

Buku Ajar

ETIK DAN HUKUM KEPERAWATAN

Raden Siti Maryam • Djusmadi Rasyid • Khotibul Umam
Aemilianus Mau • Wahyu Endang Setyowati

Editor : Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph



Buku Ajar : Etik dan Hukum Keperawatan

Penulis:

Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom.

Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes.

Dr. Khotibul Umam, S.Kep.Ns., M.Kes.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Wahyu Endang Setyowati, SKM., M.Kep.

Editor :

Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph

Buku Ajar:

Etik dan Hukum Keperawatan

Penulis:

Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom.

Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes.

Dr. Khotibul Umam, S.Kep.Ns., M.Kes.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Wahyu Endang Setyowati, SKM., M.Kep.

Editor : Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep. Kom., Ph

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-31-6

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar *Etik dan Hukum Keperawatan* ini dapat disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami pentingnya aspek etik dan hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar sekaligus aplikatif mengenai nilai, moral, prinsip etik, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum yang harus dipahami oleh calon perawat maupun perawat profesional.

Dalam praktik keperawatan, seorang perawat tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga harus mampu bersikap profesional, bertanggung jawab, serta mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prinsip etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelayanan keperawatan selalu berhubungan langsung dengan manusia, sehingga setiap tindakan yang diberikan perlu memperhatikan keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak pasien, kerahasiaan informasi, komunikasi yang jujur, serta tanggung jawab terhadap profesi.

Buku ajar ini membahas berbagai pokok materi yang berkaitan dengan etik dan hukum keperawatan. Pembahasan diawali dengan pengantar mengenai etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, serta akuntabilitas perawat dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep nilai, moral, etika, dan teori etika sebagai dasar dalam memahami perilaku profesional perawat. Pembahasan juga dilengkapi dengan prinsip-prinsip etik keperawatan, yaitu *autonomy*, *beneficence*, *nonmaleficence*, *justice*, *veracity*, dan *fidelity*, yang menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan keperawatan.

Selain itu, buku ini juga menjelaskan hak dan kewajiban pasien serta perawat dalam pelayanan kesehatan agar mahasiswa mampu memahami hubungan profesional antara perawat, pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Materi mengenai *informed consent*, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis juga disajikan untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana prinsip etik dan hukum diterapkan dalam situasi nyata di pelayanan kesehatan.

Melalui buku ajar ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami etik dan hukum keperawatan secara menyeluruh serta mampu menerapkannya dalam pembelajaran, praktik klinik, maupun kehidupan profesional di masa depan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, diskusi kasus, dan penguatan karakter profesional mahasiswa keperawatan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat

diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan etik dan hukum dalam praktik keperawatan.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
---------------------	-----

Daftar Isi.....	v
-----------------	---

BAB 1 PENGANTAR ETIK DAN HUKUM KEPERAWATAN: PROFESIONALISME

DAN AKUNTABILITAS	1
--------------------------------	----------

A. Konsep Dasar Etik dalam Keperawatan	6
--	---

B. Konsep Dasar Hukum dalam Keperawatan	7
---	---

C. Hubungan Etik dan Hukum dalam Praktik Keperawatan	9
--	---

D. Profesionalisme Perawat	11
----------------------------------	----

E. Akuntabilitas Perawat.....	12
-------------------------------	----

F. Tantangan Etik dan Hukum bagi Perawat.....	14
---	----

G. Ringkasan.....	35
-------------------	----

Referensi	41
------------------------	-----------

BAB 2 NILAI, MORAL, ETIKA, DAN TEORI ETIKA DALAM PRAKTIK

KEPERAWATAN	44
--------------------------	-----------

A. Konsep Nilai dalam Praktik Keperawatan	49
---	----

B. Konsep Moral dalam Praktik Keperawatan.....	51
--	----

C. Konsep Etika dalam Praktik Keperawatan.....	52
--	----

D. Perbedaan Nilai, Moral, dan Etika.....	53
---	----

E. Implikasi Nilai, Moral, dan Etika terhadap Keputusan Klinis	54
--	----

F. Teori Etika dalam Praktik Keperawatan.....	55
---	----

G. Penggunaan Teori Etik dalam Menilai Pilihan Tindakan.....	59
--	----

H. Contoh Analisis Kasus Sederhana	60
--	----

I. Penutup	61
------------------	----

J. Latihan Soal.....	74
----------------------	----

K. RINGKASAN	75
--------------------	----

Referensi	77
------------------------	-----------

BAB 3 PRINSIP ETIK KEPERAWATAN: AUTONOMY, BENEFICENCE, NONMALEFICENCE, JUSTICE, VERACITY, FIDELITY	78
A. Pendahuluan.....	82
B. Konsep Etik Keperawatan.....	82
C. Prinsip-Prinsip Etik Keperawatan.....	83
D. Dilema Etik dan Pengambilan Keputusan.....	86
E. Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Etis.....	88
F. Penegakan Etik dan Disiplin.....	88
G. Peran Stakeholder Dalam Pencegahan Pelanggaran Etik	89
Referensi	94
 BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SERTA PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN	95
A. Terminologi.....	98
B. Hak dan Kewajiban Pasien.....	99
C. Hak dan Kewajiban Perawat.....	101
D. RINGKASAN	106
Referensi	110
 BAB 5 INFORMED CONSENT, PENOLAKAN, TINDAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KLINIS	112
A. Pendahuluan.....	115
B. Konsep Dasar Informed Consent	117
C. Bentuk dan Prosedur Informed Consent.....	121
D. Penolakan Tindakan Medis dan Keperawatan	123
E. Pengambilan Keputusan Klinis dalam Keperawatan	126
F. Dilema Etik dalam Informed Consent dan Penolakan Tindakan	130
Referensi	138
 Profil Penulis.....	141

BAB 1

PENGANTAR ETIK DAN HUKUM KEPERAWATAN: PROFESIONALISME DAN AKUNTABILITAS

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik-hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Etik dan Hukum Keperawatan: Profesionalisme dan Akuntabilitas	1.1 Mengidentifikasi bentuk akuntabilitas profesional dan batas kewenangan praktik pada skenario pelayanan.	1.2 Menentukan tindakan profesional saat terjadi dilema tanggung jawab (escalation, konsultasi, dokumentasi) secara tepat.	CPMK-1	CPMK-5; CPMK-7

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep teori/prinsip/kode etik dan ketepatan mengaitkan standar pada vignette.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-5	Penilaian dokumentasi (audit catatan) + rubrik	Skor kelengkapan legal dokumentasi (kronologi, objektivitas, koreksi benar) dan konsistensi bukti pendukung.	15	Sampel dokumentasi; lembar audit
CPMK-7	Proyek studi kasus + etik penelitian (review protokol)	Skor kualitas rekomendasi kasus (argumentasi, opsi, tindak lanjut) dan kepatuhan komponen perlindungan subjek (rubrik).	15	Laporan proyek; lembar review etik

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik-hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
etik/standar pada vignette				konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

Kata Kunci

Etik keperawatan, hukum keperawatan, profesionalisme perawat, akuntabilitas perawat, kode etik, kewenangan perawat, SOP keperawatan, keselamatan pasien, tanggung jawab profesional, praktik keperawatan bermutu.

Pendahuluan

Perawat merupakan tenaga kesehatan vokasional dan atau profesional yang memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan dasar yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Dalam praktik sehari-hari, perawat berada pada garis terdepan pelayanan, berinteraksi langsung dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Kondisi ini menempatkan perawat tidak hanya sebagai pelaksana tindakan keperawatan, tetapi juga sebagai subjek moral dan hukum yang bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan profesional yang diambil.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, kemajuan teknologi medis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien, praktik keperawatan dituntut untuk berlandaskan prinsip etik dan hukum yang kuat. Etik keperawatan memberikan kerangka nilai dan norma moral yang membimbing perawat dalam bertindak secara benar, adil, dan berperikemanusiaan, sementara hukum kesehatan berfungsi sebagai sistem aturan formal yang mengatur batas kewenangan, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi perawat dan pasien. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik keperawatan profesional (Butts & Rich, 2022; Cummins et al., 2023).

Bab ini dirancang sebagai pengantar untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap dasar-dasar etik dan hukum keperawatan secara sederhana, kontekstual, dan aplikatif. Pembahasan diawali dengan pengertian etik, moral, dan hukum dalam konteks keperawatan, dilanjutkan dengan hubungan antara etik dan hukum dalam praktik klinik, serta implikasinya terhadap perilaku profesional perawat. Penekanan diberikan pada nilai-nilai inti profesi keperawatan, seperti tanggung jawab, akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap standar praktik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, bab ini mengaitkan konsep etik dan hukum dengan profesionalisme perawat sebagai tenaga kesehatan vokasional dan atau profesional. Profesionalisme tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai komitmen untuk bertindak sesuai kode etik, standar operasional prosedur, dan ketentuan hukum dalam setiap asuhan keperawatan. Akuntabilitas menjadi aspek kunci, di mana perawat dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakan keperawatan secara etik, hukum, dan administratif, baik kepada pasien, institusi pelayanan kesehatan, maupun kepada profesi (Mia Svantesson et al., 2017; Logsdon et al., 2020)

Melalui pembahasan dalam bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki landasan awal untuk memahami bahwa pelanggaran etik dan hukum tidak hanya berdampak

pada pasien, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, disiplin profesi, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Oleh karena itu, pemahaman sejak dini mengenai etik dan hukum keperawatan menjadi bekal penting bagi mahasiswa Keperawatan dalam membentuk sikap profesional, berpikir kritis, dan bertindak bertanggung jawab dalam praktik klinik maupun kehidupan profesional di masa depan.

A. Konsep Dasar Etik dalam Keperawatan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Etik

Etik merupakan kerangka nilai, prinsip, dan norma moral yang digunakan untuk mengevaluasi dan membimbing tindakan manusia mengenai apa yang dianggap baik, benar, adil, dan bermartabat dalam konteks sosial tertentu (Association, 2001). Dalam disiplin keperawatan, etik bukan sekadar aturan normatif, tetapi fondasi fundamental yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku profesional perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan komunitas. Etik membantu perawat memutuskan tindakan yang tepat ketika menghadapi dilema moral atau konflik nilai yang kompleks dalam praktik klinik.

2. Etik sebagai cabang filsafat moral

Secara konseptual, etik keperawatan mencakup serangkaian prinsip moral yang terinternalisasi dalam karakter dan perilaku profesional perawat. Prinsip utama tersebut antara lain penghormatan terhadap martabat manusia, beneficence (kebaikan/kebermanfaatan), non-maleficence (tidak mencederai), keadilan, dan otonomi pasien (Grace & Uveges, 2022). Prinsip-prinsip ini diaktualisasikan melalui kode etik profesi yang dirumuskan oleh organisasi keperawatan nasional maupun internasional, sebagai pedoman etis yang bersifat normatif dan aplikatif di berbagai konteks pelayanan kesehatan.

3. Etik keperawatan sebagai pedoman perilaku profesional

Dalam praktik keperawatan, penerapan etik bukan hanya bersifat teoritis, tetapi nyata dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan perawat. Misalnya, menghormati hak otonomi pasien berarti perawat memastikan pasien mendapatkan informasi yang relevan, dimengerti, dan bebas memilih keputusan terkait asuhan keperawatan, kecuali dalam kondisi darurat medis yang mendesak (Kang & Jeong, 2020a). Selain itu, menjaga kerahasiaan dan privasi pasien merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat dan privasi individu yang telah diakui sebagai hak fundamental dalam etika kesehatan (Johnston & Juengst, 2018a).

Etik keperawatan juga menuntut perawat untuk bersikap empatik, menghargai perbedaan budaya, sosial, dan nilai-nilai personal pasien, serta berkomunikasi secara menghormati dan terbuka. Dalam situasi di mana terjadi konflik antara kebutuhan pasien dan kebijakan institusi, perawat harus mampu mengambil keputusan yang beretika dengan mengutamakan keselamatan dan hak pasien tanpa mengabaikan tuntutan profesionalisme (Lachman, 2012). Kemampuan ini memerlukan refleksi etis yang berkelanjutan, kemampuan analisis dilema moral, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan praktik keperawatan yang aman dan beretika.

Bagi perawat, pemahaman etik merupakan kompetensi integral yang harus dikembangkan sejak masa pendidikan. Hal ini karena praktik profesional keperawatan sering kali melibatkan situasi yang memerlukan evaluasi terhadap nilai-nilai moral, pertimbangan konsekuensi, serta sikap mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil. Pemahaman dan internalisasi etik membantu perawat bertindak dengan teladan moral, menjaga kepercayaan publik terhadap profesi, dan memastikan praktik keperawatan yang humanistik, hormat, adil, dan bermartabat dalam setiap situasi pelayanan kesehatan (Mia Svantesson et al., 2017)

B. Konsep Dasar Hukum dalam Keperawatan

1. Pengertian hukum dan hukum kesehatan

Hukum merupakan sekumpulan aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, bersifat mengikat secara sosial dan legal, serta dapat dipaksakan melalui sanksi formal apabila dilanggar. Dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, termasuk praktik keperawatan, hukum berperan sebagai sistem aturan yang memberikan pedoman normatif bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kerangka hukum ini menetapkan ruang lingkup kewenangan profesi, membatasi tindakan yang dapat dilakukan, serta mengatur tanggung jawab dan akuntabilitas tenaga kesehatan. Selain itu, hukum juga berfungsi melindungi hak dan kepentingan pasien maupun tenaga kesehatan, sehingga hubungan profesional dalam pelayanan kesehatan berlangsung secara aman, adil, dan berlandaskan kepastian hukum (Ventura et al., 2021).

Hukum dalam praktik keperawatan memiliki peran yang strategis untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan berada dalam koridor legal yang jelas dan sah. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan, standar profesi, serta kebijakan institusional yang beragam, mulai dari undang-undang

kesehatan, regulasi praktik keperawatan, hingga aturan pelaporan dan dokumentasi medis. Tujuan utama hukum keperawatan adalah melindungi pasien dari malpraktik, menjamin keselamatan dan hak-hak pasien, serta memberikan kepastian hukum bagi perawat dalam melaksanakan tugas profesinya (Forde et al., 2018).

2. Hubungan hukum dengan praktik keperawatan

Pemahaman hukum bagi perawat menjadi aspek fundamental yang tidak hanya memperkuat aspek teknis praktik, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berimplikasi terhadap tuntutan hukum, sanksi administratif, ataupun konsekuensi etis dan profesional. Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai kewenangan profesional, batasan tindakan sesuai kompetensi, serta hak dan kewajiban perawat dan pasien. Misalnya, Dalam praktik keperawatan, perawat diwajibkan melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan batas kewenangan dan ruang lingkup praktik yang telah ditetapkan oleh regulasi profesi. Apabila suatu tindakan berada di luar kompetensi atau otoritasnya, perawat harus melaksanakannya berdasarkan perintah atau kolaborasi dengan dokter. Seluruh tindakan tersebut wajib dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku guna menjamin keselamatan pasien serta kepastian hukum bagi tenaga keperawatan (Tingle & McHale, 2009).

3. Fungsi hukum dalam pelayanan kesehatan

Salah satu aspek paling krusial dalam hukum keperawatan adalah dokumentasi asuhan keperawatan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dokumentasi yang baik tidak hanya menjadi alat komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat dipergunakan dalam proses audit, investigasi kejadian keselamatan pasien, atau apabila terjadi tuntutan hukum (Georgiou, 2021). Ketidakpatuhan terhadap dokumentasi yang benar dapat berujung pada kerugian pasien, hilangnya kredibilitas profesional, dan potensi litigasi terhadap perawat dan institusi pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, hukum keperawatan juga meliputi aturan tentang informed consent, kerahasiaan pasien, perlindungan data kesehatan, dan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu. Perawat berkewajiban untuk memahami dan menerapkan hukum ini secara konsisten dalam praktik klinik. Ketika perawat memahami batasan-batasan hukum, mereka dapat membuat keputusan klinis yang tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga terlindungi secara legal. Dengan demikian, aspek hukum dalam keperawatan tidak hanya membantu meminimalkan risiko praktik yang salah, tetapi juga memperkuat

profesionalisme perawat sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dan akuntabel (Fond et al., 2022a).

Pemahaman hukum yang solid membantu perawat D3 bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki, melaksanakan tindakan berdasarkan instruksi yang sah, serta menjamin praktik keperawatan yang bertanggung jawab secara legal dan moral. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membentuk praktik keperawatan yang aman, etis, legal, dan profesional di setiap aspek pelayanan kesehatan.

C. Hubungan Etik dan Hukum dalam Praktik Keperawatan

1. Etik sebagai pedoman moral praktik keperawatan

Etik dan hukum merupakan dua konsep yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam praktik keperawatan. Etika bersumber dari nilai-nilai dan prinsip moral yang menjadi landasan dalam mengarahkan sikap dan tindakan profesional. Prinsip-prinsip ini membimbing tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam menentukan perilaku yang patut dan bertanggung jawab, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil mencerminkan upaya untuk mewujudkan kebaikan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab moral terhadap pasien, rekan sejawat, dan masyarakat secara luas (Arries, 2020). Di sisi lain, Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang serta memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Aturan-aturan tersebut berfungsi mengatur dan membatasi perilaku individu atau kelompok dengan menetapkan tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Selain itu, hukum juga mengatur sanksi atau konsekuensi hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan (Wenli, 2019)

Keduanya berinteraksi secara dinamis dalam setiap aspek praktik keperawatan. Etik berfungsi sebagai nilai dasar yang membentuk struktur hukum kesehatan, sedangkan hukum mencerminkan dan menguatkan nilai-nilai etik dalam bentuk aturan yang dapat dipaksakan. Dalam konteks klinik, hal ini berarti bahwa norma-norma etik sering kali menjadi inspirasi atau dasar pembentukan hukum kesehatan formal, seperti hak pasien untuk memperoleh informed consent, prinsip kerahasiaan data kesehatan, dan kewajiban untuk memberikan asuhan yang aman dan bermutu ((Johnston & Juengst, 2018b; Kang & Jeong, 2020b). Dengan demikian, etik dan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan dalam menjamin praktik keperawatan yang aman, bermartabat, dan bertanggung jawab.

2. Hukum sebagai regulasi dan perlindungan praktik

Dalam praktik keperawatan sehari-hari, perawat dituntut untuk memahami dan mematuhi keduanya secara simultan. Misalnya, menjaga privasi pasien bukan hanya menjadi kewajiban moral berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat individu, tetapi juga kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perlindungan data kesehatan. Ketidaktepatan dalam menjaga kerahasiaan dapat menyebabkan dampak negatif bagi pasien, seperti stigma sosial, kerugian psikologis, dan pelanggaran hak individu, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi perawat dan institusi (Fond et al., 2022b). Contoh lain adalah informed consent, di mana etik menuntut agar pasien memperoleh kejelasan informasi sebelum mengambil keputusan, sementara hukum mensyaratkan bukti tertulis persetujuan pasien sebagai bentuk perlindungan hukum atas tindakan medis yang dilakukan.

Perawat juga sering menghadapi situasi di mana tuntutan etik dan tuntutan hukum harus diintegrasikan secara tepat. Misalnya, ketika ada konflik antara kewajiban etik untuk melakukan tindakan yang terbaik bagi pasien dengan pembatasan hukum yang mengatur ruang lingkup praktik. Dalam situasi seperti itu, perawat harus menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan refleksi etis untuk menyeimbangkan nilai-nilai moral dengan kewajiban hukum, serta berkoordinasi dengan tim layanan kesehatan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan standar profesional, etik, dan legal (Logsdon et al., 2020).

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban etik dan hukum dalam praktik keperawatan dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik terhadap pasien, profesional perawat, maupun institusi pelayanan kesehatan. Pelanggaran etik dapat mengurangi kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap profesi, sementara pelanggaran hukum dapat berujung pada sanksi administratif, pidana, atau tuntutan perdata. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara etik dan hukum serta implementasinya dalam praktik merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki sejak masa pendidikan keperawatan (Mia Svantesson et al., 2017).

Secara keseluruhan, integrasi etik dan hukum dalam praktik keperawatan membentuk landasan bagi perilaku profesional yang bertanggung jawab, akuntabel, dan berfokus pada keselamatan serta hak-hak pasien. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan perawat untuk bertindak tidak hanya secara legal, tetapi juga secara etis dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam konteks klinik.

D. Profesionalisme Perawat

1. Pengertian profesionalisme perawat

Profesionalisme perawat mencerminkan kualitas perilaku, sikap, dan nilai yang diinternalisasi dalam praktik keperawatan sehari-hari. Profesionalisme bukan sekadar penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup komitmen terhadap disiplin, tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan profesi serta sistem pelayanan kesehatan yang berlaku (Mengelers et al., 2019). Perawat profesional memperlihatkan usaha yang konsisten dalam memberikan asuhan yang aman, bermutu, efektif, serta berorientasi pada hak dan martabat pasien.

Inti dari profesionalisme perawat adalah kesadaran dan penerapan nilai-nilai etik dan hukum dalam setiap tindakan klinik. Perawat yang menjalankan praktik secara profesional melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya. Setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan keperawatan didasarkan pada bukti ilmiah terkini, standar praktik keperawatan, serta pedoman dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh institusi pelayanan kesehatan, dengan tujuan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Melnyk et al., 2014). Hal ini mencakup kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri, meminta supervisi bila diperlukan, dan merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang lebih kompeten ketika situasi melebihi ruang lingkup kompetensi sendiri.

2. Karakteristik profesi keperawatan

Selain keterampilan teknis, profesionalisme perawat juga terekspresikan melalui sikap menghormati hak individu pasien, menghargai nilai budaya, serta menjunjung tinggi kerahasiaan dan privasi pasien. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, perawat dituntut untuk menunjukkan sikap profesional yang ditandai dengan perilaku santun, empati, dan kepekaan terhadap kebutuhan emosional serta psikososial pasien dan keluarganya. Selain itu, perawat harus mampu membangun komunikasi yang efektif, jelas, dan berlandaskan prinsip etika dalam setiap interaksi klinis, guna menciptakan hubungan terapeutik yang mendukung proses perawatan dan kesejahteraan pasien (Wanko Keutchafo et al., 2022). Kemampuan komunikasi profesional bukan hanya memengaruhi kualitas asuhan, tetapi juga memperkuat hubungan terapeutik yang mendukung keselamatan dan kepuasan pasien.

3. Standar profesi dan kode etik perawat

Profesionalisme juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap kode etik profesi dan aturan hukum yang mengatur praktik keperawatan. Perawat yang

profesional memahami bahwa ketaatan terhadap kode etik dan hukum tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga melindungi dirinya sebagai praktisi dari konsekuensi legal dan disipliner (Logsdon et al., 2020). Kepatuhan ini tercermin dalam praktik yang akurat, dokumentasi yang benar, serta perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan legal.

Komponen penting lain dalam profesionalisme perawat adalah akuntabilitas yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada pasien, rekan kerja, supervisor, serta sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas. Akuntabilitas dalam praktik profesional tercermin dari kesiapan individu untuk terbuka terhadap umpan balik, melakukan refleksi kritis atas kinerja yang telah dijalankan, serta berkomitmen melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan apabila ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam praktik. Sikap ini menjadi dasar penting dalam menjaga mutu pelayanan dan tanggung jawab profesional (Guler et al., 2018). Mahasiswa yang dibekali profesionalisme akan mampu menavigasi tantangan klinik secara bertanggung jawab, berfokus pada keselamatan pasien dan keberlanjutan praktik yang etis.

Bagi perawat, membangun profesionalisme sejak tahap pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam pengembangan karier dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Profesionalisme yang kuat akan menciptakan kultur kerja yang positif, mengurangi risiko kesalahan praktik, serta memupuk citra profesi yang dihormati dan diteladani (Mengelers et al., 2019). Dengan demikian, profesionalisme bukan hanya aspek teknis dan perilaku individual, tetapi juga cerminan komitmen kolektif terhadap mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.

E. Akuntabilitas Perawat

1. Pengertian akuntabilitas perawat

Akuntabilitas dalam keperawatan merujuk pada tanggung jawab profesional yang melekat pada setiap tindakan, keputusan, dan perawatan yang diberikan oleh perawat. Konsep ini tidak hanya mencakup pelaksanaan tugas sesuai instruksi, namun juga kemampuan perawat untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk pasien, atasan, tim kesehatan, dan institusi pelayanan kesehatan. Akuntabilitas merupakan fondasi moral dan profesional yang menegaskan bahwa perawat tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga komitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam konteks etik dan legal praktik keperawatan (American Nurses Association (ANA), 2025).

2. Akuntabilitas dan praktik keperawatan profesional

Dalam praktik keperawatan, akuntabilitas ditunjukkan melalui beberapa perilaku konkret yang terukur. Perawat harus melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ruang lingkup kompetensi profesionalnya. Hal ini mencakup mengikutsertakan pengetahuan ilmiah terbaru, keterampilan klinik yang tepat, serta prinsip keselamatan pasien dalam setiap tahap proses keperawatan. Misalnya, akuntabilitas tercermin saat perawat memastikan pemberian obat yang benar, melakukan observasi secara sistematis, serta mengambil tindakan yang sesuai pada keadaan kritis tanpa menunda keputusan penting demi keselamatan pasien (Luggar-Schmit, 2024).

Lebih lanjut, akuntabilitas juga diwujudkan melalui pencatatan dan dokumentasi asuhan keperawatan yang benar dan lengkap. Dokumentasi yang akurat menjadi bukti tertulis bahwa tindakan keperawatan telah dilakukan secara profesional, aman, dan sesuai standar. Hal ini sangat penting karena dokumentasi berfungsi sebagai alat komunikasi antarprofesional, dukungan bukti dalam audit klinis, serta bukti pertanggungjawaban dalam investigasi manajemen risiko atau kasus hukum kesehatan. Ketidakpatuhan terhadap dokumentasi yang baik dapat membuka celah kesalahan diagnosis dan merugikan pasien serta institusi, sehingga memperlemah akuntabilitas profesional (American Nurses Association (ANA), 2025).

Aspek lain dari akuntabilitas adalah kesediaan menerima evaluasi, supervisi, dan refleksi profesional. Perawat profesional tidak hanya bertindak secara individu, tetapi juga bersedia mengakui kekurangan, menerima umpan balik dari atasan atau kolega, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Inilah yang disebut sebagai akuntabilitas reflektif—sikap terbuka terhadap pembelajaran dan peningkatan mutu praktik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan secara keseluruhan (American Nurses Association (ANA), 2025).

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan *just culture*, yaitu budaya profesional yang menyeimbangkan antara tanggung jawab individu dan dukungan sistem dalam menghadapi kesalahan yang terjadi. Budaya ini mendorong perawat untuk melaporkan kesalahan tanpa rasa takut akan hukuman yang tidak proporsional, sehingga memfasilitasi pembelajaran organisasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Pendekatan ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya soal kesalahan, tetapi juga tentang

promosi keselamatan pasien dan perbaikan kualitas berkelanjutan (American Nurses Association (ANA), 2025).

Bagi perawat, pengembangan sikap akuntabilitas adalah bagian penting dari pembentukan profesionalisme klinik. Sikap ini membantu perawat bertindak secara etis, tepat secara klinis, dan bertanggung jawab secara legal, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Dengan akuntabilitas yang kuat, perawat dapat meningkatkan mutu pelayanan, mengurangi insiden negatif, serta menjamin keselamatan pasien sebagai inti praktik keperawatan yang bertanggung jawab dan bermutu tinggi (American Nurses Association (ANA), 2025).

F. Tantangan Etik dan Hukum bagi Perawat

1. Kompleksitas pelayanan kesehatan modern

Dalam praktik keperawatan yang dinamis dan penuh tuntutan, perawat sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat etik maupun hukum. Tantangan ini muncul karena kompleksitas kondisi pasien, keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, serta situasi klinis yang tidak selalu linear. Kondisi ini menuntut kemampuan profesional untuk menavigasi keputusan sulit yang melibatkan nilai moral dan ketentuan hukum untuk memastikan keselamatan pasien dan mempertahankan integritas profesi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perawat adalah workload tinggi dan keterbatasan waktu, yang merupakan faktor stressor signifikan dalam praktik klinik. Beban kerja yang berat dapat mengurangi kemampuan perawat untuk menganalisis kebutuhan pasien secara menyeluruh, memperhatikan detail dalam dokumentasi asuhan, dan berkomunikasi secara efektif, sehingga berpotensi menyebabkan pelanggaran etik atau kesalahan praktik yang berimplikasi hukum (Waterfield & Barnason, 2022). Tantangan ini tidak hanya berdampak pada keselamatan pasien, tetapi juga menimbulkan moral distress ketika perawat merasa sulit untuk memenuhi standar profesional karena keterbatasan sumber daya dan tekanan organisasi.

2. Dilema etik dan resiko hukum dalam praktik keperawatan

Selain itu, situasi klinis yang kompleks seperti kasus pasien dengan banyak penyakit menyertai (*multimorbidities*), gangguan kognitif, atau pada fase akhir kehidupan, menimbulkan dilema etis yang rumit. Misalnya, menjaga otonomi pasien yang memiliki gangguan kognitif sering kali bertentangan dengan kewajiban hukum untuk melindungi keselamatan pasien, khususnya ketika persetujuan tindakan klinik tidak selalu mudah diperoleh (Alodhialah et al., 2024).

Dilema seperti ini membutuhkan kemampuan perawat untuk membuat keputusan yang seimbang antara prinsip etik (seperti otonomi dan kasih sayang) dan standar hukum seperti *informed consent*.

Tantangan lain berkaitan dengan ketidakjelasan ruang lingkup praktik dan tanggung jawab hukum. Perawat dengan kompetensi vokasional dan atau profesional, harus memastikan bahwa setiap tindakan klinik berada dalam batas kompetensi yang ditetapkan. Melakukan tindakan di luar ruang lingkup tersebut misalnya prosedur yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan lain atau tanpa supervise dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti tuntutan malpraktik atau sanksi profesional ((Dupuis, 2025). Ketidakpastian seperti ini sering menjadi sumber kecemasan profesional, terutama ketika perawat tidak memiliki dukungan hukum yang memadai dari institusi.

Dalam konteks teknologi medis dan digitalisasi data pasien, perawat juga menghadapi tantangan baru terkait privasi dan keamanan data. Penggunaan sistem elektronik kesehatan dan telemedicine membuka peluang untuk efisiensi pelayanan, tetapi juga memperbesar risiko pelanggaran hukum apabila data pasien tidak dilindungi secara tepat. Tantangan ini membutuhkan pemahaman hukum tentang perlindungan data serta kemampuan menjaga kerahasiaan informasi yang sesuai dengan standar legal dan etika (Kasenda & Mambu, 2025).

Selain faktor-faktor di atas, perawat sering mengalami tekanan moral akibat perbedaan nilai antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Konflik antara harapan keluarga dan keinginan pasien, atau kebutuhan untuk melakukan intervensi medis yang kontroversial, dapat menimbulkan beban psikologis dan dilema moral yang berkepanjangan. Ketika dilema tersebut tidak dikelola dengan baik, perawat dapat mengalami moral distress, yang pada tingkat ekstrem dapat berkontribusi pada burnout dan penurunan kualitas pelayanan (Haryati et al., n.d. 2025)

Karena tantangan etik dan hukum ini sering bersifat kompleks dan kontekstual, pemahaman yang mendalam sejak masa pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan yang kuat tentang prinsip-prinsip etik, hukum kesehatan, serta strategi pengambilan keputusan dapat membekali perawat untuk menghadapi situasi ini dengan keterampilan analitis, pemikiran kritis, serta kesadaran profesional yang tinggi. Dengan demikian, perawat dapat bekerja secara aman, mempertahankan kualitas praktik, dan memastikan akuntabilitas dalam kerangka hukum yang berlaku.

Deskripsi Kasus (Minicase)

Seorang pasien Wanita 51 Tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan kondisi Diare. Saat perawat akan melakukan tindakan keperawatan, memasang infus, terdapat beberapa mahasiswa praktik di dalam ruangan. Pada saat yang sama, seorang pengunjung pasien lain berada cukup dekat sehingga berpotensi mendengar percakapan antara perawat dan pasien.

Ketika perawat mulai menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, pasien tampak ragu dan menunjukkan kecemasan. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung privasi ini menimbulkan dilema bagi perawat, karena tindakan keperawatan tetap harus dilakukan sesuai standar pelayanan.

Sebagai perawat pelaksana, Anda diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional dengan tetap menjaga privasi pasien, menerapkan prinsip etik, mematuhi aspek hukum, serta menunjukkan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Tugas Mahasiswa

Berdasarkan kasus di atas, lakukan:

1. Identifikasi minimal dua masalah etik dan satu masalah hukum.
2. Jelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan perawat dalam situasi tersebut.
3. Uraikan bagaimana perawat menunjukkan profesionalisme dalam interaksi dengan pasien.
4. Jelaskan bentuk akuntabilitas perawat dalam kasus ini.

Diskusi Kelompok (Small Group Discussion). Diskusikan dalam kelompok (4–5 orang) dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Soal OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Etik dan Hukum Keperawatan
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, khususnya dalam menjaga privasi dan komunikasi terapeutik dengan pasien.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Anda adalah seorang perawat yang akan melakukan tindakan keperawatan pemasangan infus pada pasien Wanita 51 tahun, di ruang rawat inap dengan kondisi Diare. Saat akan memulai tindakan, terdapat orang lain di sekitar pasien (mahasiswa/keluarga pasien lain) yang berpotensi mengganggu privasi. TUGAS : 1. Pendekatan kepada pasien secara profesional.

No.	Komponen	Isi
		2. Penjelasan tindakan yang akan dilakukan (<i>informed consent sederhana</i>). 3. Upaya menjaga privasi dan kenyamanan pasien. 4. Komunikasi terapeutik yang sesuai.
8	Instruksi untuk pengujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perawat yang akan melakukan tindakan keperawatan pemasangan infus pada pasien Wanita 51 tahun, di ruang rawat inap dengan kondisi Diare. Saat akan memulai tindakan, terdapat orang lain di sekitar pasien (mahasiswa/keluarga pasien lain) yang berpotensi mengganggu privasi. TUGAS: 1. Pendekatan kepada pasien secara profesional. 2. Penjelasan tindakan yang akan dilakukan (<i>informed consent sederhana</i>). 3. Upaya menjaga privasi dan kenyamanan pasien. 4. Komunikasi terapeutik yang sesuai. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Amati dan nilai kemampuan peserta berdasarkan aspek Komunikasi terapeutik 2. Amati dan nilai kemampuan peserta berdasarkan aspek Penerapan prinsip etik (privasi, otonomi) 3. Amati dan nilai kemampuan peserta berdasarkan aspek Kepatuhan terhadap aspek hukum (kerahasiaan, persetujuan tindakan) 4. Amati dan nilai kemampuan peserta berdasarkan aspek Profesionalisme dan sikap 5. Amati dan nilai kemampuan peserta berdasarkan aspek Akuntabilitas Tindakan
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: Wanita dewasa 51 tahun. 2. Riwayat penyakit sekarang: pasien diare. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama.

No.	Komponen	Isi
		5. Riwayat kebiasaan sosial: pasien tampak cemas, dan tidak nyaman dengan lingkungan rumah sakit. 6. Harapan terhadap penyakit: pasien berharap anak segera membaik, seperti biasa. 7. Bila peserta menanyakan BAK, jawaban pasien: sejak pagi baru BAK 2 kali dan jumlahnya sedikit. 8. Bila peserta menanyakan asupan makan dan minum, jawaban pasien : kurang napsu makan, minum sedikit-sedikit, khawatir bertambah BAB, 9. Pasien posisi terlentang dengan raut wajah cemas, meringis. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Penyakit Dalam ▪ Tempat tidur pasien ▪ Pasien standar ▪ Penguji ▪ Laboran Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Pintu masuk 5. Troli alat 6. Wastafel/handrub 1. 7. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Cairan Infus: Sesuai kebutuhan, 2. Infus Set: Makro drip, 3. Kanul Intravena/Abocath: Ukuran sesuai kebutuhan, 4. Turniket: Pembendung vena, 5. Alkohol Swab/Antiseptik, 6. Kasa Steril & Plester/Transparan Dressing, 7. Perlak/Alas & Bengkok (Nierbekken), 8. Sarung Tangan Bersih: (Handscoon), dan 9. Tiang Infus: Untuk menggantung cairan 10. Lembar jawaban peserta Laboran ada.

No.	Komponen	Isi
		Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Djusmadi Rasyid
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: pemasangan infus				
3	Mencuci tangan, pasang sarung tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir/umur secara aktif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
C	Tahap Kerja (fokus penilaian)				
9	Memastikan pemahaman pasien				
10	Meminta persetujuan pasien (informed consent sederhana)				
11	Mengidentifikasi gangguan privasi di lingkungan				
12	Mengupayakan menjaga privasi (misalnya menutup tirai/meminta orang lain menjauh)				
13	Menggunakan komunikasi terapeutik (empati, kontak mata, bahasa sopan)				
	Tahap Kerja (No.14 secara sistematis)				
14	1) Hubungkan cairan infus dengan infus set, gantung, dan alirkan cairan untuk membuang udara (priming). 2) Pilih vena yang lurus dan besar (utamakan tangan non-dominan), pasang perlat di bawahnya. 3) Pasang torniket 15-20 cm di atas lokasi penusukan. 4) Desinfeksi area penusukan menggunakan alkohol swab dengan teknik sirkuler (dari dalam ke luar).				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	5) Tusukkan kanula/abocath dengan bevel (ujung tajam) menghadap ke atas dengan sudut 6) Cek Darah: Jika darah terlihat pada indikator kanula, tarik jarum sedikit (stylet) sambil mendorong kateter plastik ke dalam vena. 7) Lepas torniket, tekan vena di ujung kateter agar darah tidak keluar, lalu cabut jarum sepenuhnya. 8) Sambungkan kateter dengan selang infus, pastikan cairan mengalir lancar. 9) Lakukan fiksasi dengan plester atau transparan dressing. 10) Atur kecepatan tetesan sesuai kebutuhan 11) Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 12) Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
15	Menyimpulkan kegiatan				
16	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
17	Memberikan reinforcement positif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
18	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
E	Tahap Dokumentasi				
19	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil kegiatan dalam menerapkan prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, khususnya dalam menjaga privasi dan komunikasi terapeutik dengan pasien, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
20	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: Etik dan Hukum Keperawatan

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengidentifikasi ketidaksiapan, pasien tampak ragu dan menunjukkan kecemasan, Kondisi lingkungan yang kurang mendukung privasi.					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: terkait etik dan hukum kesehatan	Menerapkan prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, khususnya dalam menjaga privasi					5	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		dan komunikasi terapeutik dengan pasien						
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: Etik dan Hukum Keperawatan

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1. Pengkajian Keperawatan, Aspek ini menilai kemampuan mengidentifikasi ketidaksiapan, pasien tampak ragu dan menunjukkan kecemasan, Kondisi lingkungan yang kurang mendukung privasi. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik, serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi Keperawatan, Aspek ini menilai kemampuan peserta menerapkan prinsip etik, hukum,					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, khususnya dalam menjaga privasi dan komunikasi terapeutik dengan pasien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
4. Perilaku Profesional, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik, menjaga kenyamanan dan keamanan, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.				2		

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi masalah secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti ketidaksiapan, pasien, tampak ragu dan kecemasan, tetapi masih ada data penting yang terlewat	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi mengidentifikasi ketidaksiapan, keraguan dan kecemasan, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung privasi, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			atau interpretasi belum lengkap.	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak menerapkan prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, khususnya dalam menjaga privasi dan komunikasi terapeutik dengan pasien, atau tindakan yang dilakukan	Menerapkan prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Menerapkan, prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, khususnya dalam menjaga privasi dan komunikasi terapeutik dengan cukup baik, sebagian	Menerapkan, prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan, khususnya dalam menjaga privasi dan komunikasi terapeutik dengan secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.		besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	penjelasan tujuan, serta verifikasi pemahaman pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{20} \times 100 =$

20

(Kota),

Penguji :

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata atau simulasi. Pada konteks Bab ini, DOPS difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan tindakan keperawatan sederhana dengan tetap mengintegrasikan prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas.

DOPS menilai tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga aspek komunikasi, sikap profesional, serta kepatuhan terhadap standar prosedur dan regulasi hukum yang berlaku.

Instruksi Pelaksanaan

Untuk Mahasiswa:

- Lakukan prosedur keperawatan sesuai instruksi pembimbing.
- Terapkan prinsip etik dan hukum selama tindakan.
- Komunikasikan setiap langkah kepada pasien.

Untuk Penguji/Preceptor:

- Amati secara langsung tindakan mahasiswa.
- Nilai berdasarkan checklist dan rubrik yang tersedia.
- Berikan umpan balik segera setelah tindakan selesai.

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
Metode Penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata, menggunakan instrumen terstruktur.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan tindakan pemasangan infus pada pasien wanita 51 tahun dengan diare di ruang rawat inap.
Tujuan Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik secara aman, tepat, sesuai standar, serta memperhatikan aspek etik, hukum, komunikasi, dan profesionalisme.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari keterampilan teknis pemasangan infus, tetapi juga dari kemampuannya menjaga privasi pasien, memberikan penjelasan, serta mengelola kecemasan pasien.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
Kasus Klinik (Minicase)	Kasus diambil dari situasi nyata yang mengandung tantangan klinik sekaligus aspek etik dan legal.	Seorang pasien wanita 51 tahun dirawat dengan diare. Saat akan dilakukan pemasangan infus, terdapat mahasiswa praktik dan pengunjung lain di sekitar. Pasien tampak cemas dan ragu, sementara lingkungan kurang mendukung privasi, sehingga menimbulkan dilema etik bagi perawat.
Aktivitas Mahasiswa yang Diamati	Mahasiswa melakukan seluruh rangkaian prosedur mulai dari persiapan, komunikasi, tindakan, hingga evaluasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta izin, menjelaskan prosedur infus, berupaya menjaga privasi (misalnya dengan menutup tirai atau meminta pengunjung menjauh), menenangkan pasien, kemudian melakukan pemasangan infus sesuai SOP, serta melakukan evaluasi setelah tindakan.
Aspek yang Dinilai	Meliputi keterampilan teknis, komunikasi terapeutik, penerapan prinsip etik (autonomi, beneficence, non-maleficence, justice), aspek legal, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan teknik aseptik, ketepatan pemasangan infus, kemampuan menjelaskan tindakan, menghormati privasi pasien, menjaga kerahasiaan, serta menunjukkan sikap empati dan tanggung jawab.
Fokus Observasi Pembimbing	Menilai performa mahasiswa secara holistik berdasarkan standar kompetensi klinik dan capaian pembelajaran.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengatasi situasi kurangnya privasi, mengambil keputusan etis (misalnya menunda sejenak untuk memastikan privasi), serta tetap menjalankan tindakan sesuai standar keselamatan pasien.
Umpan Balik	Diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi	Pembimbing memberikan apresiasi jika mahasiswa mampu menjaga komunikasi dan teknik dengan baik,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
	pada peningkatan kompetensi.	serta memberikan saran perbaikan seperti peningkatan inisiatif dalam menjaga privasi atau memperkuat informed consent.
Keputusan Penilaian	Menentukan tingkat kompetensi mahasiswa berdasarkan performa yang ditampilkan.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan prosedur secara aman, menjaga privasi, dan menunjukkan sikap profesional. Dinyatakan perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan, dan remedial jika belum memenuhi standar.
Makna dalam OBE (Outcome-Based Education)	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian kompetensi pada level praktik nyata (does).	Mahasiswa menunjukkan kemampuan nyata dalam mengintegrasikan keterampilan klinik, komunikasi, etik, dan hukum dalam tindakan pemasangan infus pada situasi yang kompleks.

Portofolio (Berbasis Eviden Pembelajaran Mahasiswa)

Portofolio merupakan kumpulan bukti autentik (*evidence-based learning*) yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan.

Dalam konteks Bab ini, portofolio tidak hanya berisi hasil tugas tertulis, tetapi juga refleksi diri, dokumentasi praktik, serta umpan balik dari pembimbing klinik. Portofolio berfungsi sebagai alat evaluasi berkelanjutan yang menggambarkan proses belajar mahasiswa secara holistik, mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif.

Tujuan Portofolio

1. Mendokumentasikan pencapaian kompetensi mahasiswa secara sistematis.
2. Mengembangkan kemampuan refleksi kritis terhadap praktik keperawatan.
3. Menilai integrasi pengetahuan etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas.
4. Mendorong pembelajaran mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa dengan Diare dan Isu Privasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap, berkelanjutan, dan berbasis performa nyata.	Pada kasus pasien wanita 51 tahun dengan diare, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan tindakan pemasangan infus secara aman, menjaga privasi pasien, menerapkan prinsip etik, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan keterampilan pemasangan infus, tetapi juga perkembangan kemampuan dalam komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan etik, dan pengelolaan kecemasan pasien.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bukti keterampilan terstruktur (laboratorium) dan performa nyata (klinik).	OSCE mencakup keterampilan pemasangan infus sesuai SOP, sedangkan DOPS mencatat performa mahasiswa saat menghadapi situasi nyata dengan tantangan privasi dan kecemasan pasien.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus meliputi data penting pasien, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus pasien diare dengan indikasi terapi cairan intravena, kondisi lingkungan yang kurang privat, kecemasan pasien, serta intervensi berupa edukasi, informed consent, dan pemasangan infus.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengidentifikasi risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan risiko pelanggaran privasi, kesalahan komunikasi, dan kecemasan pasien

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
		yang dapat memengaruhi keselamatan tindakan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing sebagai dasar perbaikan kompetensi.	CI menilai mahasiswa sudah baik dalam teknik aseptik dan komunikasi, namun perlu meningkatkan inisiatif dalam menjaga privasi (misalnya penggunaan tirai atau pengaturan lingkungan).
Karakteristik penilaian	Penilaian bersifat berkelanjutan, berbasis bukti, dan menekankan konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman klinik serupa yang menunjukkan konsistensi dalam menjaga privasi, keselamatan pasien, dan profesionalisme.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan mutu performa dalam berbagai situasi.	Dari hasil OSCE, DOPS, dan refleksi, mahasiswa secara konsisten mampu melakukan tindakan invasif dengan aman, komunikatif, dan etis.
Makna dalam OBE	Portofolio menjadi bukti autentik pencapaian kompetensi pada level praktik nyata (does).	Mahasiswa membuktikan kemampuan integrasi keterampilan klinik, komunikasi, etik, dan hukum dalam situasi kompleks di ruang rawat inap.

Tabel 1. 2 Case Report pada Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
Hakikat case report	Laporan sistematis tentang satu kasus klinik sebagai bukti kemampuan analisis dan dokumentasi.	Mahasiswa menyusun laporan kasus pasien wanita 51 tahun dengan diare yang membutuhkan terapi cairan intravena.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan kondisi pasien, kebutuhan cairan, serta aspek psikologis (kecemasan) dan sosial (lingkungan tidak privat).

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
Isi laporan	Identitas pasien, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi.	Data meliputi diare, risiko defisit volume cairan, kecemasan pasien, diagnosis keperawatan, intervensi pemasangan infus, edukasi, dan evaluasi respons pasien.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, logika penalaran klinik, dan relevansi intervensi.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa mengaitkan diare dengan kebutuhan cairan serta pentingnya informed consent dan privasi.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mahasiswa belajar bahwa keberhasilan tindakan tidak hanya ditentukan teknik, tetapi juga komunikasi dan etika.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori dalam analisis kasus nyata secara sistematis.	Mahasiswa mampu menyusun laporan yang mencerminkan praktik keperawatan holistik dan profesional.

Tabel 1. 3 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Pasien Dewasa dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi untuk mengenali risiko, menganalisis masalah, dan merencanakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa kondisi lingkungan yang tidak privat dapat memengaruhi keselamatan psikologis dan kualitas tindakan.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien dalam setiap tindakan.	Mahasiswa memahami bahwa kecemasan pasien dapat menghambat prosedur dan meningkatkan risiko kesalahan.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, dan tindakan pencegahan.	Fokus pada risiko pelanggaran privasi, komunikasi tidak efektif, dan ketidaknyamanan pasien.
Risiko yang diidentifikasi	Kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko meliputi kebocoran informasi, kecemasan pasien, penolakan tindakan,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus (Minicase)
		dan kesalahan prosedur akibat kondisi tidak kondusif.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk meminimalkan risiko.	Mahasiswa melakukan upaya menjaga privasi (menutup tirai, membatasi akses), memberikan edukasi yang jelas, serta memastikan persetujuan tindakan (informed consent).
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi terhadap pengalaman untuk perbaikan praktik ke depan.	Mahasiswa menyadari pentingnya menjaga privasi, komunikasi empatik, dan pengambilan keputusan etik dalam tindakan invasif.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu mengevaluasi praktiknya dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

G. Ringkasan

Etik keperawatan merupakan pedoman nilai dan prinsip moral yang mengarahkan perilaku perawat dalam praktik. Prinsip seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang berorientasi pada kepentingan terbaik pasien. Hukum kesehatan dan hukum keperawatan berfungsi mengatur praktik keperawatan melalui standar, kewenangan, serta perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Kepatuhan terhadap hukum menjadi syarat penting dalam praktik profesional yang aman.

Etik dan hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi. Etik memberikan arah moral, sedangkan hukum memberikan batasan formal. Praktik keperawatan yang ideal adalah praktik yang memenuhi kedua aspek tersebut secara seimbang. Profesionalisme tercermin dari kompetensi, sikap, integritas, serta kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi. Perawat profesional mampu memberikan pelayanan yang bermutu dengan tetap menjaga martabat pasien.

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab etik, hukum, dan profesional terhadap setiap tindakan keperawatan. Perawat harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan secara transparan dan rasional. Perkembangan teknologi, kompleksitas kasus, serta dinamika sosial budaya

memunculkan berbagai dilema etik dan risiko hukum. Hal ini menuntut kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etik-hukum yang tinggi.

Secara konseptual, hubungan antar komponen dalam Bab ini dapat dipahami sebagai berikut: Etik mengarahkan nilai dan keputusan moral, Hukum mengatur dan membatasi praktik, Profesionalisme mewujudkan praktik yang bermutu dan Akuntabilitas menjamin tanggung jawab dan transparansi. Keempat aspek ini saling terintegrasi dan menjadi dasar praktik keperawatan yang aman (*patient safety*) dan berkualitas.

Implikasi dalam Praktik Keperawatan sebagai berikut : Perawat harus selalu mempertimbangkan aspek etik dan hukum dalam setiap tindakan. Keputusan klinis tidak hanya berbasis keterampilan, tetapi juga nilai moral dan regulasi. Profesionalisme dan akuntabilitas menjadi indikator utama kualitas pelayanan keperawatan. Kesalahan dalam aspek etik dan hukum dapat berdampak serius terhadap pasien dan perawat.

Terkait Keterkaitan dengan Capaian Pembelajaran (OBE Alignment), Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa diharapkan mencapai: aspek Kognitif memahami konsep etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas, aspek Afektif menunjukkan sikap etis dan profesional dan aspek Psikomotor menerapkan prinsip etik dan hukum dalam praktik

Red Flag: Kesalahan Kritis dalam Praktik Etik dan Hukum Keperawatan

Red flag merupakan indikator kesalahan kritis yang tidak boleh terjadi dalam praktik keperawatan karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan pasien, pelanggaran etik, serta konsekuensi hukum bagi perawat. Dalam konteks pembelajaran, red flag berfungsi sebagai peringatan dini (*early warning system*) bagi mahasiswa untuk mengenali tindakan yang harus dihindari secara mutlak. Identifikasi red flag membantu mahasiswa mengembangkan kewaspadaan klinis serta meningkatkan kualitas praktik yang aman, etis, dan sesuai hukum.

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi tindakan yang termasuk pelanggaran etik dan hukum.
2. Mencegah terjadinya kesalahan kritis dalam praktik keperawatan.
3. Menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Tabel 1. 4 Red Flags & Eskalasi

Red Flags	Makna Klinis / Non-Klinis	Tindakan Eskalasi
KLINIS		
Tanda dehidrasi (mata cekung, turgor menurun, mukosa kering)	Menunjukkan defisit cairan yang memerlukan intervensi segera	Segera lakukan pemasangan infus sesuai standar, monitor intake-output
BAK sedikit atau tidak ada	Perfusi ginjal menurun, risiko gagal ginjal akut	Dokumentasikan output urin, laporkan ke dokter jika anuria berlanjut
Diare terus-menerus atau meningkat	Kehilangan cairan aktif yang belum terkontrol	Monitor frekuensi dan konsistensi diare, evaluasi efektivitas terapi
Demam	Kemungkinan infeksi sistemik atau komplikasi	Ukur suhu secara berkala, laporkan jika >38,5°C
Tanda syok (nadi cepat lemah, CRT >2 detik, ekstremitas dingin)	Kondisi gawat darurat, risiko syok hipovolemik	Eskalasi emergensi, panggil tim medis segera, siapkan resusitasi cairan
NON-KLINIS (Etik, Hukum, Profesionalisme)		

Pasien ragu dan menunjukkan kecemasan saat akan dilakukan tindakan	Belum tercapainya <i>informed consent</i> yang sah; berpotensi melanggar otonomi pasien	Hentikan sejenak tindakan, lakukan komunikasi terapeutik, berikan penjelasan ulang dengan bahasa yang mudah dipahami
Lingkungan kurang mendukung privasi (ada mahasiswa praktik dan pengunjung lain)	Berisiko melanggar kerahasiaan dan privasi pasien (UU Kesehatan & Kode Etik)	Atur ulang lingkungan: pasang sampiran, minta mahasiswa/pengunjung menunggu di luar, atau lakukan penjelasan di area lebih privat
Perawat menjelaskan tindakan di depan orang lain tanpa persetujuan pasien	Potensi pelanggaran etik dan hukum terkait <i>confidentiality</i>	Lakukan eskalasi komunikasi: minta izin pasien terlebih dahulu jika ada pihak lain yang hadir, dokumentasikan persetujuan
Mahasiswa praktik berada di ruangan saat tindakan invasif dilakukan	Risiko terhadap kenyamanan pasien dan keamanan tindakan jika tidak dikelola dengan baik	Berikan arahan kepada mahasiswa untuk menjaga jarak, tetap mengamati tetapi tidak mengganggu privasi pasien; pastikan pasien memberikan izin

Form Checklist (Lembar Siap Pakai untuk Praktik/OSCE/DOPS)

Form checklist ini digunakan sebagai alat penilaian terstruktur untuk menilai keterampilan mahasiswa dalam menerapkan prinsip etik, hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik keperawatan.

Checklist dirancang untuk:

1. Menstandarkan proses penilaian praktik
2. Memudahkan observasi langsung oleh penguji/preseptor
3. Menjamin aspek keselamatan pasien dan kepatuhan etik-hukum
4. Mendukung evaluasi berbasis kompetensi (OBE)

Identitas Penilaian

- Nama Mahasiswa : _____
- NIM : _____
- Tanggal : _____
- Tempat/Unit : _____
- Jenis Penilaian : ☐ OSCE ☐ DOPS ☐ Praktik Klinik

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian diare pada dewasa secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada pasien dewasa dengan diare	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji frekuensi dan karakteristik BAB cair pada pasien dewasa	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya muntah, intake cairan, dan jumlah urin	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda dehidrasi pada pasien dewasa	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada pasien dewasa dengan diare	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada pasien dewasa dengan diare	☐	☐	
No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan

8	Saya sudah bisa memantau status hidrasi dan intake-output pasien dewasa	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang pemberian oralit dengan benar pada pasien dewasa	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menganjurkan pola makan yang sesuai dengan toleransi pasien dewasa	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada pasien dewasa dengan diare kepada pasien dan keluarga	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien dewasa yang cemas	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan pasien dewasa dengan diare	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat pasien dewasa dengan diare	☐	☐	
16	Saya sudah bisa mengelola kecemasan pasien sebelum tindakan invasif (pemasangan infus)	☐	☐	(penam bahan sesuai kasus)
17	Saya sudah bisa menjaga privasi pasien saat melakukan tindakan keperawatan di lingkungan yang kurang mendukung	☐	☐	(penam bahan sesuai kasus)
18	Saya sudah bisa menjelaskan prosedur pemasangan infus dan mendapatkan informed consent dengan benar	☐	☐	(penam bahan sesuai kasus)

Refleksi singkat mahasiswa:

.....
.....
.....

Referensi

- Alodhialah, A. M., Almutairi, A. A., & Almutairi, M. (2024). Ethical and Legal Challenges in Caring for Older Adults with Multimorbidities: Best Practices for Nurses. *Healthcare (Switzerland)*, 12(16). <https://doi.org/10.3390/healthcare12161585>
- American Nurses Association (ANA). (2025). *Code of Ethics for Nurses with Interpretive Statements* (Provision 4.1). <https://codeofethics.ana.org/provision-4-1>.
- Arries, E. J. (2020). Professional values and ethical ideology: Perceptions of nursing students. *Nursing Ethics*, 27(3), 726–740. <https://doi.org/10.1177/0969733019889396>
- Association, A. N. (2001). *Code of ethics for nurses with interpretive statements*. Nursesbooks.org.
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2022). *Nursing ethics: Across the curriculum and into practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Cummins, L., Byers, K. V., & Pedrick, L. (2023). *Policy practice for social workers: An ethic of care approach*. Routledge.
- Dupuis, J. C. (2025). *Preventing Foreseeable Negligence and Malpractice in Nursing: Implications for Nursing Education by A doctoral thesis presented by*.
- Fond, G., Fernandes, S., Lucas, G., Greenberg, N., & Boyer, L. (2022a). Depression in healthcare workers: Results from the nationwide AMADEUS survey. *International Journal of Nursing Studies*, 135, 104328. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104328>
- Fond, G., Fernandes, S., Lucas, G., Greenberg, N., & Boyer, L. (2022b). Depression in healthcare workers: Results from the nationwide AMADEUS survey. *International Journal of Nursing Studies*, 135, 104328. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104328>
- Forde, M. F., Coffey, A., & Hegarty, J. (2018). The factors to be considered when evaluating bedside handover. *Journal of Nursing Management*, 26(7), 757–768. <https://doi.org/10.1111/jonm.12598>
- Georgiou, G. P. (2021). A model for the diagnosis of schizophrenia in speech perception. *The European Journal of Psychiatry*, 35(2), 126–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpsy.2020.11.001>
- Grace, P. J., & Uveges, M. K. (2022). *Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Guler, H., Cetin, P., Yurtsal, Z. B., Cesur, B., Bekar, M., Uçar, T., Evcili, F., & Cetin, A. (2018). Effect of episiotomy training with beef tongue and sponge

- simulators on the self-confidence building of midwifery students. *Nurse Education in Practice*, 30, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.02.004>
- Haryati, I., Trisyani, Y., & Nuraeni, A. (2025). Nurses' Ethical Challenges During Caring for COVID-19 Patients: Literature Study. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 15(2), 2022.
- Johnston, J., & Juengst, E. (2018a). Are Parents Really Obligated to Learn as Much as Possible about Their Children's Genomes? *Hastings Center Report*, 48, S14–S15. <https://doi.org/10.1002/hast.877>
- Johnston, J., & Juengst, E. (2018b). Are Parents Really Obligated to Learn as Much as Possible about Their Children's Genomes? *Hastings Center Report*, 48, S14–S15. <https://doi.org/10.1002/hast.877>
- Kang, C. M., & Jeong, I. S. (2020a). Validation of the Korean version of the Kidney Transplant Understanding Tool. *Asian Nursing Research*, 14(5), 320–326. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.09.002>
- Kang, C. M., & Jeong, I. S. (2020b). Validation of the Korean version of the Kidney Transplant Understanding Tool. *Asian Nursing Research*, 14(5), 320–326. <https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.09.002>
- Kasenda, E., & Mambu, I. R. (2025). *LITERATURE REVIEW: DILEMA ETIS DAN LEGAL DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI MEDIS DALAM PERAWATAN PASIEN*.
- Lachman, V. D. (2012). Applying the ethics of care to your nursing practice. *Medsurg Nursing*, 21(2).
- Logsdon, M. C., Lauf, A., Stikes, R., Revels, A., & Vickers-Smith, R. (2020). Partnering with new mothers to develop a smart phone app to prevent maternal mortality after hospital discharge: A pilot study. *Journal of Advanced Nursing*, 76(1), 324–327. <https://doi.org/10.1111/jan.14219>
- Luggar-Schmit, K. (2024). *Accountability in nursing: Nursing ethics breakdown*. <https://Nursingcecentral.Com/Accountability-in-Nursing/>.
- Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Long, L. E., & Fineout-Overholt, E. (2014). The Establishment of Evidence-Based Practice Competencies for Practicing Registered Nurses and Advanced Practice Nurses in Real-World Clinical Settings: Proficiencies to Improve Healthcare Quality, Reliability, Patient Outcomes, and Costs. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 11(1), 5–15. <https://doi.org/10.1111/wvn.12021>
- Mengellers, A. M. H. J., Bleijlevens, M. H. C., Verbeek, H., Capezuti, E., Tan, F. E. S., & Hamers, J. P. H. (2019). Professional and family caregivers' attitudes towards involuntary treatment in community-dwelling

- people with dementia. *Journal of Advanced Nursing*, 75(1), 96–107.
<https://doi.org/10.1111/jan.13839>
- Mia Svantesson, Marit Silén, & Inger James. (2017). It's not all about moral reasoning: Understanding the content of Moral Case Deliberation. *https://Journals.Sagepub.Com/Home/NEJ*, 25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0969733017700235>
- Tingle, J., & McHale, J. (2009). Specialist healthcare law for nurses: an introduction. *British Journal of Nursing*, 18(1), 38–39.
<https://doi.org/10.12968/bjon.2009.18.1.32088>
- Ventura, C. A. A., Austin, W., Carrara, B. S., & de Brito, E. S. (2021). Nursing care in mental health: Human rights and ethical issues. *Nursing Ethics*, 28(4), 463–480. <https://doi.org/10.1177/0969733020952102>
- Wanko Keutchafo, E. L., Kerr, J., & Baloyi, O. B. (2022). A Model for Effective Nonverbal Communication between Nurses and Older Patients: A Grounded Theory Inquiry. *Healthcare*, 10(11), 2119.
<https://doi.org/10.3390/healthcare10112119>
- Waterfield, D., & Barnason, S. (2022). The integration of care ethics and nursing workload: A qualitative systematic review. In *Journal of Nursing Management* (Vol. 30, Number 7, pp. 2194–2206). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/jonm.13723>
- Wenli, X. (2019). Human Rights in China and the Rule of Law, 42 U. Rich. In *L. Rev.* <https://scholarship.richmond.edu/lawreview>

BAB 2

NILAI, MORAL, ETIKA, DAN TEORI ETIKA DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Nilai, Moral, Etika, dan Teori Etika dalam Praktik Keperawatan	2.1 Membedakan nilai, moral, dan etika serta implikasinya pada keputusan klinis.	2.2 Menggunakan teori etik untuk menilai pilihan tindakan pada skenario sederhana.	CPMK-1	CPMK-2

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep teori/prinsip/kode etik dan ketepatan mengaitkan standar pada vignette.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Pendahuluan

Keperawatan merupakan profesi yang tidak hanya menuntut penguasaan ilmu biomedik dan keterampilan klinik, tetapi juga kemampuan untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan manusiawi. Dalam praktik sehari-hari, perawat berinteraksi langsung dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan dalam berbagai situasi yang sering kali kompleks, sensitif, dan sarat pertimbangan etik. Oleh karena itu, praktik keperawatan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: *Apa yang benar untuk dilakukan? Apa yang terbaik bagi pasien? Apakah keputusan yang diambil sudah menghormati martabat dan hak pasien?*

Pemahaman terhadap nilai, moral, dan etika menjadi sangat penting. Ketiga konsep ini merupakan fondasi awal sebelum mahasiswa mempelajari prinsip etik, kode etik profesi, hak pasien, informed consent, kerahasiaan, akuntabilitas profesional, hingga pengambilan keputusan etik dalam situasi klinis. Praktik keperawatan profesional menuntut integrasi antara pengetahuan, penalaran etik, sensitivitas moral, dan tanggung jawab profesional agar keputusan klinis yang diambil tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etik (Shadi et al., 2024).

Istilah nilai, moral, dan etika sering digunakan secara bergantian. Namun, secara konseptual ketiganya memiliki makna yang berbeda. Nilai berkaitan dengan keyakinan mengenai apa yang dianggap penting atau berharga; moral berkaitan dengan standar benar dan salah dalam perilaku; sedangkan etika merupakan refleksi rasional dan sistematis terhadap alasan di balik tindakan yang dinilai benar atau salah (Zhao et al., 2025). Perbedaan ini sangat penting dipahami oleh mahasiswa keperawatan agar mereka mampu mengenali sumber konflik etik, menilai alternatif tindakan, dan mengambil keputusan klinis yang lebih matang (Poorchangizi et al., 2019).

Selain memahami konsep dasar, mahasiswa juga perlu mengenal teori-teori etik yang sering digunakan dalam praktik keperawatan, seperti deontologi, utilitarianisme, virtue ethics, dan ethics of care. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai lensa analisis dalam menghadapi situasi klinis yang tidak selalu memiliki jawaban tunggal. Penggunaan teori etik dalam pendidikan keperawatan membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperjelas pertimbangan moral, dan meningkatkan kualitas keputusan klinis dalam situasi nyata (Sari et al., 2018).

Buku disusun untuk memberikan landasan konseptual dan praktis mengenai nilai, moral, etika, serta teori-teori etik dalam praktik keperawatan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami istilah-istilah etik secara teoritis, tetapi juga mampu menggunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang aman, profesional, dan berorientasi pada martabat manusia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep nilai, moral, dan etika dalam konteks praktik keperawatan.
2. Membedakan nilai, moral, dan etika secara konseptual maupun aplikatif.
3. Menjelaskan implikasi nilai, moral, dan etika dalam pengambilan keputusan klinis.
4. Menjelaskan teori-teori etik utama yang relevan dalam praktik keperawatan.
5. Menggunakan teori etik untuk menilai pilihan tindakan pada skenario sederhana.
6. Menyusun argumentasi awal terhadap keputusan etik dalam praktik keperawatan.

Peta Konsep

Bab ini membahas landasan konseptual yang penting dalam praktik keperawatan, yaitu nilai, moral, dan etika sebagai dasar berpikir dan bertindak profesional. Pembahasan diawali dengan konsep nilai sebagai keyakinan tentang apa yang dianggap penting dan berharga, dilanjutkan dengan konsep moral sebagai standar benar dan salah yang membimbing perilaku, serta konsep etika sebagai kajian rasional dan sistematis mengenai alasan di balik suatu tindakan dinilai benar atau salah. Selanjutnya, bab ini menguraikan perbedaan antara nilai, moral, dan etika agar mahasiswa mampu membedakan keyakinan pribadi, norma perilaku, dan kerangka analisis profesional dalam pengambilan keputusan. Materi juga menekankan implikasi ketiganya terhadap keputusan klinis, karena praktik keperawatan tidak hanya memerlukan pertimbangan ilmiah dan teknis, tetapi juga penalaran etik yang matang. Untuk memperkuat analisis, bab ini membahas teori etik yang relevan dalam praktik keperawatan, yaitu deontologi, utilitarianisme, virtue ethics, dan ethics of care, yang masing-masing memberikan sudut pandang berbeda dalam menilai tindakan keperawatan. Pada bagian akhir, konsep dan teori tersebut diaplikasikan pada kasus sederhana agar mahasiswa mampu menghubungkan pemahaman teoritis dengan situasi klinis nyata secara lebih sistematis, reflektif, dan profesional.

Uraian Materi

A. Konsep Nilai dalam Praktik Keperawatan

1. Pengertian Nilai

Nilai (*values*) adalah keyakinan, prinsip, atau pandangan yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang dianggap penting, baik, benar, dan layak diperjuangkan dalam kehidupan. Nilai memengaruhi cara seseorang menilai situasi, memilih tindakan, serta berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks profesi kesehatan, nilai juga berperan sebagai dasar pembentukan sikap profesional dan kualitas pelayanan (Li & Li, 2024).

Nilai dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain keluarga, budaya, agama, pendidikan, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, nilai bersifat sangat personal sekaligus sosial. Dua individu dapat berada pada situasi yang sama, tetapi menilai situasi tersebut secara berbeda karena latar belakang nilai yang berbeda pula (Tedjomuljo & Afifah, 2016).

2. Jenis-Jenis Nilai

Secara umum, nilai dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Nilai personal, yaitu keyakinan pribadi yang membentuk identitas dan pilihan individu.
- b. Nilai sosial, yaitu nilai yang hidup dan diterima dalam masyarakat.
- c. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkembang dalam tradisi atau kelompok budaya tertentu.
- d. Nilai profesional, yaitu nilai yang menjadi fondasi perilaku dalam suatu profesi.

Dalam keperawatan, nilai profesional sangat penting karena menjadi dasar perilaku perawat dalam memberikan asuhan yang aman, bermartabat, dan berorientasi pada pasien. International Council of Nurses menegaskan bahwa profesi keperawatan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat manusia, keadilan sosial, dan pelayanan tanpa diskriminasi (Huang & Pham, 2024).

3. Nilai dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, sejumlah nilai profesional yang sangat penting antara lain:

- a. penghormatan terhadap martabat manusia,
- b. kepedulian (*caring*),
- c. keselamatan pasien,
- d. kejujuran,
- e. tanggung jawab,
- f. keadilan,
- g. empati,
- h. profesionalisme.

Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi prinsip abstrak, tetapi harus tampak dalam tindakan nyata perawat. Sebagai contoh, nilai martabat manusia tercermin ketika perawat menjaga privasi pasien saat tindakan dilakukan. Nilai keselamatan pasien tercermin dalam ketelitian saat pemberian obat. Sementara itu, nilai kepedulian tampak saat perawat peka terhadap rasa nyeri, ketakutan, atau kecemasan pasien (Fitria De Intan , Akhmad Faozi, 2024).

Nilai profesional dalam keperawatan berfungsi sebagai dasar hubungan terapeutik, pengambilan keputusan, dan pembentukan identitas profesional perawat (Nazari et al., 2024). Oleh sebab itu, mahasiswa keperawatan perlu mengembangkan kesadaran nilai sejak dini agar mampu bertindak konsisten dengan standar profesi.

B. Konsep Moral dalam Praktik Keperawatan

1. Pengertian Moral

Moral adalah seperangkat norma, standar, atau aturan perilaku yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Moral berkaitan dengan kewajiban praktis manusia dalam kehidupan sehari-hari dan sangat dekat dengan hati nurani serta kebiasaan sosial (Nazari et al., 2024).

Apabila nilai menjawab pertanyaan *"Apa yang penting bagi saya?"*, maka moral lebih dekat dengan pertanyaan *"Apa yang seharusnya saya lakukan?"* Dengan demikian, moral memiliki orientasi yang lebih langsung terhadap perilaku.

2. Sumber Moral

Moral seseorang dibentuk oleh banyak faktor, antara lain:

- a. ajaran keluarga,
- b. keyakinan agama,
- c. norma masyarakat,
- d. budaya,
- e. pendidikan,
- f. pengalaman hidup.

Dalam konteks profesi, moral juga berkembang melalui proses pendidikan dan sosialisasi profesi. Mahasiswa keperawatan belajar bukan hanya melalui teori, tetapi juga melalui teladan dosen, preceptor, pembimbing klinik, dan budaya profesional di lingkungan pelayanan.

3. Moral dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, moral tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti:

- a. berkata jujur kepada pasien sesuai kewenangan,
- b. tidak memalsukan dokumentasi,
- c. tidak mengabaikan kebutuhan pasien,
- d. tidak memperlakukan pasien secara diskriminatif,
- e. menjaga kerahasiaan informasi pasien.

Perilaku-perilaku tersebut tidak hanya penting secara administratif atau legal, tetapi juga menunjukkan integritas moral seorang perawat. Integritas moral sangat berhubungan dengan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan, dan kepercayaan tersebut merupakan komponen penting dalam keberhasilan hubungan terapeutik (Poorchangizi et al., 2019).

4. Moral Distress dalam Keperawatan

Dalam praktik klinis, perawat juga dapat mengalami moral distress, yaitu keadaan ketika perawat mengetahui tindakan yang dianggap benar secara moral,

tetapi mengalami hambatan untuk melakukannya. Hambatan tersebut dapat berasal dari sistem, struktur organisasi, tekanan keluarga, keterbatasan kewenangan, atau konflik dengan tenaga kesehatan lain (Butts, n.d.).

Sebagai contoh, seorang perawat mungkin merasa bahwa pasien perlu diberikan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan, tetapi keluarga justru meminta agar informasi tertentu disembunyikan. Situasi semacam ini dapat menimbulkan tekanan moral yang signifikan dan membutuhkan penalaran etik yang matang.

C. Konsep Etika dalam Praktik Keperawatan

1. Pengertian Etika

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip mengenai baik dan buruk, benar dan salah, kewajiban, tanggung jawab, serta alasan rasional yang mendasari tindakan manusia. Etika tidak sekadar menilai tindakan, tetapi juga mengkaji *mengapa* suatu tindakan dianggap benar atau salah (Shadi et al., 2024).

Dalam profesi keperawatan, etika berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menilai persoalan yang tidak selalu dapat dijawab hanya dengan kebiasaan, intuisi, atau aturan prosedural. Oleh karena itu, etika membantu perawat berpikir secara sistematis, reflektif, dan bertanggung jawab.

2. Fungsi Etika dalam Keperawatan

Etika memiliki beberapa fungsi penting dalam praktik keperawatan, yaitu:

- a. Sebagai dasar refleksi profesional, agar perawat mampu mempertanyakan alasan di balik tindakan.
- b. Sebagai alat analisis, untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks atau dilematis.
- c. Sebagai pedoman perilaku profesional, agar pelayanan yang diberikan tetap menghormati hak, martabat, dan keselamatan pasien.
- d. Sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama ketika terdapat konflik antara kebutuhan klinis, nilai pasien, keinginan keluarga, dan tuntutan sistem.

3. Etika Keperawatan sebagai Disiplin Profesi

Etika keperawatan berkembang sebagai bagian penting dari profesionalisme. Seorang perawat tidak cukup hanya “berniat baik”, tetapi juga harus mampu memberikan alasan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan dan tindakan klinis. Dengan kata lain, praktik etis bukan hanya masalah “sikap baik”, melainkan juga masalah penalaran profesional.

Butts dan Rich menegaskan bahwa etika keperawatan tidak berdiri terpisah dari praktik, tetapi justru menjadi inti dari praktik profesional itu sendiri karena hampir setiap keputusan keperawatan memiliki dimensi etik, baik secara eksplisit maupun implisit (Butts, n.d.).

D. Perbedaan Nilai, Moral, dan Etika

Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan nilai, moral, dan etika sangat penting agar mahasiswa mampu mengenali sumber persoalan dalam situasi klinis. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik.

Tabel 2. 1 Perbedaan Nilai, Moral, dan Etika

Aspek	Nilai	Moral	Etika
Pengertian	Keyakinan tentang apa yang dianggap penting atau berharga	Standar perilaku mengenai benar dan salah	Kajian rasional tentang alasan di balik benar dan salah
Fokus	Apa yang dianggap penting	Apa yang seharusnya dilakukan	Mengapa tindakan itu benar atau salah
Bentuk	Prinsip/keyakinan	Norma/perilaku	Kerangka analisis/refleksi
Contoh	Martabat pasien harus dihormati	Tidak boleh mempermalukan pasien	Bagaimana cara menjaga martabat pasien dalam situasi klinis tertentu?

Aplikasi dalam Praktik

Sebagai ilustrasi, pada situasi ketika seorang pasien merasa malu saat akan dilakukan tindakan:

1. Nilai yang relevan adalah penghormatan terhadap martabat pasien.
2. Moral yang relevan adalah keyakinan bahwa pasien tidak boleh dipermalukan.
3. Etika membantu perawat menjawab bagaimana tindakan dilakukan secara tepat, aman, dan tetap menghormati pasien.

Dengan demikian, nilai, moral, dan etika dapat dipahami sebagai tiga lapisan yang saling melengkapi: nilai memberi arah, moral memberi batas perilaku, dan etika memberi dasar analisis.

E. Implikasi Nilai, Moral, dan Etika terhadap Keputusan Klinis

Praktik keperawatan selalu melibatkan pengambilan keputusan. Sebagian keputusan memang bersifat teknis, tetapi sebagian lainnya memuat dimensi etik yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, nilai, moral, dan etika memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap cara seorang perawat menilai situasi dan memilih tindakan.

1. Nilai Memengaruhi Preferensi dan Prioritas

Nilai memengaruhi cara pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan memandang suatu tindakan atau hasil pelayanan. Sebagai contoh, bagi sebagian pasien, kenyamanan dan kualitas hidup mungkin lebih penting daripada tindakan invasif; sementara bagi keluarga, kelangsungan hidup mungkin menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, perawat perlu peka bahwa konflik yang muncul tidak selalu disebabkan oleh "siapa yang benar", tetapi sering kali oleh perbedaan nilai.

Contoh

Pasien menolak tindakan tertentu karena merasa privasinya terganggu, sementara tim kesehatan menilai tindakan tersebut penting untuk pemantauan kondisi. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai pasien dan kebutuhan klinis perlu dipertimbangkan secara seimbang.

2. Moral Membantu Menentukan Batas Benar dan Salah

Moral membantu perawat mengenali perilaku yang tidak dapat dibenarkan dalam praktik, misalnya:

- a. berbohong kepada pasien,
- b. memalsukan dokumentasi,
- c. mempermalukan pasien,
- d. mengabaikan keluhan nyeri,
- e. membicarakan kondisi pasien secara tidak pantas.

Dalam konteks ini, moral berfungsi sebagai pagar perilaku profesional. Menurut Burkhardt dan Nathaniel, sensitivitas moral penting untuk membantu perawat mengenali kapan suatu tindakan berpotensi merugikan martabat, hak, atau kesejahteraan pasien (Shadi et al., 2024).

3. Etika Membantu Menilai Situasi yang Kompleks

Tidak semua persoalan klinis dapat diselesaikan hanya dengan aturan sederhana. Dalam situasi yang kompleks, etika membantu perawat:

- a. mengidentifikasi konflik utama,
- b. mengenali pihak-pihak yang terlibat,
- c. mempertimbangkan alternatif tindakan,
- d. menilai konsekuensi dari setiap pilihan,
- e. mengambil keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh

Seorang pasien dewasa sadar menolak tindakan tertentu karena takut, sementara keluarga mendesak agar tindakan tetap dilakukan. Dalam situasi ini, perawat perlu mempertimbangkan:

- a. apakah pasien memahami kondisinya,
- b. apakah pasien memiliki kapasitas mengambil keputusan,
- c. apakah informasi sudah cukup diberikan,
- d. apa kewajiban profesional perawat,
- e. bagaimana menjaga keselamatan pasien tanpa melanggar martabat dan haknya.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa keputusan klinis yang baik harus memadukan pertimbangan teknis, komunikasi terapeutik, dan penalaran etik.

F. Teori Etika dalam Praktik Keperawatan

Teori etik memberikan kerangka konseptual untuk menilai tindakan secara lebih sistematis. Dalam praktik keperawatan, teori etik membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan memahami bahwa satu masalah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang moral dan profesional. Teori etik tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian klinis, melainkan memperkuat kualitas keputusan yang diambil (Sari et al., 2018).

1. Deontologi (Etika Kewajiban)

a. Pengertian

Deontologi adalah teori etik yang menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan kewajiban, aturan, atau prinsip moral yang harus dipatuhi, bukan terutama berdasarkan akibat akhirnya. Dalam pendekatan ini, suatu tindakan dinilai benar apabila sesuai dengan kewajiban moral yang melekat pada peran profesional (Butts, n.d.).

b. Karakteristik Utama

Ciri utama deontologi antara lain:

- 1) menekankan kewajiban moral,
- 2) menghormati hak individu,
- 3) mengutamakan prinsip kejujuran dan tanggung jawab,
- 4) memandang manusia sebagai pribadi yang harus dihormati.

c. Relevansi dalam Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, deontologi sangat relevan karena profesi ini memiliki kewajiban moral dan profesional yang jelas, seperti:

- 1) menghormati otonomi pasien,
- 2) menjaga kerahasiaan,
- 3) memberikan informasi yang benar sesuai kewenangan,
- 4) bertindak sesuai standar profesi.

d. Contoh Aplikasi

Apabila pasien bertanya tentang prosedur yang akan dijalani, perawat memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jujur, jelas, dan sesuai kewenangan. Dalam perspektif deontologi, kejujuran tetap penting meskipun informasi tersebut mungkin menimbulkan kecemasan sementara pada pasien.

e. Kekuatan dan Keterbatasan

Kekuatan deontologi terletak pada kemampuannya melindungi hak pasien dan menjaga konsistensi moral. Namun, keterbatasannya adalah pendekatan ini dapat menjadi kaku ketika dua kewajiban tampak saling bertabrakan, misalnya antara menjaga kenyamanan pasien dan kebutuhan melakukan tindakan yang tidak nyaman tetapi penting.

2. Utilitarianisme (Etika Konsekuensi)

a. Pengertian

Utilitarianisme adalah teori etik yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau hasilnya. Tindakan dianggap baik apabila menghasilkan manfaat terbesar atau kerugian paling kecil bagi sebanyak mungkin pihak (Sari et al., 2018).

b. Karakteristik Utama

Ciri utama utilitarianisme antara lain:

- 1) berfokus pada hasil akhir,
- 2) mempertimbangkan manfaat dan kerugian,
- 3) menekankan efisiensi dan dampak,
- 4) relevan dalam situasi prioritas dan alokasi sumber daya.

c. Relevansi dalam Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, utilitarianisme sering muncul pada situasi seperti:

- 1) triase pasien,
- 2) prioritas tindakan,
- 3) manajemen waktu dan sumber daya,
- 4) pengendalian risiko,
- 5) keselamatan pasien.

d. Contoh Aplikasi

Dalam situasi ruang gawat darurat dengan banyak pasien, perawat mungkin harus memprioritaskan pasien yang paling berisiko mengalami perburukan cepat. Keputusan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan utilitarian karena bertujuan menghasilkan manfaat terbesar dalam kondisi sumber daya terbatas.

e. Kekuatan dan Keterbatasan

Utilitarianisme berguna untuk menentukan prioritas dalam situasi nyata. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena berisiko mengabaikan hak atau preferensi individu jika hanya berfokus pada hasil kolektif.

3. Virtue Ethics (Etika Kebajikan)

a. Pengertian

Virtue ethics adalah teori etik yang menekankan bahwa tindakan baik lahir dari karakter atau kebajikan yang baik. Fokus utamanya bukan hanya pada aturan atau konsekuensi, tetapi pada pembentukan pribadi profesional yang bermoral (Butts, n.d.).

b. Karakteristik Utama

Etika kebajikan menekankan pentingnya karakter seperti:

- 1) jujur,
- 2) sabar,
- 3) adil,
- 4) empatik,
- 5) berani,
- 6) bijaksana,
- 7) bertanggung jawab.

c. Relevansi dalam Keperawatan

Dalam keperawatan, virtue ethics sangat relevan karena profesi ini sangat bergantung pada kualitas karakter perawat dalam membangun hubungan terapeutik. Keterampilan teknis tanpa karakter profesional yang baik dapat menurunkan mutu pelayanan dan kepercayaan pasien.

d. Contoh Aplikasi

Perawat yang tetap sabar dan tenang ketika menghadapi pasien yang marah atau takut menunjukkan kebajikan profesional. Dalam situasi tersebut, tindakan etis tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari kualitas karakter yang ditampilkan.

e. Kekuatan dan Keterbatasan

Kekuatan virtue ethics terletak pada pembentukan identitas profesional yang kuat. Namun, pendekatan ini kadang kurang memberikan langkah analisis yang sistematis ketika menghadapi dilema klinis yang kompleks.

4. Ethics of Care (Etika Kepedulian)

a. Pengertian

Ethics of care adalah teori etik yang menekankan pentingnya relasi, empati, perhatian, tanggung jawab interpersonal, dan pemahaman terhadap kebutuhan konkret individu. Teori ini menempatkan hubungan manusia sebagai pusat pertimbangan etik (Butts, n.d.).

b. Karakteristik Utama

Ciri utama ethics of care meliputi:

- 1) pentingnya hubungan interpersonal,
- 2) penghargaan terhadap pengalaman subjektif pasien,
- 3) empati dan kehadiran terapeutik,
- 4) perhatian pada konteks dan kebutuhan individual.

c. Relevansi dalam Keperawatan

Ethics of care sangat dekat dengan hakikat profesi keperawatan karena keperawatan pada dasarnya merupakan praktik yang berorientasi pada caring. Hubungan terapeutik, pendampingan, pengurangan penderitaan, dan perhatian terhadap pengalaman pasien merupakan inti dari praktik keperawatan.

d. Contoh Aplikasi

Seorang pasien tampak takut menjalani prosedur. Perawat yang tidak hanya menjelaskan prosedur, tetapi juga duduk, mendengarkan ketakutan pasien, dan memberikan rasa aman sedang menerapkan ethics of care.

e. Kekuatan dan Keterbatasan

Kekuatan teori ini adalah kesesuaiannya yang sangat tinggi dengan praktik keperawatan. Namun, bila tidak diimbangi dengan standar profesional dan pertimbangan keselamatan, pendekatan ini dapat menjadi terlalu subjektif atau emosional.

G. Penggunaan Teori Etik dalam Menilai Pilihan Tindakan

Dalam praktik keperawatan, teori etik dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai alternatif tindakan secara lebih sistematis. Mahasiswa perlu memahami bahwa satu kasus dapat dianalisis dari lebih dari satu teori etik, dan masing-masing teori dapat memberikan penekanan yang berbeda.

Langkah Sederhana Analisis Etik

Analisis etik sederhana dalam konteks pembelajaran dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi masalah
 - a. Apa yang sedang terjadi?
 - b. Siapa saja pihak yang terlibat?
 - c. Di mana letak konflik atau ketegangan utamanya?
2. Mengidentifikasi pilihan tindakan
 - a. Tindakan apa saja yang mungkin dilakukan?
 - b. Adakah tindakan yang secara langsung berisiko terhadap pasien?
3. Menganalisis menggunakan teori etik
 - a. Deontologi: tindakan mana yang paling sesuai dengan kewajiban profesional?
 - b. Utilitarianisme: tindakan mana yang memberikan manfaat terbesar atau risiko paling kecil?
 - c. Virtue ethics: tindakan mana yang paling mencerminkan karakter profesional yang baik?
 - d. Ethics of care: tindakan mana yang paling menunjukkan kepedulian dan penghormatan terhadap pengalaman pasien?
4. Menentukan keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan
 - a. Keputusan dipilih bukan hanya karena “terasa benar”, tetapi karena dapat dijelaskan secara rasional dan profesional.
5. Mengomunikasikan dan mendokumentasikan keputusan
 - a. Dalam praktik nyata, keputusan etik perlu dikomunikasikan secara jelas dan dicatat secara tepat.

Langkah ini sangat berguna bagi mahasiswa karena membantu membangun kebiasaan berpikir sistematis dalam menghadapi situasi klinis yang mengandung persoalan etik.

H. Contoh Analisis Kasus Sederhana

Kasus

Seorang pasien dewasa sadar dirawat di ruang rawat inap dan direncanakan dilakukan pemasangan kateter urin untuk pemantauan output urin yang akurat. Namun, pasien menolak tindakan tersebut karena merasa malu dan tidak nyaman.

Pilihan Tindakan

Beberapa pilihan tindakan yang mungkin muncul adalah:

1. Tetap melakukan tindakan demi kepentingan klinis pasien.
2. Menghormati penolakan pasien tanpa melakukan eksplorasi lebih lanjut.
3. Memberikan penjelasan yang sesuai kewenangan, menjaga privasi, mengeksplorasi alasan penolakan pasien, dan mempertimbangkan langkah selanjutnya secara profesional.

Analisis Etik

1. Analisis Deontologi

Dalam perspektif deontologi, perawat memiliki kewajiban untuk:

- a. menghormati martabat pasien,
- b. memberikan penjelasan yang jujur,
- c. menjaga privasi,
- d. menghormati hak pasien dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, tindakan memaksa pasien jelas tidak sesuai dengan kewajiban profesional.

2. Analisis Utilitarianisme

Dari sudut pandang utilitarianisme, pemasangan kateter memang dapat memberi manfaat klinis penting, yaitu pemantauan kondisi pasien secara akurat. Namun, tindakan terbaik adalah yang tetap memberi manfaat klinis terbesar dengan risiko psikologis dan ketidaknyamanan sekecil mungkin. Oleh karena itu, edukasi yang baik, komunikasi terapeutik, dan pendekatan yang menghormati pasien merupakan pilihan yang lebih tepat.

3. Analisis Virtue Ethics

Dari sudut pandang virtue ethics, perawat yang baik akan menunjukkan:

- a. empati,
- b. kesabaran,
- c. kebijaksanaan,
- d. rasa hormat,
- e. tanggung jawab.

Perawat tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi juga pada kualitas sikap profesional yang ditampilkan saat menghadapi pasien.

4. Analisis Ethics of Care

Dalam perspektif ethics of care, rasa malu pasien bukan sekadar hambatan teknis, tetapi pengalaman manusiawi yang nyata dan harus dihormati. Oleh karena itu, perawat perlu hadir secara terapeutik, mendengarkan pasien, dan membangun rasa aman sebelum melanjutkan proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan Kasus

Berdasarkan analisis di atas, pilihan tindakan yang paling tepat adalah memberikan penjelasan yang sesuai kewenangan, menjaga privasi, mengeksplorasi alasan pasien, serta merespons penolakan pasien secara profesional dan etis. Keputusan ini paling seimbang karena menghormati pasien sekaligus tetap mempertimbangkan kepentingan klinis.

I. Penutup

Nilai, moral, dan etika merupakan fondasi penting dalam praktik keperawatan profesional. Pemahaman terhadap ketiga konsep ini memungkinkan mahasiswa dan perawat untuk tidak hanya bertindak berdasarkan kebiasaan atau instruksi, tetapi juga berdasarkan penalaran yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik nyata, keputusan klinis yang baik tidak hanya harus benar secara teknis, tetapi juga harus menghormati martabat manusia, hak pasien, keselamatan, dan integritas profesi.

Teori etik seperti deontologi, utilitarianisme, virtue ethics, dan ethics of care membantu perawat melihat persoalan klinis dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi. Oleh karena itu, penguasaan bab ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami topik-topik etik keperawatan yang lebih kompleks pada bab-bab berikutnya, seperti prinsip etik, hak pasien, informed consent, kerahasiaan, isu etik klinis, dan pengambilan keputusan etik-hukum dalam pelayanan keperawatan.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case

Kasus

Seorang pasien perempuan usia 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena anemia berat dan direncanakan menjalani transfusi darah. Sebelum tindakan dilakukan, pasien tampak cemas dan menyampaikan kepada perawat bahwa ia belum memahami manfaat serta risiko tindakan tersebut. Pasien mengatakan ia takut dan belum yakin untuk melanjutkan tindakan.

Keluarga pasien yang berada di ruangan meminta perawat agar tidak menjelaskan terlalu banyak kepada pasien karena khawatir pasien menjadi semakin takut dan akhirnya menolak transfusi. Keluarga berpendapat bahwa yang terpenting adalah pasien segera menjalani tindakan.

Perawat berada dalam situasi yang melibatkan kebutuhan klinis pasien, keinginan keluarga, serta hak pasien untuk memahami tindakan yang akan dijalani.

Petunjuk Kegiatan

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi unsur nilai, moral, dan etika yang muncul dalam kasus tersebut.
2. Mengapa perawat perlu membedakan antara keinginan keluarga dan hak pasien?
3. Teori etik apa yang paling relevan digunakan untuk menilai kasus ini? Jelaskan alasannya.
4. Apa risiko bila perawat hanya mengikuti keinginan keluarga tanpa mempertimbangkan hak pasien?
5. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan perawat?
6. Susun argumentasi profesional singkat atas tindakan yang Anda pilih.

Arah Pembahasan

Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi:

- a. adanya nilai seperti keselamatan, penghormatan, dan kepedulian;
- b. adanya persoalan moral seperti kejujuran dan tanggung jawab;
- c. adanya persoalan etika terkait hak pasien untuk mengetahui dan memahami tindakan;
- d. penggunaan teori deontologi, ethics of care, dan utilitarianisme untuk menilai tindakan;

- e. tindakan terbaik adalah memberikan penjelasan yang sesuai kewenangan, empatik, jujur, dan tetap menghormati pasien.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/Skill Lab

Fokus: Komunikasi Etik pada Pasien yang Ragu terhadap Tindakan

Mahasiswa naik tangga kompetensi, sehingga pembelajaran tidak langsung “loncat ke ujian”, tetapi dibangun dari pemahaman menuju performa.

Tujuan Simulasi

Mahasiswa mampu:

1. menggali kekhawatiran pasien secara profesional;
2. membedakan nilai, moral, dan etika dalam situasi klinis sederhana;
3. menggunakan teori etik secara awal untuk menilai tindakan;
4. memberikan komunikasi etik yang aman, jelas, dan empatik.

Asesmen (Piramida Miller)

Tabel 2. 2 Asesmen Bab 2 Berdasarkan Piramida Miller

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE komunikasi etik sederhana
Does	DOPS di lahan praktik / observasi langsung komunikasi klinis sederhana

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Melakukan komunikasi terapeutik secara sopan dan profesional.
2. Menjaga identitas, privasi, dan kenyamanan pasien.
3. Menggali alasan kecemasan atau keraguan pasien.
4. Memberikan penjelasan yang jujur, sederhana, dan sesuai kewenangan.
5. Tidak memaksa pasien dan tidak mengabaikan hak pasien.
6. Menunjukkan pertimbangan etik awal dalam merespons konflik pasien–keluarga.

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan & penghormatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan awal	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Contoh: Template Soal Osce Keperawatan

Station: Komunikasi Etik Pada Pasien Yang Ragu Terhadap Tindakan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Komunikasi Etik pada Pasien yang Ragu terhadap Tindakan
3	Waktu yang dibutuhkan	10–12 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi terapeutik, pengkajian fokus, identifikasi unsur etik dasar, serta memberikan penjelasan awal secara profesional pada pasien yang ragu terhadap tindakan.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Penalaran etik awal 4. Profesionalisme
6	Kategori	1. Etik keperawatan 2. Hak pasien 3. Komunikasi klinis 4. Profesionalisme
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien perempuan usia 28 tahun dirawat karena anemia berat dan direncanakan menjalani transfusi darah. Pasien tampak cemas dan mengatakan belum memahami manfaat dan risiko tindakan. Keluarga meminta Anda agar tidak menjelaskan terlalu banyak kepada pasien karena takut pasien menolak. TUGAS: 1) Lakukan pengkajian fokus terkait kekhawatiran pasien. 2) Berikan penjelasan awal sesuai kewenangan. 3) Tunjukkan respons profesional terhadap konflik antara pasien dan keluarga.

8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENGUJI: 1) Menilai kemampuan peserta dalam menggali kekhawatiran pasien dan pemahaman pasien terhadap tindakan. 2) Menilai kemampuan peserta menjelaskan tindakan dengan bahasa sederhana, jujur, dan sesuai kewenangan. 3) Menilai kemampuan peserta menjaga hak pasien, privasi, dan komunikasi terapeutik. 4) Menilai kemampuan peserta menunjukkan pertimbangan etik awal. 5) Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1) Identitas pasien: perempuan, 28 tahun. 2) Keluhan utama: takut menjalani transfusi. 3) Pasien mengatakan "Saya takut, saya belum paham manfaat dan risikonya." 4) Bila ditanya alasan takut: takut komplikasi dan takut jarum. 5) Bila ditanya apakah keluarga mendukung: keluarga ingin tindakan cepat dilakukan. 6) Ekspresi pasien tampak cemas dan ragu.
10	Setting station	Ruang rawat / ruang edukasi pasien
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Kursi pasien 2. Kursi peserta 3. Meja kecil 4. Handrub 5. Lembar instruksi peserta 6. Lembar penilaian penguji
12	Penulis	
13	Referensi	Sesuaikan dengan referensi bab

Checklist Osce Ringkas

Komunikasi Etik Pada Pasien Yang Ragu Terhadap Tindakan

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra-interaksi				
1	Menyiapkan diri dan memahami skenario				
2	Melakukan kebersihan tangan				
B	Tahap Orientasi				
3	Menyampaikan salam terapeutik				

4	Menyampaikan nama dan peran perawat				
5	Mengecek identitas pasien secara aktif				
6	Menjelaskan maksud dan tujuan interaksi				
7	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja				
8	Menggali apa yang membuat pasien takut/ragu				
9	Menggali pemahaman pasien terhadap tindakan				
10	Menggali pengaruh keluarga terhadap keputusan pasien				
11	Menunjukkan sikap empatik terhadap kecemasan pasien				
12	Memberikan penjelasan awal yang sederhana dan jujur				
13	Menjelaskan bahwa pasien berhak memahami tindakan				
14	Tidak memaksa pasien				
15	Menunjukkan respons profesional terhadap permintaan keluarga				
16	Menyampaikan bahwa penjelasan lebih lanjut/konfirmasi dapat dikoordinasikan dengan tim terkait bila diperlukan				
D	Tahap Terminasi				
17	Menyimpulkan pembicaraan				
18	Memberi kesempatan pasien bertanya				

19	Menutup interaksi dengan baik				
E	Penampilan Profesional				
20	Aman, sopan, teliti, responsif, dan etis				

Form Penilaian Osce Keperawatan

Station: Komunikasi Etik Pada Pasien Yang Ragu Terhadap Tindakan

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian fokus	Menggali kekhawatiran pasien, pemahaman pasien, dan pengaruh keluarga					2	
2	Penalaran etik awal	Menunjukkan pemahaman hak pasien dan respons terhadap konflik sederhana					3	
3	Edukasi/komunikasi	Menjelaskan tindakan dengan bahasa sederhana, jujur, dan sesuai kewenangan					3	
4	Perilaku profesional	Menjaga privasi, empati, sistematis, aman, dan etis					2	

Jumlah = 10

Keterangan skor

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

Station: Komunikasi Etik Pada Pasien Yang Ragu Terhadap Tindakan

a. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1. Pengkajian Fokus Aspek ini menilai kemampuan peserta menggali alasan kecemasan pasien, tingkat pemahaman pasien terhadap tindakan, serta pengaruh keluarga terhadap keputusan pasien.					2	
2. Penalaran Etik Awal Aspek ini menilai kemampuan peserta mengenali hak pasien untuk memahami tindakan dan menunjukkan respons yang tepat terhadap konflik sederhana antara pasien dan keluarga.					3	
3. Edukasi/Komunikasi Aspek ini menilai kemampuan peserta menjelaskan tindakan secara jujur, sederhana, sesuai kewenangan, dan tetap menghormati pasien.					3	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai komunikasi terapeutik, privasi, empati, sistematika, keselamatan, dan sikap profesional peserta.					2	

b. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Fokus	Tidak menggali kekhawatiran	Menggali sangat terbatas,	Menggali cukup baik, sebagian	Menggali secara lengkap,

	pasien atau pengkajian tidak relevan	tidak sistematis, dan tidak menangkap masalah utama	besar data penting didapat, tetapi masih ada data yang terlewat	sistematis, relevan, dan mampu menangkap inti kekhawatiran pasien serta pengaruh keluarga
2. Penalaran Etik Awal	Tidak menunjukkan pemahaman etik atau respons keliru	Menunjukkan pemahaman sangat terbatas dan respons belum tepat	Menunjukkan pemahaman cukup baik tentang hak pasien dan konflik sederhana	Menunjukkan pemahaman etik yang jelas, logis, dan respons profesional yang kuat
3. Edukasi/Komunikasi	Tidak mampu menjelaskan tindakan atau penjelasan tidak sesuai	Penjelasan sangat terbatas, tidak jelas, atau berisiko	Penjelasan cukup baik, cukup jelas, namun masih kurang lengkap	Penjelasan jelas, jujur, sederhana, sesuai kewenangan, dan sangat membantu pasien
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih banyak kekurangan	Menunjukkan perilaku profesional cukup baik, masih ada kekurangan kecil	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten: empatik, sopan, etis, menjaga privasi, dan sistematis

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai

1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

c. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai penilaian umum terhadap kemampuan peserta ujian.

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR
-------------	------------	-------	----------

Jumlah total skor =

Nilai akhir =

$$\frac{\text{Jumlah total skor} \times 100}{30}$$

(Kota),

Penguji:

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

Observasi Langsung pada Komunikasi Etik Dasar dalam Asuhan Keperawatan

Checklist + umpan balik singkat

Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan DOPS pada Komunikasi Etik Dasar dalam Praktik Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Bab 2
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa mahasiswa saat melakukan keterampilan atau interaksi klinik tertentu.	Pembimbing mengamati langsung interaksi mahasiswa saat menjelaskan tindakan sederhana atau merespons keraguan pasien di ruang rawat.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan komunikasi, pengkajian fokus, penalaran etik awal, dan profesionalisme.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan etik, tetapi juga dari kemampuannya menghormati pasien dan berkomunikasi secara aman.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata dan sesuai capaian pembelajaran.	Misalnya pasien tampak takut terhadap tindakan, belum memahami prosedur, atau

		meminta penjelasan lebih lanjut.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan interaksi klinik singkat namun utuh.	Mahasiswa memperkenalkan diri, menggali kekhawatiran pasien, memberi penjelasan sederhana, dan merespons pasien secara etis.
Aspek yang dinilai	Pengkajian, komunikasi, penalaran etik awal, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menunjukkan penghormatan, kejujuran, dan kepedulian.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing memperhatikan kualitas performa secara langsung.	Apakah mahasiswa memahami hak pasien, tidak memaksa, dan menjaga privasi.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi, singkat dan spesifik.	Pembimbing dapat menilai mahasiswa sudah baik dalam empati, tetapi masih perlu meningkatkan kejelasan penjelasan.
Keputusan penilaian	Menentukan tingkat performa mahasiswa.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu berinteraksi secara aman, etis, dan profesional.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Mahasiswa dinilai bukan hanya memahami konsep etik, tetapi mampu menunjukkannya dalam praktik.

Portofolio

Bukti yang Dikumpulkan

- Hasil analisis mini-case
- Hasil OSCE komunikasi etik
- Hasil DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi etik/patient safety
- Feedback CI/dosen

Tabel 2. 3 Portofolio pada Bab 2: Nilai, Moral, Etika, dan Teori Etika

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Bab 2
----------	-----------	-------------------

Hakikat portofolio	Portofolio adalah kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.	Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami dan menerapkan dasar etik secara konsisten.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan.	Mahasiswa menunjukkan bagaimana ia berkembang dalam komunikasi etik dan penalaran etik awal.
OSCE dan DOPS	Menjadi bukti keterampilan terstruktur dan performa nyata.	OSCE menunjukkan performa di skill lab, DOPS menunjukkan performa di lahan praktik.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus yang pernah dihadapi mahasiswa.	Misalnya kasus pasien yang takut tindakan atau ragu menerima prosedur tertentu.
Refleksi patient safety/etik	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko etik dan keselamatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya komunikasi yang jujur dan penghormatan terhadap pasien.
Feedback CI/dosen	Bukti pembinaan dan area perbaikan.	Dosen/CI menilai komunikasi mahasiswa sudah baik, tetapi perlu lebih sistematis.
Karakteristik penilaian	Dibangun berulang, bukan sekali selesai.	Mahasiswa dinilai dari konsistensi performanya dalam berbagai situasi.
Bukti konsistensi kompetensi	Memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa.	Portofolio menunjukkan mahasiswa mampu berkomunikasi etik secara konsisten.
Makna dalam OBE	Menunjukkan bahwa capaian pembelajaran benar-benar tampak dalam performa berulang.	Mahasiswa tidak hanya paham teori etik, tetapi mampu menunjukkannya dalam praktik.

Tabel 2. 4 Case Report

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Bab 2
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pasien yang ragu terhadap tindakan karena belum memahami prosedur.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data, analisis masalah, dan tindakan.	Mahasiswa menjelaskan masalah komunikasi, unsur etik, dan respons profesional yang dilakukan.
Isi laporan	Identitas singkat, keluhan utama, data subjektif-objektif, analisis, tindakan, evaluasi, dan pembelajaran.	Mahasiswa menuliskan kekhawatiran pasien, respons keluarga, tindakan edukasi, dan hasil interaksi.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, relevansi analisis, logika penalaran, dan tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data dengan persoalan etik sederhana.
Nilai edukatif	Membantu mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi profesional.	Mahasiswa belajar bahwa komunikasi etik adalah bagian penting dari asuhan keperawatan.
Makna dalam OBE	Menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori pada kasus nyata.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia mampu menganalisis situasi etik sederhana secara sistematis.

Tabel 2. 5 Refleksi Patient Safety / Refleksi Etik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Bab 2
Hakikat refleksi	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko, menganalisis masalah, dan merencanakan perbaikan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa komunikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kecemasan, salah paham, atau penolakan tindakan.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan dan etika adalah bagian dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kegagalan menjelaskan tindakan dapat memengaruhi keputusan pasien.

Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko utama: pasien tidak paham tindakan, merasa dipaksa, atau kehilangan kepercayaan.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi merugikan pasien.	Misalnya pasien mengambil keputusan tanpa pemahaman yang cukup.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Menjelaskan tindakan dengan bahasa sederhana, memverifikasi pemahaman, dan menjaga komunikasi empatik.
Pembelajaran mahasiswa	Apa yang dipelajari dan bagaimana memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa komunikasi etik adalah bagian dari keselamatan dan profesionalisme.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan tanggung jawab klinik.	Mahasiswa tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mengevaluasi kualitas tindakannya.

J. Latihan Soal

Pilihan Ganda

- Pernyataan "kejujuran adalah hal yang penting dalam pelayanan" paling tepat menggambarkan konsep ...
 - hukum
 - nilai
 - insiden
 - diagnosis
- Pernyataan "perawat tidak boleh memalsukan dokumentasi" paling dekat dengan konsep ...
 - moral
 - anatomi
 - triase
 - fisiologi

3. Pertanyaan “mengapa tindakan ini dianggap benar?” merupakan fokus dari ...
 - a. etika
 - b. patologi
 - c. farmakologi
 - d. mikrobiologi
4. Teori etik yang menilai tindakan berdasarkan kewajiban adalah ...
 - a. utilitarianisme
 - b. deontologi
 - c. behaviorisme
 - d. positivism.
5. Teori etik yang menekankan manfaat terbesar adalah ...
 - a. virtue ethics
 - b. ethics of care
 - c. utilitarianisme
 - d. legalisme

Soal Uraian Singkat

1. Jelaskan perbedaan nilai, moral, dan etika dengan satu contoh klinis sederhana.
2. Mengapa perawat perlu memahami teori etik, bukan hanya aturan?
3. Berikan satu contoh keputusan klinis sederhana yang dapat dinilai menggunakan dua teori etik yang berbeda.

K. RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa praktik keperawatan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kemampuan membuat keputusan yang benar, manusiawi, dan profesional. Tiga konsep dasar yang penting dipahami mahasiswa adalah nilai, moral, dan etika. Nilai adalah keyakinan tentang apa yang dianggap penting atau berharga. Moral adalah standar benar–salah yang memandu perilaku manusia. Etika adalah kajian rasional tentang alasan di balik benar–salahnya suatu tindakan.

Dalam praktik keperawatan, nilai memengaruhi cara perawat memandang pasien dan pelayanan. Moral memengaruhi perilaku benar–salah dalam tindakan sehari-hari. Etika membantu perawat menganalisis situasi yang tidak sederhana, terutama ketika terjadi konflik antara kebutuhan klinis, keinginan pasien, keluarga, dan standar profesi.

Bab ini juga memperkenalkan empat teori etik utama yang relevan dalam keperawatan, yaitu deontologi, utilitarianisme, virtue ethics, dan ethics of care. Deontologi menekankan kewajiban dan prinsip. Utilitarianisme menekankan hasil atau manfaat terbesar. Virtue ethics menekankan pembentukan karakter profesional yang baik. Ethics of care menekankan hubungan, empati, dan kepedulian.

Mahasiswa perlu memahami bahwa dalam praktik nyata, keputusan yang baik sering kali tidak cukup hanya berdasarkan kebiasaan atau perasaan pribadi. Keputusan profesional harus didasarkan pada analisis yang rasional, aman, menghormati pasien, dan sesuai dengan tanggung jawab profesi. Oleh karena itu, bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami prinsip etik, kode etik, hak pasien, informed consent, privasi, keselamatan pasien, dan analisis kasus etik–hukum pada bab-bab selanjutnya.

Referensi

- Butts, J. B. (n.d.). *Ethics in Professional Nursing Practice*. 59–96.
- Fitria De Intan , Akhmad Faozi, D. D. (2024). *Correlation between Knowledge of the Nursing Code of Ethics and Non-Maleficence Behavior of Nurses in the Inpatient Room*. 7(1), 216–222. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v7i1.174>
- Huang, M., & Pham, T. (2024). *Psychometric validation of the nursing professional values scale-revised: Vietnamese version*. 19(4), 492–499.
- Li, J., & Li, X. (2024). Professional values education for undergraduate nursing students: developing a framework based on the professional values growth theory. *BMC Nursing*, 1–25. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01743-0>
- Nazari, A. M., Borhani, F., Zare-kaseb, A., Yousofvand, V., & Abbaszadeh, A. (2024). *The relationship between moral reasoning and nurses ' professional values in undergraduate nursing students: a descriptive-correlational study*.
- Poorchangizi, B., Borhani, F., Abbaszadeh, A., Mirzaee, M., & Farokhzadian, J. (2019). *The importance of professional values from nursing students ' perspective*. 1–7.
- Sari, D., Baysal, E., Celik, G. G., & Eser, I. (2018). *Ethical Decision Making Levels of Nursing Students*. 34(3).
- Shadi, A. Z., Zohreh, V., Eesa, M., & Anoshirvan, K. (2024). Moral sensitivity of nursing students: a systematic review. *BMC Nursing*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01713-6>
- Tedjomuljo, S., & Afifah, E. (2016). *TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEPERAWATAN TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN CARING*. 19(2), 129–136.
- Zhao, T., Chen, S., Dong, X., Lu, X., Chen, X., Li, H., Tang, S., Wen, S., & Liu, H. (2025). *The level of moral sensitivity among nurses: a systematic review and meta-analysis*.

BAB 3

PRINSIP ETIK KEPERAWATAN: AUTONOMY, BENEFICENCE, NONMALEFICENCE, JUSTICE, VERACITY, FIDELITY

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik-hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Prinsip Etik Keperawatan: Autonomy, Beneficence, Nonmaleficence, Justice, Veracity, Fidelity	3.1 Mengidentifikasi konflik prinsip etik dalam vignette klinis dan menetapkan prinsip prioritas.	3.2 Merumuskan keputusan berbasis prinsip dengan langkah mitigasi risiko dan komunikasi yang sesuai.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep teori/prinsip/kode etik dan ketepatan mengaitkan standar pada vignette.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus
CPMK-7	Proyek studi kasus + etik penelitian (review protokol)	Skor kualitas rekomendasi kasus (argumentasi, opsi, tindak lanjut) dan kepatuhan komponen perlindungan subjek (rubrik).	15	Laporan proyek; lembar review etik

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik-hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

Peta Konsep Bab

Pilar Moral Praktik (*Autonomy, Beneficence, Nonmaleficence, Justice, Veracity, Fidelity, Confidentiality*) → Identifikasi Dilema Etik → Analisis Kasus (Metode Sistematis) → Pengambilan Keputusan Klinis Etis.

A. Pendahuluan

Etika keperawatan merupakan fondasi moral yang membimbing perawat dalam setiap interaksi klinis. Kata etik berasal dari bahasa Yunani, "*Ethos*", yang berarti kebiasaan, model perilaku, atau standar. Dalam perspektif profesional, etika diartikan sebagai ilmu tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya (Riskika et al., 2022). Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling lama berada di sisi pasien wajib menerapkan prinsip moral ini untuk menjamin martabat dan keselamatan pasien. Prinsip etik bukan sekadar teori, melainkan aturan perilaku profesional yang tercantum dalam lafal sumpah dan kode etik perawat (Nasrullah, 2019).

B. Konsep Etik Keperawatan

1. Pengertian etik

Etik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti "kebiasaan", "model perilaku" atau "standar" dengan asal kata "*Ethos*", dengan kata lain etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya (Riskika et al., 2022).

Etik profesi merupakan prinsip moral atau asas yang harus diterapkan oleh perawat dalam hubungannya dengan pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya. Etik ini mengatur tentang perilaku profesional pada perawat dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam lafal sumpah dan kode etik perawat yang disusun organisasi profesional bersama pemerintah (Nasrullah, 2019).

2. Tipe etik

Etik terbagi ke dalam beberapa jenis tipe, yaitu (Riskika et al., 2022):

a. Bioetik

Merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik yang menyangkut masalah biologi dan pengobatan serta difokuskan lebih secara spesifik pada evaluasi etik pada moralitas treatment tertentu dan inovasi teknologi yang dikembangkan dan pelaksanaan treatment ini dilakukan pada manusia, artinya hal ini berfokus pada perawatan modern dan aplikasi pada teori dan prinsip etik terhadap masalah pelayanan kesehatan.

b. Etik Klinik

Merupakan bagian dari bioetik yang lebih berfokus pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien, misalnya pemberian persetujuan dan penolakan terhadap tindakan.

c. Etik Keperawatan

Merupakan bagian dari bioetik yang merupakan studi formal tentang isu etik pada keperawatan dan dikembangkan dalam tindakan keperawatan serta dievaluasi dan dianalisis untuk pengambilan keputusan etik.

3. Tujuan etik keperawatan

Mempelajari etika keperawatan khususnya pada perawat bertujuan agar para perawat dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dalam artian perawat dapat menghormati seluruh umat manusia yang menjadi kliennya tanpa terkecuali (Riskika et al., 2022)

4. Fungsi etika keperawatan

Etika keperawatan yang dipelajari memiliki fungsi yang sangat penting baik pada perawat dan setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan, antara lain (Riskika et al., 2022):

- a. Bertanggung jawab mengelola asuhan keperawatan
- b. Membantu perawat agar termotivasi untuk mengembangkan keilmuan dengan mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian yang kemudian hasilnya dapat digunakan dalam aplikasi di tatanan keperawatan pelayanan
- c. Membantu perawat agar berperan aktif dalam membantu klien untuk mandiri dalam menjaga kesehatannya
- d. Memotivasi perawat untuk semakin meningkatkan kapasitas keilmuan dengan melakukan dan menambah pengetahuan guna meningkatkan profesionalitas, integritas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima
- e. Memotivasi perawat agar bersikap yang sesuai dengan aturan yang tertuang dalam etika keperawatan
- f. Memacu perawat agar lebih responsif, produktif, dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya.

C. Prinsip-Prinsip Etik Keperawatan

1. Autonomy (Otonomi)

Otonomi adalah prinsip yang menghormati hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Perawat harus menghargai bahwa setiap pasien memiliki nilai-nilai dan kepercayaan pribadi yang unik (Mendri & Prayogi, 2017).

- a. Contoh Penerapan: Memberikan informasi lengkap sebelum pasien menandatangani *Informed Consent*.
- b. Pelanggaran & Sanksi:
 - Ringan: Tidak menjelaskan prosedur rutin (misal: pasang infus) secara detail.
 - Sanksi: Teguran lisan.

- Sedang: Mengabaikan keluhan pasien yang ingin menunda tindakan karena alasan pribadi. Sanksi: Peringatan tertulis.
- Berat: Memaksa pasien menjalani operasi atau tindakan invasif tanpa persetujuan (melanggar hak asasi). Sanksi: Rekomendasi pencabutan SIP sementara

2. Beneficence (Berbuat Baik)

Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi pasien dan mencegah kerugian. Fokus utama adalah kesejahteraan pasien di atas kepentingan lainnya (Berman et al., 2022).

a. Contoh Penerapan: Menyarankan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri selain dengan obat-obatan.

b. Pelanggaran & Sanksi:

- Ringan: Melakukan asuhan dengan terburu-buru sehingga pasien merasa tidak nyaman. Sanksi: Teguran.
- Sedang: Mengabaikan kebutuhan psikososial pasien yang sedang cemas berat. Sanksi: Pembinaan perilaku.
- Berat: Sengaja tidak memberikan asuhan yang dibutuhkan pasien (pembinaan) hingga kondisi pasien memburuk. Sanksi: Penundaan kenaikan pangkat/skorsing

3. Nonmaleficence (Tidak Merugikan)

Prinsip ini mewajibkan perawat untuk tidak menyebabkan cedera fisik atau psikologis. "Utama, jangan mencelakai" (*Primum Non Nocere*) adalah inti dari prinsip ini (Nasrullah, 2019).

a. Contoh Penerapan: Memeriksa identitas pasien dengan teliti sebelum memberikan obat (Prinsip 7 Benar).

b. Pelanggaran & Sanksi:

- Ringan: Lupa memasang pagar tempat tidur namun pasien tidak jatuh. Sanksi: Teguran lisan.
- Sedang: Salah memberikan dosis obat dosis rendah yang menyebabkan alergi ringan. Sanksi: Peringatan tertulis.
- Berat: Salah memberikan golongan darah saat transfusi atau salah menyuntikkan obat dosis tinggi yang menyebabkan kematian/cacat. Sanksi: Pencabutan SIP dan sidang disiplin.

4. Justice (Keadilan)

Keadilan menekankan pada pembagian beban dan manfaat secara merata kepada seluruh pasien tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau agama (Mendri & Prayogi, 2017).

a. Contoh Penerapan: Membagi waktu kunjungan perawat berdasarkan tingkat keparahan penyakit pasien, bukan berdasarkan kelas kamar.

b. Pelanggaran & Sanksi:

- Ringan: Lebih ramah kepada pasien keluarga pejabat daripada pasien umum. Sanksi: Teguran.
- Sedang: Mengistimewakan antrean pasien tertentu tanpa indikasi medis yang darurat. Sanksi: Peringatan tertulis.
- Berat: Menolak memberikan pelayanan kegawatdaruratan kepada pasien miskin/tanpa identitas hingga meninggal. Sanksi: Pemberhentian tidak hormat.

5. Veracity (Kejujuran)

Veracity adalah kewajiban untuk menyampaikan kebenaran secara akurat dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada pasien (Riskika et al., 2022).

a. Contoh Penerapan: Menjelaskan secara jujur efek samping dari obat kemoterapi.

b. Pelanggaran & Sanksi:

- Ringan: Memberikan janji palsu tentang waktu kedatangan dokter. Sanksi: Teguran.
- Sedang: Menutupi kesalahan kecil dalam dokumentasi asuhan. Sanksi: Peringatan tertulis.
- Berat: Berbohong mengenai hasil diagnosis fatal atau menutupi malpraktik yang terjadi. Sanksi: Pencabutan izin praktik.

6. Fidelity (Menepati Janji)

Prinsip kesetiaan terhadap janji dan komitmen profesional yang telah dibuat, baik kepada pasien maupun kepada profesi (Potter et al., 2021).

a. Contoh Penerapan: Datang kembali ke kamar pasien tepat waktu sesuai janji untuk membantu mobilisasi.

b. Pelanggaran & Sanksi:

- Ringan: Sering terlambat memberikan tindakan yang sudah dijanjikan. Sanksi: Teguran.
- Sedang: Membicarakan kondisi kesehatan pasien di area publik (kantin/lift). Sanksi: Peringatan tertulis.
- Berat: Membocorkan data medis pasien ke pihak luar/media tanpa izin untuk keuntungan pribadi. Sanksi: Pemecatan dan sanksi hukum.

7. Confidentiality (Kerahasiaan)

Prinsip menjaga privasi informasi pasien yang diperoleh selama proses perawatan. Informasi hanya boleh dibagikan kepada tim medis yang relevan (Komite Keperawatan, 2017).

- a. Contoh Penerapan: Tidak membicarakan diagnosis pasien di area publik, mengamankan rekam medis elektronik dengan kata sandi, dan menutup tirai saat melakukan tindakan.
- b. Pelanggaran & Sanksi:
 - Ringan: Membiarkan status pasien (papan nama diagnosa) terlihat oleh pengunjung lain. Sanksi: Teguran lisan.
 - Sedang: Membagikan foto pasien di media sosial meskipun identitas wajah ditutup namun lokasi rumah sakit terlihat. Sanksi: Peringatan tertulis dan pembinaan etika.
 - Berat: Membocorkan rekam medis pasien publik figur kepada media massa secara sengaja. Sanksi: Pencabutan SIP dan pemutusan hubungan kerja

D. Dilema Etik dan Pengambilan Keputusan

Dalam praktik nyata, perawat sering menghadapi situasi di mana dua prinsip etik berbenturan. Berikut adalah analisis dilema dan panduan keputusan etis di berbagai unit pelayanan:

1. Ruang Gawat Darurat (IGD)

- Dilema: *Justice vs Beneficence*.
- Kasus: Terdapat dua pasien datang bersamaan: satu pasien kecelakaan dengan trauma kepala berat (harapan hidup kecil) dan satu pasien serangan jantung (harapan hidup besar jika segera ditangani), sementara tim medis sangat terbatas.
- Keputusan Tepat: Perawat harus melakukan Triage berdasarkan prinsip *Utility* (manfaat terbesar untuk jumlah orang terbanyak). Pasien dengan peluang keselamatan lebih tinggi dan kegawatan yang bisa diintervensi segera diprioritaskan tanpa mengabaikan kenyamanan pasien lainnya.

2. Ruang Kritis (ICU/ICCU)

- Dilema: *Autonomy vs Nonmaleficence* (Isu *Do Not Resuscitate* / DNR).
- Kasus: Keluarga meminta mesin ventilator dilepas karena biaya sudah habis, namun pasien secara klinis masih memiliki peluang meskipun kecil.
- Keputusan Tepat: Perawat memfasilitasi pertemuan antara dokter, keluarga, dan Komite Etik RS. Keputusan tidak boleh diambil sepihak. Jika pasien memiliki *Advanced Directive* (pesan tertulis sebelumnya), maka hak otonomi

pasien harus diutamakan selama tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia (UU Kesehatan No. 17/2023).

3. Unit Hemodialisa

- Dilema: *Nonmaleficence vs Autonomy*.
- Kasus: Pasien gagal ginjal kronis menolak tindakan hemodialisa karena sudah merasa lelah dengan prosedur rutin, padahal jika tidak cuci darah, racun dalam tubuh akan meningkat drastis (uremia).
- Keputusan Tepat: Perawat melakukan edukasi terapeutik mengenai risiko tanpa paksaan. Jika pasien tetap menolak setelah diberi penjelasan lengkap (Informed Dissent), perawat menghormati otonomi pasien namun wajib mendokumentasikannya secara lengkap di rekam medis untuk perlindungan hukum.

4. Ruang Rawat Inap Dewasa

- Dilema: *Veracity vs Beneficence*.
- Kasus: Pasien bertanya tentang hasil biopsi yang menunjukkan tumor ganas, namun dokter belum menyampaikan dan keluarga melarang perawat memberitahu karena pasien memiliki riwayat serangan jantung jika kaget.
- Keputusan Tepat: Perawat tidak boleh berbohong (Veracity). Jawaban terbaik adalah: *"Hasil sudah ada pada dokter, mari kita jadwalkan pertemuan bersama dokter dan keluarga siang ini agar Ibu mendapatkan penjelasan yang utuh."* Ini menjaga kejujuran tanpa melampaui wewenang medis.

5. Keperawatan Anak

- Dilema: *Autonomy (Orang Tua) vs Beneficence (Anak)*.
- Kasus: Orang tua menolak anaknya diberi imunisasi atau transfusi darah karena keyakinan tertentu, padahal nyawa anak terancam.
- Keputusan Tepat: Perawat melakukan advokasi terhadap hak anak untuk hidup sehat. Sesuai UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan, kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas utama. Perawat dapat melibatkan tim perlindungan anak atau dinas sosial jika mediasi buntu.

6. Keperawatan Maternitas

- Dilema: *Autonomy vs Nonmaleficence*.
- Kasus: Seorang ibu ingin melahirkan normal di rumah meskipun memiliki riwayat *Seksio Sesarea* (SC) sebelumnya (VBAC berisiko tinggi), yang berpotensi menyebabkan ruptur uteri.
- Keputusan Tepat: Perawat memberikan penjelasan mengenai risiko kematian ibu dan janin secara detail. Mengarahkan ibu untuk memilih tempat bersalin dengan fasilitas operasi darurat demi prinsip *Nonmaleficence* (mencegah bahaya).

7. Keperawatan Jiwa

- Dilema: *Autonomy vs Beneficence (Restraint)*.
- Kasus: Pasien skizofrenia mengamuk dan membahayakan pasien lain serta staf. Perawat harus melakukan pengikatan (*restraint*).
- Keputusan Tepat: Kebebasan individu (*Autonomy*) dapat dibatasi demi keamanan bersama (*Beneficence*). Pengikatan dilakukan hanya sebagai jalan terakhir, dalam waktu sesingkat mungkin, dan dengan pemantauan ketat setiap 15-30 menit.

8. Keperawatan Keluarga & Komunitas

- Dilema: *Confidentiality vs Justice (Public Safety)*.
- Kasus: Perawat mengetahui seorang kepala keluarga menderita penyakit menular (seperti TBC paru aktif) namun menolak berobat dan melarang perawat memberitahu warga atau anggota keluarga lain karena malu.
- Keputusan Tepat: Kerahasiaan (*Confidentiality*) memiliki batas jika membahayakan keselamatan publik (*Justice*). Perawat wajib melaporkan kasus ini ke Puskesmas/Dinas Kesehatan untuk upaya tracing dan pencegahan penularan masal, sesuai protokol kesehatan masyarakat.

E. Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan Etis

Untuk menyelesaikan dilema di atas, perawat disarankan menggunakan model sistematis:

1. Pengkajian Fakta: Kumpulkan data klinis, keinginan pasien, nilai budaya, dan faktor legal.
2. Identifikasi Masalah Etik: Tentukan prinsip etik apa saja yang bertabrakan.
3. Pertimbangkan Opsi: Apa yang terjadi jika opsi A diambil? Apa dampaknya bagi keselamatan pasien?
4. Aplikasi Teori Etik: Gunakan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 sebagai landasan hukum dan Kode Etik PPNI sebagai panduan moral.
5. Implementasi & Evaluasi: Laksanakan keputusan yang paling meminimalkan risiko bahaya dan paling menghargai martabat pasien.

F. Penegakan Etik dan Disiplin

Regulasi terbaru melalui UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan pada mekanisme penegakan disiplin dan etik bagi tenaga kesehatan.

1. Lembaga Berwenang: Sidang dugaan pelanggaran etik dan disiplin kini dilakukan secara integratif oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).
2. Mekanisme Pelaksanaan Sidang:
 - a. Pengaduan: Pasien atau masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Majelis.
 - b. Investigasi: Pembentukan tim ahli untuk mencari bukti dan fakta medis di lapangan.
 - c. Sidang Disiplin: Pemeriksaan tertutup dimana perawat diberikan hak untuk membela diri dengan pendampingan dari organisasi profesi (PPNI).
 - d. Sanksi: Putusan dapat berupa kewajiban mengikuti pendidikan tambahan, teguran, hingga pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

G. Peran Stakeholder Dalam Pencegahan Pelanggaran Etik

Tabel 3. 1 Peran stake holder dalam pencegahan pelanggaran etik

Stakeholder	Peran Utama
Perawat	Refleksi diri dan peningkatan kompetensi etik berkelanjutan.
PPNI	Menyusun standar kode etik dan memberi advokasi hukum/etik.
Komite Etik RS	Pembinaan internal dan mediator konflik etik di rumah sakit.
Majelis Disiplin	Memberikan sanksi tegas bagi pelanggar untuk menjaga muruah profesi.

Aktivitas Belajar Terstruktur

Aktivitas 1:

1. Seorang pasien menolak pemasangan kateter karena merasa malu, namun perawat tetap memasangnya secara paksa tanpa penjelasan lebih lanjut. Prinsip etik utama apa yang dilanggar perawat tersebut?
2. Siapakah lembaga yang berwenang melakukan sidang disiplin bagi perawat menurut UU No. 17 Tahun 2023?
3. Sebutkan contoh pelanggaran etik kategori berat dalam prinsip *Confidentiality*!

Jawaban:

1. Autonomy (Otonomi) – Karena perawat tidak menghormati hak pasien untuk menolak tindakan dan mengabaikan persetujuan pasien.
2. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang merupakan bagian dari KTKI.

3. Mengunggah data medis atau foto pasien ke media sosial tanpa izin, atau membocorkan rahasia penyakit pasien publik figur kepada media massa.

Aktivitas 2:

Analisis Kasus (Case-Based Learning)

Tugas: Membuat Laporan Analisis Kasus Etik (Produk untuk CPMK-2)

Skenario Kasus: Seorang pasien lansia menderita tumor ganas stadium lanjut. Dokter belum menyampaikan hasil diagnosis secara utuh karena keluarga melarang, khawatir pasien terkena serangan jantung akibat kaget. Namun, pasien terus bertanya secara detail mengenai kondisinya kepada perawat jaga.

Instruksi Pengerjaan (Struktur Laporan): Mahasiswa wajib menyusun laporan (150-200 kata per bagian) dengan poin-poin berikut:

1. Identifikasi Konflik: Jelaskan prinsip etik apa yang bertabrakan (Contoh: *Veracity* vs *Beneficence*).
2. Justifikasi Opsi: Berikan minimal 2 opsi tindakan beserta konsekuensinya.
3. Keputusan Akhir: Tentukan tindakan yang paling menghargai martabat pasien dan meminimalkan risiko bahaya.
4. Refleksi Diri: Sikap profesional apa yang Anda pelajari dari kasus ini?

Instrumen Penilaian (Rubrik CPMK-2)

Indikator Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi Konflik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru.	Konflik teridentifikasi sebagian.	Konflik teridentifikasi tepat.	Sangat tepat dan komprehensif.
Kualitas Justifikasi	Tanpa kerangka; alasan lemah.	Kerangka ada; opsi terbatas.	Kerangka jelas; opsi memadai.	Kerangka kuat; mitigasi risiko sangat jelas.

Laporan Analisis Kasus Etik (Format Mahasiswa)

1. Pengkajian Fakta Kasus

- Data Klinis: Pasien lansia dengan tumor ganas stadium lanjut.
- Inti Masalah: Keluarga melarang perawat memberitahu diagnosis karena riwayat serangan jantung pasien.
- Keinginan Pasien: Pasien terus bertanya secara aktif dan detail mengenai kondisi kesehatannya kepada perawat.

- Aspek Legal: UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 mengatur hak pasien atas informasi kesehatan mereka.

2. Identifikasi Konflik Prinsip Etik

Dalam kasus ini, terjadi benturan antara dua prinsip utama:

- *Veracity* (Kejujuran): Kewajiban perawat untuk menyampaikan kebenaran secara akurat kepada pasien yang bertanya langsung tentang diagnosisnya.
- *Beneficence* (Berbuat Baik) / *Nonmaleficence*: Keinginan keluarga untuk melindungi pasien dari syok psikologis (serangan jantung) yang dianggap sebagai bentuk "kasih sayang" atau upaya tidak mencelakai pasien.

3. Analisis Opsi dan Konsekuensi

- Opsi A: Memberitahu langsung saat itu juga.
 - *Konsekuensi*: Menghargai otonomi pasien, namun berisiko tinggi memicu kegawatan medis (serangan jantung) karena pasien belum siap secara psikologis.
- Opsi B: Berbohong atau mengatakan "tidak tahu".
 - *Konsekuensi*: Melanggar prinsip *Veracity*, merusak kepercayaan pasien terhadap perawat, dan melanggar hak pasien secara hukum.
- Opsi C: Memfasilitasi pertemuan kolaboratif (Opsi Terpilih).
 - *Konsekuensi*: Menjaga kejujuran tanpa melampaui wewenang medis dan meminimalkan risiko kesehatan.

4. Keputusan Etis dan Rencana Tindak Lanjut

Keputusan yang diambil adalah Opsi C, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Komunikasi Terapeutik: Memberikan jawaban jujur yang bersifat menjembatani: "Hasil sudah ada pada dokter, mari kita jadwalkan pertemuan bersama dokter dan keluarga siang ini agar Ibu mendapatkan penjelasan yang utuh".
- b. Kolaborasi: Menghubungi dokter dan tim medis untuk menyampaikan bahwa pasien sudah bertanya secara aktif (hak pasien).
- c. Mediasi: Memfasilitasi pertemuan antara dokter, perawat, dan keluarga untuk memberikan pengertian bahwa menyembunyikan informasi kronis secara permanen adalah pelanggaran hak, namun penyampaian harus dilakukan secara bertahap dan didampingi tim medis.

5. Refleksi Profesional

Melalui kasus ini, saya menyadari bahwa profesionalisme bukan hanya tentang kejujuran (*Veracity*), tetapi juga tentang ketepatan waktu dan cara penyampaian (*Beneficence*). Sebagai perawat, saya harus berperan sebagai Advocate (pembela hak pasien) sekaligus Collaborator yang baik agar keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.

Indikator Penilaian (Self-Check):

- a. Apakah konflik prinsip sudah jelas? Ya (*Veracity* vs *Beneficence*).
- b. Apakah ada rujukan regulasi? Ya (UU Kesehatan No. 17/2023).
- c. Apakah tindakan bersifat kolaboratif? Ya

Aktivitas 3:

Tugas Latihan Analisis Kasus Etik (Mandiri)

Topik: Penerapan Prinsip Etik dalam Praktik Klinis

Instruksi: Bacalah skenario di bawah ini dengan saksama, kemudian susunlah laporan analisis kasus sesuai dengan struktur yang telah dipelajari (Identifikasi Konflik, Justifikasi Opsi, Keputusan Etis, dan Refleksi).

Skenario Kasus: Dilema Transfusi Darah pada Pasien Anak

Seorang anak berusia 7 tahun dirawat di unit gawat darurat karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan perdarahan hebat. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kadar hemoglobin (Hb) anak tersebut sangat rendah dan dokter menetapkan bahwa pasien membutuhkan transfusi darah segera untuk menyelamatkan nyawanya.

Namun, kedua orang tua pasien menolak tindakan transfusi darah tersebut karena keyakinan agama yang mereka anut, yang melarang masuknya unsur darah orang lain ke dalam tubuh. Mereka memahami risiko kematian yang dihadapi anak mereka, tetapi tetap bersikeras untuk memilih pengobatan alternatif tanpa darah. Di sisi lain, dokter menyatakan bahwa tidak ada pengobatan alternatif yang cukup cepat untuk mengatasi kondisi kritis anak tersebut saat ini. Perawat merasa terjepit antara kewajiban menghormati keputusan orang tua sebagai wali sah (otonomi) dan kewajiban untuk menyelamatkan nyawa anak (berbuat baik).

Struktur Laporan yang Harus Dibuat Mahasiswa:

1. Identifikasi Konflik Prinsip Etik: Sebutkan minimal dua prinsip etik yang bertabrakan dalam kasus ini.
2. Analisis Opsi: Jelaskan apa yang terjadi jika perawat mengikuti keinginan orang tua vs jika perawat melakukan advokasi untuk tetap melakukan transfusi.
3. Landasan Hukum: Kaitkan keputusan Anda dengan regulasi yang berlaku di Indonesia (misalnya UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 atau UU Perlindungan Anak).
4. Keputusan Etis: Tentukan langkah konkret yang harus diambil perawat dalam situasi tersebut.

Rubrik Penilaian (RB-07. Analisis Kasus Etik)

Digunakan oleh dosen untuk menilai laporan mahasiswa (Skala 1–4).

Aspek Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Ketepatan Identifikasi Konflik (CPMK-2.1)	Gagal mengidentifikasi prinsip yang bertabrakan.	Mengidentifikasi satu prinsip dengan penjelasan terbatas.	Mengidentifikasi konflik prinsip dengan tepat.	Mengidentifikasi konflik secara komprehensif dan tajam.
Kualitas Justifikasi & Analisis (CPMK-2.2)	Pendapat bersifat subjektif tanpa dasar teori/etika.	Analisis ada namun opsi tindakan sangat terbatas.	Analisis logis dengan mempertimbangan konsekuensi setiap opsi.	Justifikasi sangat kuat, sistematis, dan berbasis prinsip moral yang kokoh.
Penggunaan Landasan Hukum/SOP	Tidak mencantumkan rujukan hukum atau kode etik.	Mencantumkan rujukan namun kurang relevan dengan kasus.	Merujuk pada UU Kesehatan atau Kode Etik PPNI secara tepat.	Mengintegrasikan rujukan hukum dan etik secara konsisten untuk memperkuat argumen.
Kualitas Rekomendasi / Solusi (CPMK-7.1)	Solusi tidak praktis atau membahayakan pasien.	Solusi ada namun langkah-langkahnya kurang jelas.	Solusi jelas, praktis, dan meminimalkan risiko bahaya.	Solusi komprehensif, mencakup aspek komunikasi, kolaborasi, dan mitigasi risiko.

Referensi

- Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2022). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing*. Pearson.
- Komite Keperawatan. (2017). *Buku Standar Kode Etik Keperawatan*. Padang: RSJ Sa'anin, Mendri, N. K., & Prayogi, A. S. (2017). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Baru Press.
- Nasrullah, D. (2019). *Etika Keperawatan*. Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Riskika, S., et al. (2022). *Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN SERTA PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Hak dan Kewajiban Pasien serta Perawat dalam Pelayanan Kesehatan	5.1 Mengidentifikasi hak pasien dan kewajiban perawat yang relevan pada kasus pelayanan.	5.2 Menentukan tindakan perlindungan hak pasien saat terjadi konflik kepentingan atau hambatan layanan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-1

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep teori/prinsip/kode etik dan ketepatan mengaitkan standar pada vignette.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus
CPMK-3	Simulasi informed consent/penolakan (OSCE) + checklist	Persentase elemen consent terpenuhi dan ketepatan langkah saat penolakan/kapasitas tidak adekuat (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; catatan skenario

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

A. Terminologi

1. Hak : Kekuasaan/ kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu.
2. Kewajiban : Sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum.
3. Pasien : setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
4. Klien : perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.

5. Perawat : seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Pelayanan Keperawatan : suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
7. Rumah Sakit : sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
8. Rumah Sakit : institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

B. Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 13 ayat 3 Undang Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit berbunyi setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Hak Pasien Menurut Undang Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 yaitu:

1. Mendapatkan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Anda terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter dan kelas perawatan tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
9. Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Mendapatkan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita.
12. Didampingi keluarga disaat kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perilaku Rumah Sakit terhadap pasien.
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 dalam Permenkes No. 4 tahun 2018 menyebutkan kewajiban pasien yaitu:

- a. mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
- c. menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit ;
- d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
- h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

C. Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 36 Undang Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 menyebutkan bahwa Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/ atau keluarganya.
3. menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan;
4. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban:

1. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
4. mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
5. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/ atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
6. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat; dan
7. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus Pasien:

Pasien laki-laki berusia 57 tahun dirawat hampir 2 minggu di RS dan mengatakan tengkuknya masih sakit, sering pusing, dan masih suka merasakan jantung berdebar-debar. Pasien nampak lemah dengan kondisi berbaring dan terlihat memegang kepalanya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital diketahui yaitu Tekanan darah 150/90 mmHg; Nadi 93 x/menit; Napas 20 x/menit; dan Suhu 38 °C. Pasien memiliki riwayat stroke 3 bulan yang lalu dan terdapat bekas luka jahitan di bagian perut akibat senjata tajam.

Tugas:

1. Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.
2. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi kondisi kesehatan pasien yang ada sesuai kasus tersebut?
2. Identifikasi dan elaborasi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi pasien?
3. Identifikasi hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan pasien tersebut?
4. Identifikasi kewajiban perawat relevan yang harus dilakukan sesuai kasus?
5. Identifikasi dan elaborasi informasi medis yang tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pasien?

Aktivitas 2 — Shows How

Beberapa tindakan perlindungan hak pasien saat terjadi konflik kepentingan atau hambatan layanan yaitu:

1. Mengenali Hak Pasien: Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan mereka, hak untuk membuat keputusan tentang pengobatan, dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
2. Mengidentifikasi Konflik Kepentingan: Konflik kepentingan dapat terjadi ketika ada kepentingan pribadi atau organisasi yang mempengaruhi keputusan medis. Pasien harus diberitahu jika ada konflik kepentingan.
3. Mencari Solusi: Jika terjadi konflik kepentingan atau hambatan layanan, pasien dapat mencari solusi dengan cara:
 - Berbicara dengan dokter atau tim kesehatan lain
 - Menghubungi komite etik keperawatan/ kedokteran

- Mengajukan komplain/ pelaporan kepada aparat hukum
- 4. Mendapatkan Dukungan: Pasien dapat meminta dukungan dari keluarga, teman, atau advokat.
- 5. Menggunakan Sistem Pengaduan: Rumah sakit harus memiliki sistem pengaduan yang efektif untuk menangani keluhan pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit sangat penting, terutama saat terjadi konflik kepentingan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa pasien mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa aspek perlindungan hak pasien yang perlu diperhatikan adalah:

- Hak untuk mendapatkan informasi: Pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan, termasuk diagnosis, prognosis, dan alternatif perawatan yang akan diterima.
- Hak untuk membuat keputusan: Pasien memiliki hak untuk membuat keputusan tentang perawatan, termasuk menolak atau menerima perawatan.
- Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas: Pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar medis.

Tabel 4. 1 Case Report pada Kegiatan Diskusi Kelompok

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien dengan Hipertensi
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa ketika praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien berusia 57 tahun yang dirawat dengan hipertensi yang memiliki hak dan kewajiban
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, faktor risiko	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang harus diberikan sebagai kewajiban

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien dengan Hipertensi
	yang terjadi dan pengembangan dari kasus yang ada	seorang perawat, dan menganalisis perkembangan kondisi pasien hipertensi
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus hipertensi, mahasiswa menuliskan identitas pasien, keluhan, masalah keperawatan yang terjadi, dan hal apa yang dipelajari dari kasus yang terjadi serta menuliskan hak dan kewajiban pasien dan perawat yang diterima dan dilakukan
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan identifikasi, relevansi analisis masalah, logika penalaran, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengelaborasi	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data dengan masalah yang terjadi; hak pasien yang diperoleh; kewajiban pasien yang harus dilakukan; ketepatan tindakan keperawatan yang harus dilakukan sebagai kewajiban perawat; dan menilai dampak jangka panjang yang akan terjadi akibat penyakit
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan situasi praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus hipertensi mahasiswa belajar bahwa terdapat hak dan kewajiban pasien dan perawat yang harus ditunaikan dan merupakan bagian sangat penting dalam pelayanan kesehatan/keperawatan
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep hak dan kewajiban pasien dan perawat, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien dengan Hipertensi
		menggambarkan pelayanan kesehatan/ keperawatan secara utuh.

D. RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa hak dan kewajiban pasien dan perawat telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat menerapkannya ketika melakukan praktik klinik yang akan berhadapan langsung dengan pasien.

Mahasiswa perlu memahami bahwa ada keinginan pasien yang bisa bertentangan dengan etika dan standar profesi. Tetapi, sebagai perawat yang memahami kewajibannya harus bisa memberikan pemahaman dan mencari alternatif pemecahannya jika terjadi konflik kepentingan atau terdapat hambatan dalam pelayanan. Terdapat banyak tantangan dalam implementasi perlindungan hak pasien, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak pasien dan kurangnya regulasi yang efektif dalam penanganannya ketika terjadi konflik kepentingan seperti mediasi, negosiasi dan litigasi (proses hukum).

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa pasien dan perawat memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus diketahui dan dipahami agar kualitas pelayanan kesehatan dan keperawatan dapat terwujud. Pemahaman yang baik terhadap hak-hak dan kewajiban ini penting agar pasien dapat berpartisipasi secara optimal dalam perawatan mereka sendiri.

Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali dan mengidentifikasi hak dan kewajiban pasien tetapi juga mampu mengidentifikasi kewajiban yang harus dilakukan seorang perawat seperti memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi pada keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran teori melalui studi kasus dan diskusi kelompok.

Tabel 4. 2 Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
ketidaktahuan pasien terhadap kewajiban	menyebabkan kesalahan dalam penyampaian informasi atau ketidaksesuaian antara harapan pasien dengan prosedur medis yang dijalani	pasien harus diberikan edukasi bahwa wajib memberi tahu dokter/ tenaga kesehatan tentang alergi atau riwayat penyakit sebelumnya (atau apapun terkait penyakit) yang dapat mempengaruhi pengobatan yang diberikan
mematuhi aturan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bersangkutan	menyebabkan kerugian pihak RS/ fasilitas kesehatan	pasien dan/ atau keluarga pasien harus mengetahui aturan administratif RS/ fasilitas kesehatan
pasien kurang paham mengenai hak-hak mereka	mendapatkan informasi yang lengkap mengenai prosedur medis dan tindakan keperawatan	sosialisasi dan edukasi hukum
di daerah terpencil, fasilitas kesehatan dan tenaga medis/ tenaga kesehatan yang tersedia terbatas	menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal dan memengaruhi implementasi hak pasien	memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai fasilitas yang ada dengan tetap memperhatikan respon klien dan memperbaiki distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai
dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak pasien	pengaturan hak dan kewajiban pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia telah diatur dalam undang-undang dan Permenkes	edukasi mencakup informasi mengenai hak-hak dasar pasien seperti informed consent, hak atas kerahasiaan informasi medis, serta kewajiban pasien dalam menjalani perawatan.
pasien memiliki keinginan yang bertentangan dengan etika dan standar profesi	pasien memberikan keterangan palsu, berlaku curang, meminta aborsi ilegal, meminta euthanasia	memberikan penjelasan dan edukasi serta konsekuensi hukum yang terjadi jika melanggar kode etik

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
komunikasi tidak efektif dalam kondisi tertentu	menghambat penyampaian informasi yang cukup kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya dan opsi perawatan yang akan diberikan	pelibatan keluarga atau wali pasien sebagai sumber informasi tambahan atau penerima informasi dari perawat dan penggunaan teknologi komunikasi seperti telekonferensi/ video call

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Diskusi : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian hak dan kewajiban pasien	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi hak pasien	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi kewajiban pasien	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi hak perawat	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi kewajiban perawat	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi perlindungan hak pasien jika terjadi masalah	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Al-Irfani, A.W., & Yusuf, H. (2025). Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia. *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2 (1): 1415-1422. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Damayanti, S., & Maradona. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu. *Unes Law Review*, 6 (2): 7406-7417. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Irawati, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Keadaan Urgensi di Rumah Sakit Patria IKKT: Analisis Terhadap Hak-Hak Pasien dan Tanggung Jawab Pihak Medis. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10 (1): 153-166. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.10.1.153-166.2024>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>
- Kemenkes. (2020). *Standar Profesi Perawat*. Jakarta: Sekretariat KTKI.
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN.
- Primadita, A. (2020). Tanggung Jawab Hukum Perawat terhadap Hak-Hak Klien dalam Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. *Jurnal JURISTIC*, 1 (1): 67-80. <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1483>.
- Riasari, R.H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perawat pada RS berdasarkan UU nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (10): 946-960. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/79>
- Saputra, M.P. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Menjalankan Pelimpahan Kewenangan dari Tenaga Medis Dokter. *Journal of Professional Nursing (JPN)*, 1 (1): 22-32. <https://journal.univummibogor.ac.id/index.php/JPN>
- Secillia, B.A., Maranatha, F.S., Hartanti, N.A., & Yuniarti. (2025). Analisis Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Praktik Keperawatan di Indonesia. *Jurnal Siti Rufaidah*, 3 (2): 38-48. DOI : <https://doi.org/10.57214/jasira.v3i2.182>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI.(2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Definisi dan Indikator Diagnostik*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI.(2018).*Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Definisi dan Tindakan Keperawatan*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI.(2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.

Tim Pokja DPP PPNI.(2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.

BAB 5

INFORMED CONSENT, PENOLAKAN, TINDAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KLINIS

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep etik dan hukum keperawatan, profesionalisme, akuntabilitas, serta standar praktik sebagai dasar pelayanan.	CPMK-1; CPMK-5
CPL-2	Mampu menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis untuk pengambilan keputusan klinis secara etis dan beralasan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Mampu menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien dan perawat, termasuk informed consent dan penolakan tindakan dalam praktik.	CPMK-3; CPMK-5
CPL-4	Mampu menjaga kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan (termasuk etika digital) sesuai regulasi dan standar layanan.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dalam layanan keperawatan.	CPMK-6; CPMK-5
CPL-6	Mampu menerapkan etika penelitian, melakukan analisis kasus etik–hukum, serta refleksi profesional untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7; CPMK-1

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan dasar etik dan hukum keperawatan, teori etik, prinsip etik, kode etik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam praktik.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etik dan kerangka analisis etik untuk pengambilan keputusan klinis termasuk isu akhir hayat dan populasi khusus.
CPMK-3	Menerapkan aspek hukum hak–kewajiban pasien/perawat, informed consent, penolakan tindakan, dan pengambilan keputusan klinis sesuai ketentuan.
CPMK-4	Menerapkan perlindungan kerahasiaan, privasi, dan keamanan data kesehatan termasuk etika digital dan tata kelola akses informasi.
CPMK-5	Menerapkan aspek hukum dokumentasi keperawatan dan tanggung gugat profesi melalui dokumentasi yang benar, lengkap, dan dapat diaudit.
CPMK-6	Menerapkan keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan insiden, serta pencegahan kelalaian/malpraktik dan disiplin profesi berbasis standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menganalisis kasus etik–hukum dan etika penelitian keperawatan untuk menghasilkan rekomendasi, argumen profesional, dan rencana tindak lanjut.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Informed Consent, Penolakan Tindakan, dan Pengambilan Keputusan Klinis	6.1 Menetapkan kelengkapan elemen persetujuan tindakan (informasi, kapasitas, voluntaritas) pada skenario.	6.2 Menentukan langkah saat penolakan tindakan/ketidakmampuan mengambil keputusan, termasuk dokumentasi dan rujukan.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-5

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Analisis kasus etik (case-based)	Skor ketepatan identifikasi konflik prinsip dan kualitas justifikasi keputusan berbasis kerangka analisis (rubrik).	20	Laporan analisis kasus
CPMK-3	Simulasi informed consent/penolakan (OSCE) + checklist	Persentase elemen consent terpenuhi dan ketepatan langkah saat penolakan/kapasitas tidak adekuat (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; catatan skenario
CPMK-5	Penilaian dokumentasi (audit catatan) + rubrik	Skor kelengkapan legal dokumentasi (kronologi, objektivitas, koreksi benar) dan konsistensi bukti pendukung.	15	Sampel dokumentasi; lembar audit

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep etik–hukum (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan mengaitkan kode etik/standar pada vignette	Tidak relevan/keliru	Relevan sebagian; rujukan kurang tepat	Relevan; rujukan tepat	Sangat relevan; rujukan tepat dan konsisten di berbagai situasi

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi konflik prinsip etik	Konflik tidak teridentifikasi/keliru	Konflik teridentifikasi sebagian	Konflik teridentifikasi tepat	Konflik teridentifikasi sangat tepat dan komprehensif
2.2 Kualitas justifikasi keputusan (kerangka analisis)	Tanpa kerangka; alasan lemah	Kerangka ada; opsi/konsekuensi terbatas	Kerangka jelas; opsi dan konsekuensi memadai	Kerangka sangat kuat; opsi komprehensif, mitigasi jelas, konsisten dengan nilai pasien

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan elemen informed consent (checklist)	≤60% elemen terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; elemen penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan langkah pada penolakan/kapasitas tidak adekuat	Langkah keliru; dokumentasi tidak ada	Langkah cukup; dokumentasi belum lengkap	Langkah tepat; dokumentasi jelas	Langkah sangat tepat; dokumentasi sangat lengkap dan rujukan/eskalasi sesuai

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan identifikasi risiko pelanggaran privasi	Risiko utama tidak teridentifikasi	Risiko teridentifikasi sebagian	Risiko utama teridentifikasi tepat	Risiko teridentifikasi komprehensif dan terprioritas
4.2 Kualitas rencana kontrol akses/etika digital	Tidak operasional; tanpa mitigasi	Operasional sebagian; indikator lemah	Operasional; mitigasi jelas	Sangat operasional; mitigasi komprehensif + indikator pemantauan kepatuhan jelas

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kelengkapan legal dokumentasi (audit)	Banyak komponen hilang; tidak dapat diaudit	Komponen inti ada; masih ada kekurangan bermakna	Lengkap; kekurangan minor	Sangat lengkap; ringkas, kronologis, dapat diaudit

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan praktik koreksi dan objektivitas catatan	Koreksi tidak sesuai; catatan subjektif	Koreksi sebagian benar; objektivitas belum konsisten	Koreksi benar; objektif	Koreksi sangat benar; objektif konsisten dan bukti pendukung kuat

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan klasifikasi risiko & prioritas mitigasi	Risiko salah; prioritas keliru	Risiko cukup tepat; prioritas kurang jelas	Risiko tepat; prioritas jelas	Risiko sangat tepat; prioritas tajam berbasis dampak–probabilitas
6.2 Kualitas rencana pencegahan berbasis RCA & indikator audit	Rencana umum; tanpa indikator	Rencana ada; indikator belum jelas	Rencana spesifik; indikator terukur	Rencana sangat spesifik; indikator komprehensif (baseline–target–cara ukur) + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas rekomendasi kasus etik–hukum (argumentasi)	Argumentasi lemah; tidak berbasis data/standar	Argumentasi cukup; opsi terbatas	Argumentasi kuat; opsi dan tindak lanjut jelas	Argumentasi sangat kuat; opsi komprehensif, risiko–mitigasi jelas, konsisten standar
7.2 Kepatuhan komponen perlindungan subjek penelitian (review)	Komponen kunci tidak ada; risiko tidak dinilai	Komponen ada; penilaian risiko terbatas	Komponen lengkap; penilaian risiko jelas	Komponen sangat lengkap; penilaian manfaat–risiko kuat + langkah perlindungan dan monitoring jelas

A. Pendahuluan

Keselamatan, mutu dan pertanggungjawaban pelayanan kesehatan sangat bergantung pada kualitas proses pengambilan keputusan klinis yang menjunjung tinggi hak pasien serta berlandaskan prinsip etika dan ketentuan hukum. Dalam praktik keperawatan kontemporer, informed consent tidak dapat dipersempit sebagai sekadar kelengkapan administrasi, melainkan harus dipahami sebagai rangkaian komunikasi profesional yang menentukan keabsahan tindakan keperawatan dan perlindungan keselamatan pasien. Meningkatnya kompleksitas kasus klinis, ketidakpastian hasil terapi, serta kesadaran masyarakat terhadap hak kesehatan menjadikan informed consent sebagai komponen fundamental dalam hubungan terapeutik antara perawat, pasien, dan keluarga.

Pelaksanaan informed consent berlangsung dalam situasi yang kerap ditandai oleh ketimpangan informasi, keterbatasan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatan, serta tekanan psikologis akibat penyakit yang dihadapi. Pada saat yang sama, perawat dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan asuhan yang cepat, akurat, dan sesuai standar profesi. Kondisi tersebut menempatkan perawat pada posisi yang menuntut tidak hanya keterampilan klinis, tetapi juga kemampuan komunikasi yang efektif, kepekaan etik, serta pemahaman aspek hukum agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pilihan pasien secara sadar dan bertanggung jawab.

Hak pasien untuk menolak tindakan merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap otonomi individu. Namun, dalam praktik klinis, penolakan tindakan sering kali menimbulkan persoalan etik dan implikasi hukum, khususnya ketika keputusan tersebut berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien. Perawat berada dalam posisi strategis sekaligus dilematis karena harus menjaga keseimbangan antara kewajiban profesional untuk melindungi pasien, penghormatan terhadap keputusan pasien atau keluarga, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar praktik keperawatan.

Pengambilan keputusan klinis dalam keperawatan tidak dapat dilepaskan dari dimensi etik dan hukum yang melekat pada setiap tindakan profesional. Setiap keputusan terkait pemberian, penundaan, maupun penghentian asuhan keperawatan membawa konsekuensi moral dan yuridis. Ketidaktepatan dalam mengelola informed consent dan penolakan tindakan berpotensi memicu konflik, sengketa hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi perawat dalam pengambilan keputusan klinis yang reflektif, etis, dan berbasis bukti menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan ditandai oleh kompleksitas kasus yang meningkat, praktik kolaborasi antarprofesi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam situasi ini, perawat dituntut berperan sebagai pendamping pasien, fasilitator proses pengambilan keputusan, dan penjaga nilai-nilai etik dalam praktik klinis. Pemahaman yang komprehensif mengenai batas kewenangan, tanggung jawab hukum, serta konsekuensi etik dari setiap tindakan menjadi bagian penting dari profesionalisme perawat.

Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan yang mengintegrasikan prinsip etik keperawatan, kerangka hukum kesehatan, dan dinamika praktik klinis. Pembahasan meliputi konsep dan penerapan informed consent, penolakan tindakan, serta pengambilan keputusan klinis dalam keperawatan, disertai analisis dilema etik dan contoh kasus yang merepresentasikan

kondisi nyata di lapangan. Setiap bab dirancang untuk mendorong pengembangan kemampuan analitis, refleksi etik, dan pertimbangan hukum dalam praktik keperawatan.

Secara keseluruhan, buku ini bertujuan memperkuat kapasitas perawat dalam mengelola informed consent, menyikapi penolakan tindakan, serta mengambil keputusan klinis secara profesional, etis, dan bertanggung jawab secara hukum. Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi dosen, mahasiswa, dan praktisi keperawatan dalam membangun praktik yang menjunjung martabat manusia, melindungi keselamatan pasien, serta memperkuat integritas profesi keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan.

B. Konsep Dasar Informed Consent

1. Pengertian

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau pihak yang berwenang setelah memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami mengenai tindakan medis atau keperawatan yang akan dilakukan. Persetujuan ini tidak hanya berupa tanda tangan pada formulir, tetapi merupakan suatu proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan memastikan bahwa pasien memahami manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil. Konsep informed consent berakar pada prinsip penghormatan terhadap otonomi pasien, yang menempatkan individu sebagai pihak yang memiliki hak untuk menentukan pilihan terhadap tubuh dan kesehatannya sendiri. Setiap tindakan medis atau keperawatan harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun manipulasi. Kondisi ini menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk menerima atau menolak tindakan setelah memahami informasi yang diberikan secara adekuat (Basukala et al., 2023; Ediit, 2022).

Informed consent juga mencerminkan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan dalam memberikan informasi yang jujur, akurat, dan transparan. Informasi yang disampaikan mencakup diagnosis, tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, risiko dan manfaat, alternatif tindakan, serta kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Proses ini menuntut kemampuan komunikasi yang efektif agar informasi dapat dipahami oleh pasien dengan berbagai latar belakang pendidikan, budaya, dan kondisi psikologis. Perspektif hukum menempatkan informed consent sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pasien sekaligus perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam praktik profesional. Ketidadaan informed consent yang sah dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum,

termasuk tuduhan malpraktik atau tindakan tanpa izin. Oleh karena itu, pelaksanaan informed consent harus memenuhi unsur-unsur penting seperti kompetensi pasien, pemberian informasi yang adekuat, pemahaman, serta persetujuan yang diberikan secara sukarela (Kristin et al., 2022; Leclercq et al., 2013; Negash, 2020).

Pemahaman yang komprehensif mengenai informed consent menjadi dasar penting dalam praktik keperawatan, khususnya dalam situasi kedaruratan dan krisis. Kondisi tersebut sering kali melibatkan keterbatasan waktu, tekanan emosional, dan ketidakpastian, sehingga perawat perlu tetap memastikan bahwa prinsip informed consent dijalankan secara etis dan profesional. Implementasi yang tepat tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kualitas hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan.

2. Tujuan informed consent

Informed consent bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan medis dan keperawatan dilakukan dengan menghormati hak otonomi pasien melalui pemberian informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami sehingga pasien mampu mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

Tujuan informed consent meliputi:

- a. Menjamin hak otonomi pasien dalam menentukan pilihan terhadap tindakan kesehatan yang akan dijalani.
- b. Meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga.
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan dalam praktik profesional.
- d. Meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*) melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan perawatan.

Pemahaman terhadap tujuan tersebut menjadi dasar penting dalam praktik keperawatan, khususnya dalam situasi kedaruratan dan krisis yang menuntut komunikasi efektif, etis, dan profesional (Ediit, 2022; Kristin et al., 2022).

3. Informed consent sebagai hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan

Informed consent merupakan wujud penghormatan terhadap hak pasien sekaligus menjadi kewajiban profesional tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan. Hak pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan keputusan atas tindakan yang akan dilakukan mencerminkan prinsip otonomi, sedangkan kewajiban tenaga kesehatan berkaitan dengan tanggung jawab etik dan hukum dalam memberikan informasi yang adekuat, jujur, dan dapat dipahami (Giacobello & Marcos, 2025; Lawongsa, 2025; Pallocci et al., 2023).

Informed consent sebagai hak pasien menurut (Giacobello & Marcos, 2025; Lawongsa, 2025; Pallocci et al., 2023) meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh informasi lengkap mengenai kondisi kesehatan, tindakan, risiko, dan alternatif.
- b. Hak untuk menerima atau menolak tindakan secara sukarela tanpa paksaan.
- c. Hak untuk mendapatkan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai kondisi pasien.

Informed consent sebagai kewajiban tenaga kesehatan meliputi:

- a. Kewajiban memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan.
- b. Kewajiban memastikan pasien memahami informasi sebelum memberikan persetujuan.
- c. Kewajiban menghormati keputusan pasien dan mendokumentasikan persetujuan secara tepat.

Pemahaman terhadap posisi *informed consent* sebagai hak dan kewajiban memperkuat praktik keperawatan yang berlandaskan etik, hukum, dan keselamatan pasien (Giacobello & Marcos, 2025; Lawongsa, 2025; Pallocci et al., 2023).

4. Prinsip-prinsip etik dalam informed consent

Pelaksanaan *informed consent* didasarkan pada prinsip-prinsip etik yang menjadi landasan dalam praktik keperawatan profesional. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses pemberian informasi dan persetujuan dilakukan secara menghormati hak pasien, memberikan manfaat, serta menjaga integritas pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip etik dalam *informed consent* menurut (Varkey, 2021; Wong et al., 2025) meliputi:

a. Otonomi

Prinsip otonomi menekankan hak pasien untuk menentukan keputusan terkait tindakan kesehatan yang akan dijalani. Pasien memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak tindakan setelah memperoleh informasi yang memadai tanpa adanya paksaan.

b. Beneficence

Prinsip *beneficence* mengarahkan tenaga kesehatan untuk bertindak demi kebaikan pasien. Informasi yang diberikan dalam *informed consent* harus bertujuan membantu pasien memperoleh manfaat terbaik dari tindakan yang direncanakan.

c. Non-maleficence

Prinsip *non-maleficence* menekankan kewajiban untuk tidak menimbulkan bahaya. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis.

d. Justice

Prinsip keadilan menuntut tenaga kesehatan memberikan informasi dan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi. Setiap pasien berhak memperoleh penjelasan yang sama sesuai kebutuhan dan kondisinya.

e. Veracity dan fidelity

Prinsip veracity berkaitan dengan kejujuran dalam penyampaian informasi, sedangkan fidelity menekankan komitmen tenaga kesehatan dalam menjaga kepercayaan pasien. Kedua prinsip ini penting untuk membangun hubungan terapeutik yang kuat dan profesional.

Penerapan prinsip-prinsip etik tersebut memastikan bahwa informed consent tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi merupakan proses komunikasi yang bermakna dan berorientasi pada kepentingan pasien.

5. Informed consent dalam perspektif hukum kesehatan

Informed consent dalam perspektif hukum kesehatan merupakan dasar legal yang mengatur keabsahan tindakan medis dan keperawatan. Persetujuan pasien yang diberikan setelah menerima informasi yang memadai menjadi bukti bahwa tindakan dilakukan secara sah, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Keabsahan *informed consent* tidak hanya ditentukan oleh adanya tanda tangan, tetapi harus memenuhi unsur dan syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Ketiadaan unsur tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum seperti tindakan tanpa izin atau kelalaian. Unsur dan syarat sah *informed consent* meliputi:

a. Kompetensi dan kapasitas pengambilan keputusan pasien

Pasien harus memiliki kemampuan secara hukum dan mental untuk memahami informasi dan membuat keputusan secara rasional.

b. Kecukupan informasi (diagnosis, tindakan, risiko, manfaat, alternatif)

Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan relevan agar pasien dapat mempertimbangkan pilihan secara tepat.

c. Pemahaman pasien terhadap informasi

Pasien harus benar-benar memahami informasi yang diberikan, bukan sekadar menerima tanpa mengerti maknanya.

d. Kesukarelaan tanpa paksaan

Persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, atau manipulasi dari pihak manapun.

e. Dokumentasi informed consent

Persetujuan harus dicatat secara tertulis sebagai bukti legal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Pemenuhan unsur dan syarat tersebut memastikan bahwa *informed consent* memiliki kekuatan hukum yang sah serta melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan dalam praktik keperawatan yang profesional.

C. Bentuk dan Prosedur Informed Consent

Informed consent dalam praktik pelayanan kesehatan memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kondisi klinis, jenis tindakan, serta situasi pasien. Pemahaman terhadap bentuk dan prosedur *informed consent* menjadi penting agar proses persetujuan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif secara komunikasi dan etis dalam praktik keperawatan. Bentuk *informed consent* menurut (Kalina, 2020; I. G. A. Kurniawan & Chandra, 2024) meliputi:

1. Informed consent tersurat

Informed consent tersurat merupakan bentuk persetujuan yang diberikan secara jelas dan eksplisit, biasanya dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga sebagai bukti legal. Bentuk ini digunakan pada tindakan medis atau keperawatan yang berisiko tinggi, prosedur invasif, atau tindakan yang memerlukan pertimbangan khusus. Dokumen *informed consent* tersurat memuat informasi penting seperti diagnosis, tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, risiko dan manfaat, serta alternatif tindakan. Keberadaan dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bukti bahwa proses komunikasi dan pengambilan keputusan telah dilakukan secara etis dan profesional. Informed consent tersirat.

2. Informed consent tersirat

Informed consent tersirat merupakan bentuk persetujuan yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi ditunjukkan melalui tindakan atau sikap pasien yang mengindikasikan kesediaan untuk dilakukan tindakan tertentu. Contohnya, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dan secara sukarela mengikuti pemeriksaan tanpa menunjukkan penolakan dianggap telah memberikan persetujuan tersirat. Bentuk ini umumnya berlaku pada tindakan rutin dengan risiko minimal, seperti pemeriksaan tanda vital atau konsultasi awal. Meskipun tidak tertulis, tenaga kesehatan tetap berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai agar tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip etik dan menghormati hak pasien.

3. Informed consent verbal

Informed consent verbal merupakan persetujuan yang diberikan secara lisan oleh pasien setelah menerima penjelasan dari tenaga kesehatan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Bentuk ini biasanya digunakan pada tindakan

dengan risiko rendah hingga sedang yang tidak memerlukan dokumentasi tertulis secara khusus. Proses komunikasi dalam *informed consent* verbal tetap harus memastikan bahwa pasien memahami informasi yang disampaikan, termasuk tujuan, prosedur, serta kemungkinan risiko. Tenaga kesehatan perlu mendokumentasikan dalam catatan medis bahwa persetujuan telah diberikan secara verbal sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan perlindungan hukum.

4. Perbedaan Inform consent

Perbedaan terletak pada bentuk penyampaian dan kekuatan pembuktian hukum, di mana persetujuan tertulis memiliki kekuatan legal paling kuat, diikuti verbal, dan tersirat.

Tabel 5. 1 Perbedan Infored Consent

Aspek	Informed Consent Tersurat	Informed Consent Tersirat	Informed Consent Verbal
Pengertian	Persetujuan yang dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis	Persetujuan yang ditunjukkan melalui tindakan atau sikap	Persetujuan yang diberikan secara lisan
Bentuk	Tertulis dan ditandatangani	Tidak tertulis, berupa perilaku	Lisan (ucapan pasien)
Kekuatan hukum	Paling kuat sebagai bukti legal	Lemah	Sedang (lebih kuat dari tersirat)
Jenis tindakan	Tindakan berisiko tinggi/invasif	Tindakan rutin/risiko minimal	Tindakan risiko rendah–sedang
Contoh	Operasi, tindakan invasif, prosedur khusus	Pemeriksaan fisik umum, cek tanda vital	Pemasangan infus, pemberian terapi sederhana
Kebutuhan dokumentasi	Wajib dokumen tertulis	Tidak wajib, cukup catatan	Dicatat dalam rekam medis
Proses komunikasi	Lengkap, detail, dan formal	Sederhana	Cukup jelas dan terarah

Aspek	Informed Consent Tersurat	Informed Consent Tersirat	Informed Consent Verbal
Risiko hukum jika tidak dilakukan	Sangat tinggi	Rendah	Sedang

5. Prosedur informed consent dalam tindakan keperawatan

Prosedur *informed consent* dalam tindakan keperawatan merupakan proses sistematis yang diawali dengan pemberian informasi yang lengkap, jelas, dan sesuai kondisi pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Tahap berikutnya melibatkan upaya memastikan pemahaman pasien melalui komunikasi dua arah, termasuk penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas. Pasien kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta mengekspresikan kekhawatiran atau preferensinya. Setelah pasien memahami informasi secara adekuat, persetujuan diperoleh secara sukarela tanpa paksaan. Proses ini diakhiri dengan dokumentasi yang tepat dalam rekam medis sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan bukti legal bahwa *informed consent* telah dilakukan secara etis dan sesuai standar (Firma et al., 2025; Ghartey, 2023).

D. Penolakan Tindakan Medis dan Keperawatan

Penolakan tindakan medis dan keperawatan merupakan bagian dari hak pasien dalam menentukan pilihan terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya. Keputusan untuk menolak tindakan harus dihormati sepanjang memenuhi aspek etik dan hukum, serta didasarkan pada pemahaman yang adekuat terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi.

1. Pengertian dan dasar etik–legal penolakan tindakan

Penolakan tindakan medis dan keperawatan merupakan keputusan pasien atau pihak yang berwenang untuk tidak menerima tindakan yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan setelah memperoleh informasi yang memadai. Keputusan ini merupakan bagian dari proses informed consent yang mencakup hak pasien untuk menerima maupun menolak tindakan berdasarkan pemahaman terhadap manfaat, risiko, dan alternatif yang tersedia. Penolakan tindakan tidak dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan semata, tetapi sebagai

bentuk ekspresi otonomi pasien dalam menentukan pilihan terhadap kesehatan dirinya.

Dasar etik penolakan tindakan berlandaskan pada prinsip otonomi yang menghormati hak individu dalam pengambilan keputusan, serta didukung oleh prinsip veracity dan fidelity yang menuntut tenaga kesehatan untuk jujur dan menjaga kepercayaan pasien. Perspektif hukum mengakui penolakan tindakan sebagai hak pasien selama keputusan tersebut diambil dalam kondisi sadar, kompeten, dan tanpa paksaan. Tenaga kesehatan berkewajiban menghormati keputusan tersebut dengan tetap memastikan bahwa pasien telah menerima informasi yang lengkap serta mendokumentasikan penolakan secara tepat sebagai bagian dari tanggung jawab profesional (Busro, 2018; Mariyani, 2020).

2. Hak pasien untuk menolak tindakan

Hak pasien untuk menolak tindakan medis dan keperawatan merupakan bagian dari hak fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada prinsip otonomi. Pasien memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak tindakan setelah memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatan, tujuan tindakan, manfaat, risiko, serta alternatif yang tersedia. Keputusan ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan integritas individu dalam mengelola kesehatan dirinya.

Hak untuk menolak tindakan tetap berlaku selama pasien berada dalam kondisi sadar dan memiliki kapasitas pengambilan keputusan yang adekuat. Tenaga kesehatan berkewajiban memastikan bahwa pasien memahami konsekuensi dari penolakan tersebut, termasuk potensi perburukan kondisi atau risiko yang mungkin terjadi. Keputusan pasien harus dihormati tanpa adanya tekanan, paksaan, atau manipulasi, serta didokumentasikan secara tepat sebagai bagian dari tanggung jawab etik dan hukum dalam praktik keperawatan (H. D. Kurniawan et al., 2023; Ramadhani, 2024).

3. Penolakan tindakan dalam kondisi sadar dan kompeten

Penolakan tindakan dalam kondisi sadar dan kompeten merupakan keputusan pasien yang memiliki kesadaran penuh serta kapasitas kognitif yang memadai untuk memahami informasi dan mengambil keputusan secara rasional. Kondisi ini mencakup kemampuan pasien untuk menerima informasi, mempertimbangkan manfaat dan risiko, serta mengkomunikasikan pilihan secara jelas. Penolakan yang dilakukan dalam keadaan tersebut dianggap sah secara etik dan hukum karena didasarkan pada prinsip otonomi pasien.

Tenaga kesehatan berkewajiban menghormati keputusan pasien meskipun keputusan tersebut berpotensi memperburuk kondisi kesehatan. Proses penolakan harus didahului dengan pemberian informasi yang lengkap dan jelas,

serta memastikan bahwa pasien benar-benar memahami konsekuensi yang mungkin terjadi. Dokumentasi penolakan menjadi bagian penting untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui proses komunikasi yang adekuat dan profesional (Busro, 2018; H. D. Kurniawan et al., 2023; Mariyani, 2020; Ramadhani, 2024).

4. Penolakan tindakan oleh keluarga atau wali

Penolakan tindakan oleh keluarga atau wali terjadi ketika pasien tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan, seperti pada kondisi tidak sadar, gangguan kognitif, atau usia anak. Dalam situasi ini, keluarga atau wali yang sah secara hukum berperan sebagai pengambil keputusan pengganti (*substitute decision maker*) yang bertanggung jawab menentukan tindakan berdasarkan kepentingan terbaik pasien (*best interest*). Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi klinis, nilai, serta preferensi pasien apabila sebelumnya telah diketahui.

Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami kepada keluarga atau wali sebelum keputusan diambil. Proses komunikasi harus dilakukan secara empatik dan profesional untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pemahaman yang adekuat. Penolakan tindakan oleh keluarga atau wali harus didokumentasikan secara tertulis sebagai bukti legal, serta menjadi bagian dari tanggung jawab etik dan hukum dalam praktik keperawatan.

5. Penolakan tindakan dalam situasi darurat

Penolakan tindakan dalam situasi darurat merupakan kondisi yang kompleks karena melibatkan pertimbangan antara hak pasien dan prinsip keselamatan. Situasi darurat ditandai oleh ancaman terhadap nyawa atau fungsi vital yang memerlukan tindakan segera, sehingga sering kali tidak memungkinkan dilakukannya proses *informed consent* secara optimal. Dalam kondisi ini, apabila pasien tidak sadar atau tidak kompeten, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan prinsip *implied consent* untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Penolakan tindakan tetap dapat terjadi dalam situasi darurat apabila pasien berada dalam kondisi sadar dan kompeten serta secara tegas menyatakan penolakan. Keputusan tersebut harus dihormati sepanjang pasien memahami konsekuensi yang mungkin terjadi. Tenaga kesehatan berkewajiban memberikan penjelasan secara singkat namun jelas mengenai risiko penolakan, serta memastikan bahwa keputusan diambil tanpa paksaan. Dokumentasi yang lengkap menjadi sangat penting dalam situasi ini sebagai bentuk perlindungan

hukum dan bukti bahwa tindakan telah dilakukan sesuai prinsip etik dan profesional.

6. Implikasi hukum dan etik terhadap tenaga keperawatan

Penolakan tindakan medis dan keperawatan memiliki implikasi hukum dan etik yang signifikan bagi tenaga keperawatan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap otonomi pasien dan tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan yang aman. Perawat berkewajiban memastikan bahwa pasien atau keluarga telah menerima informasi yang lengkap, memahami konsekuensi penolakan, serta mengambil keputusan secara sadar dan tanpa paksaan. Kegagalan dalam memberikan informasi yang adekuat atau tidak mendokumentasikan penolakan secara tepat dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Implikasi etik menuntut perawat untuk tetap menunjukkan empati, menghormati keputusan pasien, serta menjaga hubungan terapeutik meskipun terjadi penolakan tindakan. Implikasi hukum menekankan pentingnya dokumentasi yang akurat, termasuk pencatatan proses komunikasi, informasi yang diberikan, serta keputusan pasien atau keluarga. Praktik yang sesuai dengan prinsip etik dan hukum akan melindungi hak pasien sekaligus menjaga keamanan profesional perawat dalam menjalankan pelayanan keperawatan.

E. Pengambilan Keputusan Klinis dalam Keperawatan

1. Konsep dan karakteristik pengambilan keputusan klinis

Pengambilan keputusan klinis merupakan proses kognitif dan profesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan terbaik berdasarkan data klinis, kondisi pasien, serta pertimbangan etik dan ilmiah. Proses ini melibatkan integrasi antara pengetahuan, pengalaman, bukti ilmiah, serta kemampuan berpikir kritis untuk menghasilkan keputusan yang tepat, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Dalam praktik keperawatan, pengambilan keputusan klinis tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan budaya pasien (Bragazzi & Garbarino, 2023; Mertens et al., 2024; Rosa et al., 2024).

Karakteristik pengambilan keputusan klinis meliputi beberapa aspek penting yang mencerminkan kompleksitas proses tersebut, yaitu:

a. Berbasis data dan bukti ilmiah

Keputusan didasarkan pada hasil pengkajian yang akurat serta didukung oleh *evidence-based practice*.

b. Melibatkan berpikir kritis dan analitis

Proses keputusan memerlukan kemampuan menganalisis informasi secara sistematis dan logis.

c. Bersifat dinamis dan adaptif

Keputusan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi pasien yang cepat dan tidak terprediksi.

d. Mempertimbangkan aspek etik dan hukum

Setiap keputusan harus sesuai dengan prinsip etik dan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*)

Prioritas utama adalah meminimalkan risiko dan meningkatkan hasil klinis yang optimal.

Pemahaman terhadap konsep dan karakteristik ini menjadi dasar penting bagi perawat dalam mengambil keputusan klinis yang tepat, terutama dalam situasi kedaruratan dan krisis yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan tanggung jawab profesional.

2. Model pengambilan keputusan klinis keperawatan

Model pengambilan keputusan klinis keperawatan merupakan kerangka sistematis yang digunakan perawat dalam menentukan tindakan berdasarkan data pasien, pertimbangan ilmiah, serta aspek etik dan profesional. Penggunaan model ini membantu perawat berpikir secara terstruktur, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat linear, tetapi juga dapat bersifat dinamis sesuai dengan perubahan kondisi pasien (Bragazzi & Garbarino, 2023; Mertens et al., 2024; Rosa et al., 2024).

Model pengambilan keputusan klinis keperawatan meliputi:

a. Model proses keperawatan (*nursing process*)

Model ini terdiri dari tahap pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang digunakan sebagai dasar sistematis dalam pengambilan keputusan.

b. Model berpikir kritis (*clinical reasoning*)

Model ini menekankan kemampuan analisis, interpretasi data, serta pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kondisi pasien.

c. Model evidence-based practice

Keputusan diambil berdasarkan integrasi antara bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta nilai dan preferensi pasien.

d. Model intuitif (intuition-based decision making)

Model ini didasarkan pada pengalaman klinis yang memungkinkan perawat mengenali pola kondisi pasien secara cepat, terutama dalam situasi krisis.

e. Model kolaboratif

Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dengan tim kesehatan lain untuk memastikan keputusan yang komprehensif dan tepat.

Pemahaman terhadap berbagai model ini membantu perawat memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi klinis, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

3. Pengambilan keputusan berbasis etik dan hukum

Pengambilan keputusan berbasis etik dan hukum merupakan proses menentukan tindakan klinis yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ilmiah dan kondisi pasien, tetapi juga berlandaskan pada prinsip etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini menuntut perawat untuk mampu menyeimbangkan antara kepentingan pasien, tanggung jawab profesional, serta norma hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan penghormatan terhadap hak pasien sekaligus menjaga keselamatan dan kualitas pelayanan.

Pengambilan keputusan berbasis etik dan hukum melibatkan beberapa pertimbangan utama, yaitu:

a. Prinsip etik keperawatan

Keputusan harus berlandaskan prinsip otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, keadilan, serta *veracity* dan *fidelity*.

b. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum kesehatan

Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan standar praktik, prosedur operasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perlindungan hak pasien

Keputusan harus menjamin hak pasien untuk memperoleh informasi, memberikan persetujuan, serta menentukan pilihan terhadap tindakan kesehatan.

d. Akuntabilitas dan tanggung jawab profesional

Perawat harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil secara etik dan hukum, termasuk melalui dokumentasi yang tepat.

e. Pertimbangan situasional dan konteks klinis

Keputusan harus disesuaikan dengan kondisi pasien, situasi kedaruratan, serta dinamika lingkungan pelayanan kesehatan.

Pemahaman terhadap pengambilan keputusan berbasis etik dan hukum menjadi sangat penting dalam praktik keperawatan, terutama dalam situasi

kompleks seperti krisis dan kedaruratan yang memerlukan ketepatan, kecepatan, serta pertimbangan profesional yang matang.

4. Peran penalaran klinis (clinical reasoning) dan berpikir kritis

Penalaran klinis (clinical reasoning) dan berpikir kritis merupakan komponen utama dalam pengambilan keputusan keperawatan yang efektif dan aman. Penalaran klinis mengacu pada proses mental dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan data pasien untuk memahami kondisi klinis secara menyeluruh. Berpikir kritis mendukung proses tersebut melalui kemampuan menganalisis informasi secara logis, mengevaluasi alternatif tindakan, serta membuat keputusan yang rasional dan tepat. Kombinasi keduanya memungkinkan perawat menghasilkan keputusan yang berbasis bukti, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Peran penalaran klinis dan berpikir kritis dalam praktik keperawatan meliputi:

a. Menginterpretasikan data klinis secara akurat

Perawat mampu mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil pengkajian yang relevan dan valid.

b. Mengidentifikasi prioritas masalah

Penentuan masalah utama dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan risiko terhadap keselamatan pasien.

c. Menentukan alternatif tindakan yang tepat

Perawat mempertimbangkan berbagai pilihan intervensi berdasarkan bukti ilmiah dan kondisi pasien.

d. Mengevaluasi hasil dan menyesuaikan keputusan

Keputusan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan sesuai respons pasien terhadap tindakan yang diberikan.

e. Mengintegrasikan aspek etik dan komunikasi

Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan nilai pasien, komunikasi efektif, serta prinsip etik dalam pelayanan kesehatan.

Pemahaman dan penguatan penalaran klinis serta berpikir kritis menjadi sangat penting, terutama dalam situasi kedaruratan dan krisis yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan tanggung jawab profesional dalam setiap keputusan yang diambil.

5. Kolaborasi interprofesional dalam pengambilan keputusan

Kolaborasi interprofesional dalam pengambilan keputusan merupakan proses kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan, seperti perawat, dokter, apoteker, dan profesi lainnya, dalam menentukan tindakan terbaik bagi pasien. Proses ini bertujuan menghasilkan keputusan yang komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan, sehingga meningkatkan kualitas

pelayanan dan keselamatan pasien. Kolaborasi tidak hanya berfokus pada pertukaran informasi, tetapi juga pada koordinasi, komunikasi efektif, serta saling menghargai peran masing-masing profesi.

Kolaborasi interprofesional dalam pengambilan keputusan meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

a. Komunikasi yang efektif dan terstruktur

Informasi disampaikan secara jelas, akurat, dan sistematis untuk menghindari miskomunikasi.

b. Koordinasi antar profesi

Setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pengambilan keputusan.

c. Pengambilan keputusan bersama (*shared decision making*)

Keputusan dihasilkan melalui diskusi tim dengan mempertimbangkan kondisi pasien, bukti ilmiah, serta nilai pasien.

d. Penghargaan terhadap peran profesional

Setiap profesi dihargai kontribusinya sehingga tercipta kerja sama yang harmonis.

e. Fokus pada keselamatan pasien (*patient safety*)

Seluruh keputusan diarahkan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan hasil klinis pasien.

Pemahaman terhadap kolaborasi interprofesional menjadi penting dalam praktik keperawatan, terutama dalam situasi kompleks seperti kedaruratan dan krisis yang memerlukan koordinasi cepat, tepat, dan efektif antar tenaga kesehatan.

F. Dilema Etik dalam Informed Consent dan Penolakan Tindakan

Dilema etik dalam *informed consent* dan penolakan tindakan muncul ketika terjadi konflik antara prinsip-prinsip etik, kondisi klinis, serta keputusan pasien atau keluarga dalam pelayanan kesehatan. Situasi ini sering melibatkan ketegangan antara penghormatan terhadap otonomi pasien dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan manfaat dan mencegah bahaya. Perawat dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga sensitif terhadap aspek etik, hukum, dan nilai yang dianut pasien.

Dilema etik dalam *informed consent* dan penolakan tindakan meliputi:

1. Konflik antara otonomi dan *beneficence*

Pasien memiliki hak untuk menolak tindakan, namun tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan tindakan terbaik demi keselamatan pasien.

2. Ketidakmampuan pasien dalam mengambil keputusan
Kondisi seperti penurunan kesadaran atau gangguan kognitif menimbulkan dilema dalam menentukan pihak yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan.
3. Perbedaan nilai antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan
Perbedaan keyakinan, budaya, atau persepsi terhadap penyakit dan pengobatan dapat memicu konflik dalam pengambilan keputusan.
4. Penolakan tindakan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pasien
Keputusan pasien yang menolak tindakan penting dapat menimbulkan konsekuensi serius, sehingga perawat menghadapi dilema antara menghormati keputusan dan mencegah bahaya.
5. Keterbatasan waktu dalam situasi darurat
Situasi krisis sering tidak memungkinkan proses *informed consent* dilakukan secara optimal, sehingga menuntut keputusan cepat dengan pertimbangan etik yang kompleks.

Pengelolaan dilema etik memerlukan pendekatan yang sistematis melalui komunikasi efektif, refleksi etik, serta kolaborasi interprofesional. Perawat perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap menghormati hak pasien, didukung oleh informasi yang adekuat, serta sesuai dengan prinsip etik dan ketentuan hukum. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan pasien dan tanggung jawab profesional dalam praktik keperawatan (Afenigus & Sinshaw, 2025; Godskesen, 2025; Godskesen et al., 2023).

G. Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Perawat

Aspek hukum dalam praktik keperawatan merupakan landasan yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta batasan tindakan perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Praktik keperawatan tidak hanya berorientasi pada aspek klinis, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan. Tanggung jawab perawat mencakup kewajiban memberikan asuhan yang aman, kompeten, dan sesuai standar, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan secara etik dan hukum.

Aspek hukum dan tanggung jawab perawat meliputi:

1. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar praktik
Perawat wajib menjalankan praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar profesi, serta prosedur operasional yang berlaku.

2. Kewenangan dan batas praktik keperawatan
Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan profesional, serta tidak melampaui batas praktik yang ditetapkan.
3. Akuntabilitas dan tanggung jawab profesional
Perawat bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam pemberian asuhan keperawatan.
4. Perlindungan hak pasien
Perawat berkewajiban menjaga hak pasien, termasuk hak atas informasi, privasi, kerahasiaan, serta persetujuan tindakan (*informed consent*).
5. Dokumentasi sebagai bukti hukum
Pencatatan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dalam rekam medis menjadi bukti legal yang penting dalam praktik keperawatan.
6. Pencegahan risiko hukum dan malpraktik
Perawat perlu menerapkan praktik berbasis standar, komunikasi efektif, serta kehati-hatian untuk menghindari kesalahan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Pemahaman terhadap aspek hukum dan tanggung jawab perawat menjadi penting dalam mendukung praktik keperawatan yang aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Implementasi yang tepat tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktiknya (Afenigus & Sinshaw, 2025; Godskesen, 2025; Godskesen et al., 2023).

Aktivitas 1

Mini-case

Seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis gagal ginjal kronis. Dokter merencanakan tindakan hemodialisis karena kondisi pasien menunjukkan peningkatan kadar ureum dan kreatinin serta penurunan kesadaran.

Perawat telah memberikan penjelasan awal mengenai prosedur hemodialisis, manfaat, dan risiko yang mungkin terjadi. Pasien dalam kondisi sadar dan mampu berkomunikasi, namun menyatakan menolak tindakan tersebut karena merasa takut dan memiliki keyakinan bahwa kondisinya akan membaik tanpa tindakan.

Keluarga pasien mendukung tindakan hemodialisis dan meminta perawat untuk tetap melanjutkan tindakan meskipun pasien menolak.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Pasien sadar, orientasi baik
- Pasien tampak cemas dan takut
- Keluarga terlihat mendesak agar tindakan dilakukan
- Tidak terdapat gangguan kognitif pada pasien

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi aspek *informed consent* yang muncul dalam kasus tersebut.
2. Analisis keabsahan penolakan tindakan oleh pasien berdasarkan aspek etik dan hukum.
3. Jelaskan konflik yang terjadi antara pasien dan keluarga.
4. Tentukan keputusan klinis yang tepat yang harus dilakukan oleh perawat.
5. Uraikan peran perawat dalam memberikan edukasi dan klarifikasi pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2

Mini-case tertulis

Seorang pasien perempuan berusia 45 tahun dibawa ke instalasi gawat darurat dalam kondisi tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perdarahan internal dan pasien memerlukan tindakan operasi segera untuk menyelamatkan nyawa.

Keluarga pasien belum tiba di rumah sakit, dan tidak ada dokumen persetujuan sebelumnya. Tim kesehatan menghadapi dilema untuk segera melakukan tindakan atau menunggu persetujuan keluarga.

Perawat yang bertugas harus segera berkoordinasi dengan tim medis dan mempertimbangkan aspek etik, hukum, serta keselamatan pasien dalam situasi tersebut.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Pasien tidak sadar (GCS rendah)
- Tanda vital tidak stabil
- Tidak ada keluarga atau wali yang dapat dihubungi saat itu
- Tindakan operasi bersifat emergensi

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi prinsip *informed consent* yang berlaku dalam situasi darurat pada kasus tersebut.
2. Jelaskan dasar etik dan hukum dalam pengambilan keputusan tanpa persetujuan pasien.
3. Analisis peran perawat dalam pengambilan keputusan klinis pada kondisi tersebut.
4. Tentukan tindakan yang harus dilakukan oleh tim kesehatan.
5. Jelaskan pentingnya dokumentasi dalam kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

FORM PENILAIAN MAHASISWA

Aktivitas Problem Based Learning (PBL)

Topik: *Informed Consent, Penolakan Tindakan, dan Pengambilan Keputusan Klinis*

Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa :

NIM :

Kelompok :

Tanggal :

Penguji/Dosen :

A. PENILAIAN AKTIVITAS 1

Kasus: *Informed Consent dan Penolakan Tindakan*

No	Aspek Penilaian	Skor (1–4)	Nilai
1	Identifikasi konsep informed consent		
2	Analisis keabsahan penolakan (etik–legal)		
3	Identifikasi konflik pasien–keluarga		
4	Pengambilan keputusan klinis		
5	Peran perawat (edukasi & advokasi)		
6	Partisipasi dalam diskusi		
	Total Skor		

B. PENILAIAN AKTIVITAS 2

Kasus: *Pengambilan Keputusan Klinis dalam Situasi Darurat*

No	Aspek Penilaian	Skor (1–4)	Nilai
1	Identifikasi prinsip informed consent darurat		
2	Analisis dasar etik dan hukum		
3	Analisis peran perawat		
4	Pengambilan keputusan klinis		
5	Analisis pentingnya dokumentasi		
6	Partisipasi dalam diskusi		
	Total Skor		

C. REKAP NILAI AKHIR

Komponen	Skor Maksimal	Skor Diperoleh
Aktivitas 1	24	
Aktivitas 2	24	
Total	48	

Perhitungan Nilai Akhir:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total Skor}}{48} \times 100$$

D. KATEGORI PENILAIAN

Rentang Nilai	Kategori
≥ 85	Sangat Kompeten
70–84	Kompeten
60–69	Cukup Kompeten
< 60	Belum Kompeten

RUBRIK PENILAIAN AKTIVITAS 1**Kasus: Informed Consent dan Penolakan Tindakan**

Aspek Penilaian	1 (Tidak Kompeten)	2 (Kurang Kompeten)	3 (Kompeten)	4 (Sangat Kompeten)
Identifikasi konsep informed consent	Tidak mampu mengidentifikasi	Sebagian tidak tepat	Tepat	Lengkap dan mendalam
Analisis keabsahan penolakan	Tidak sesuai aspek etik–legal	Kurang tepat	Tepat	Sangat komprehensif (etik & hukum)
Identifikasi konflik pasien–keluarga	Tidak mampu	Kurang jelas	Jelas	Mendalam dan kontekstual
Pengambilan keputusan klinis	Tidak tepat	Kurang sesuai	Tepat	Tepat, logis, dan profesional
Peran perawat (edukasi & advokasi)	Tidak dijelaskan	Kurang jelas	Jelas	Sangat jelas, empatik, dan aplikatif
Partisipasi diskusi	Pasif	Terbatas	Aktif	Sangat aktif dan kolaboratif

RUBRIK PENILAIAN AKTIVITAS 2

Kasus: Pengambilan Keputusan Klinis dalam Situasi Darurat

Aspek Penilaian	1 (Tidak Kompeten)	2 (Kurang Kompeten)	3 (Kompeten)	4 (Sangat Kompeten)
Identifikasi prinsip informed consent darurat	Tidak tepat	Kurang lengkap	Tepat	Lengkap dan kritis
Analisis dasar etik dan hukum	Tidak mampu	Kurang tepat	Tepat	Komprehensif dan sistematis
Analisis peran perawat	Tidak jelas	Kurang tepat	Jelas	Sangat jelas dan profesional
Pengambilan keputusan klinis	Tidak tepat	Kurang sesuai	Tepat	Cepat, tepat, dan berbasis keselamatan
Analisis pentingnya dokumentasi	Tidak dijelaskan	Kurang tepat	Tepat	Mendalam dan aplikatif
Partisipasi diskusi	Pasif	Terbatas	Aktif	Sangat aktif dan kolaboratif

PANDUAN PENILAIAN

- Skor tiap aspek: **1–4**
- Nilai akhir:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total skor diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

INTERPRETASI NILAI

Nilai	Kategori
≥ 85	Sangat Kompeten
70–84	Kompeten
60–69	Cukup Kompeten
< 60	Belum Kompeten

Referensi

- Afenigus, A. D., & Sinshaw, M. A. (2025). Ethical dilemmas and decision-making in emergency and critical care nursing in Western Amhara region , Northwest Ethiopia : a multi-method qualitative study. *BMC Nursing*.
- Basukala, S., Id, O. S., Thapa, N., Karki, S., & Pandit, A. (2023). How informed is informed consent ?— Evaluating the quality of informed consent among surgical patients in a tertiary care hospital in Nepal. *PLoS ONE*, 1–10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288074>
- Bragazzi, N., & Garbarino, S. (2023). Towards Clinical Generative Artificial Intelligence : Conceptual Framework Table of Contents. *JMR Publications*.
- Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law & Justice Journal, November, 1*(1), 1–18.
- Ediit. (2022). Keys to improving the informed consent process in research : Highlights of the i - CONSENT project. *Wiley*, 1183–1185. <https://doi.org/10.1111/hex.13427>
- Firma, F. R., Jusri, E., & Sapsudin, A. (2025). Legal Safeguard in Healthcare : Perspectives from. *Research Horizon, 0696*.
- Ghartey, A. F. (2023). A Systematic Review Of Patient Perspective On The Informed Consent Doctrine: Ethical And Legal Reflections Alexander Fiifi Ghartey 1. *UCC Law Journal, 3*(1), 32–56. <https://doi.org/10.47963/ucclj.v3i1.1250>
- Giacobello, M. L., & Marcos, A. (2025). Informed consent and bioethical advances in clinical settings. *Frontiers in Psychiatry, September*, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1654586>
- Godskesen, T. (2025). Ethical re fl ections of healthcare staff on ‘ consentless measures ’ in somatic care: A qualitative study. *Nursing Ethics*. <https://doi.org/10.1177/09697330251328649>
- Godskesen, T., Björk, J., & Juth, N. (2023). Challenges regarding informed consent in recruitment to clinical research : a qualitative study of clinical research nurses ’ experiences. *Trials*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13063-023-07844-6>
- Kalina, P. (2020). Ethical and Legal Manifestations of Informed Consent. *Technium Social Sciences Journal, 8*.
- Kristin, M., Melanie, T., Alice, S., Matthias, M., & Georg, T. (2022). Struggling with extensive informed consent procedures for cancer trials — is there even a benefit for the patients? *Supportive Care in Cancer*, 6593–6602. <https://doi.org/10.1007/s00520-022-07063-w>
- Kurniawan, H. D., Hartono, M., Ismandani, R. S., Studi, P., Administrasi, S., Sakit, R.,

- Tinggi, S., Kosala, K. P., Tengah, J., Kosala, P., & Tengah, J. (2023). HUBUNGAN PEMBERIAN INFORMED CONSENT PRAOPERASI DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI RUMAH SAKIT Dr . OEN KANDANG SAPI SOLO Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Program Studi Diploma III Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan . *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 75–84.
- Kurniawan, I. G. A., & Chandra, A. (2024). The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Procedures. *Sasi*, 30(3), 326–338.
- Lawongsa, K. (2025). Avoiding Deception and Nondisclosure in Clinical Practice : A Narrative Review of Ethical Principles , Legal Perspectives , and Communication Strategies. *Cureus*, 17(9), 1–10. <https://doi.org/10.7759/cureus.92424>
- Leclercq, W. K. G., Keulers, B. J., Houterman, S., Veerman, M., Legemaate, J., & Scheltinga, M. R. (2013). A survey of the current practice of the informed consent process in general surgery in the Netherlands. *Patient Safety In Surgery*, 1–7.
- Mariyani, Y. R. D. (2020). *Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section*. Viii, 188–198.
- Mertens, J. F., Kempen, T. G. H., Koster, E. S., Deneer, V. H. M., Bouvy, M. L., & Gelder, T. Van. (2024). Cognitive processes in pharmacists ' clinical decision-making Version : License : Downloaded from : Publisher ' s Version Research in Social and Administrative Pharmacy Cognitive processes in pharmacists ' clinical decision-making. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 20(2), 105–114. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2023.10.007>
- Negash, T. T. (2020). The Practice of Obtaining Informed Consent for Elective Surgery and Anesthesia from Patients ' Perspective : An Institutional based Cross-Sectional Study. *Research Square*, 1–13.
- Pallocci, M., Treglia, M., Passalacqua, P., Tittarelli, R., Zanovello, C., Luca, L. De, Caparrelli, V., Luna, V. De, Cisterna, A. M., Quintavalle, G., & Marsella, L. T. (2023). Informed Consent : Legal Obligation or Cornerstone of the Care Relationship ? *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Ramadhani, A. E. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian. *Syntax Admiration*, 5(7).
- Rosa, D., Villa, G., Amigoni, C., Maria, A., Guberti, M., Ghirotto, L., & Fiorenzo, D. (2024). MethodsX Role of emotions in the clinical decision-making process of the hospital nurse : A multicentre qualitative study. *MethodsX*, 12(January), 102590. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.102590>

- Varkey, B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 17–28. <https://doi.org/10.1159/000509119>
- Wong, V., Hassan, N., & Wong, Y. P. (2025). Nurses ' adherence to ethical principles – A qualitative study. *Nursing Ethics*. <https://doi.org/10.1177/09697330241291159>

Profil Penulis



Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes.

Lahir di Pomalaa, tanggal 22 Januari 1973 (Kab. Kolaka- Sulawesi Tenggara). Riwayat Pendidikan ; Akademi Perawatan Ujung Pandang Depkes. RI, tahun 1991-1994. Melanjutkan pendidikan pada D.IV Perawat Pendidik Universitas Hasanuddin (UNHAS). Melanjutkan Program Pasca Sarjana (PPS) UNHAS, bidang Promosi Kesehatan, tahun 2004-2006 dan Menyelesaikan Program Doktor Kajian Sosiologi Kesehatan, tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar (UNM). Riwayat pekerjaan: Guru Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemda Luwu, tahun 1995-1999. Menjadi Dosen DPK pada AKPER Sawerigading Pemda Luwu (ASPL), yang saat ini telah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kamus Arunika, dari tahun 2000-sekarang. Riwayat tugas tambahan : Ketua Prodi D.III Keperawatan ASPL, tahun 2006- 2011. Wakil Direktur bidang Akademik ASPL 2011-2020. Kepala LPM tahun 2021-2024. Saat ini, Dosen aktif dan Ketua LPPM di STIKES Kamus Arunika Palopo, mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Antropologi Kesehatan, Promosi Kesehatan, Metodologi Keperawatan dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Beberapa publikasi penelitian antara lain; jurnal inter- nasional dan bereputasi internasional, serta jurnal nasional dan terakreditasi. Penulis menekuni bidang penelitian terkait lansia dalam perspektif sosial dan kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rjusmadi133@gmail.com

Profil Penulis



Dr. Khotibul Umam, S.Kep.Ns.,M.Kes

lahir di Lamongan Jawa Timur, Putra dari Bpk. H.M.Rofi' Anwar dan Ibu Cholifah, Penulis menempuh pendidikan formal mulai SD lulus tahun 1986, SMP lulus Tahun 1989, SMA lulus tahun 1992, SPK Pemda Tk II Lamongan lulus tahun 1995, DIII Keperawatan lulus tahun 2003, S1 Keperawatan- Ners Universitas Airlangga lulus tahun 2006/2007, S2 Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2013.

Penulis memulai karir sebagai Perawat Pelaksana di Puskesmas Sukodadi tahun 1998 - 2000, kemudian menjadi staf dinas Kesehatan Lamongan tahun 2000-2003. Setelah lulus Pendidikan Ners tahun 2007 penulis mulai mengabdikan diri sebagai staf pengajar di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai tahun 2017. Adanya proses merger ke Universitas Airlangga maka penulis bergabung menjadi dosen di universitas Airlangga mulai bulan Januari tahun 2018 sampai saat ini.

Penulis juga aktif di organisasi profesi (PPNI), pernah menjabat sebagai ketua DPK PPNI Lamongan 1, penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPD PPNI Kabupaten Lamongan periode 2022-2027. Penulis saat ini sudah lulus Pendidikan Doktoral di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga pada awal tahun 2025.

Profil Penulis



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep

lahir di Malaka pada 27 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang ditempuh diawali di Akademi Keperawatan Kupang dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep.) dan Profesi Ners (Ns.) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya, dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Penulis kemudian meraih gelar Magister Keperawatan (M.Kep.) di Universitas Airlangga pada tahun 2010. Pendidikan formal tertinggi diselesaikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada tahun 2023. Karier profesional penulis diawali sebagai perawat sekaligus dosen di Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (PAM-KT) Dili, Timor Timur, pada periode 1996–1998. Sejak bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Jurusan Keperawatan dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Profesi Ners. Di samping aktivitas akademik, penulis aktif dalam organisasi profesi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Kolegium Keperawatan Indonesia, serta anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI). Dalam bidang pendidikan, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Falsafah dan Teori Keperawatan, Komunikasi dalam Keperawatan, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan, Caring, Etika Keperawatan, Metodologi Penelitian, Evidence-Based Nursing, dan Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif membimbing mahasiswa pada penyusunan tugas akhir, karya ilmiah, dan penelitian di bidang keperawatan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penulis telah menghasilkan sejumlah buku ajar dan book chapter di bidang keperawatan, menjadi narasumber dalam seminar, pelatihan, dan workshop ilmiah, serta berperan sebagai reviewer pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Bidang keilmuan yang menjadi fokus penulis meliputi pengembangan model praktik keperawatan berbasis caring, etik dan budaya, pendidikan keperawatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian tuberkulosis, mutu dan keselamatan pasien di RS.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aemilianusmau58@gmail.com.

Motto: "Terus Belajar agar Ilmunya Dapat Bermanfaat bagi orang lain"

Profil Penulis



Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep, Ns.Sp.Kep.Kom.

Associate Professor di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sejak tahun 2024. Lahir di Tasikmalaya, 7 Juli 1976. Penulis merupakan seorang istri dari Dr. Ir. Yadi Nurhayadi, M.Si., CDAI dan seorang ibu dari Khazanah Fadhilah Nurrahmah, S.Si dan Hiradini Rahmah, ST. Pendidikan Program Sarjana (S1) Keperawatan diselesaikan dari PSIK-FK Universitas Padjadjaran (2000), Program Pasca Sarjana & Spesialis Keperawatan Komunitas (2010) serta Doktor Ilmu Keperawatan (2022) diselesaikan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saat ini sebagai Editor in Chief JKEP (Jurnal Keperawatan) Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Pengalaman organisasinya sebagai Sekretaris Pengurus Pusat IPEGGERI (Ikatan Perawat Gerontik Indonesia) PPNI (2019-2024) dan berlanjut sebagai tim Departemen Pengembangan, Humas dan Kerjasama (2024-2029). Juga sebagai Koordinator Wilayah ALZI (Alzheimer Indonesia) Chapter Bekasi sejak tahun 2020. Penghargaan telah diraih sebagai Juara I Nasional Lomba Prestasi Publikasi Dosen Vokasi Keperawatan Kategori Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023 (AIPViKI); mendapat beasiswa penelitian Fellowship Postdoctoral dari Praboromarajchanok Institute, MOPH Thailand & University of Michigan (2023-2026); dan penghargaan internasional sebagai Finalist Innovation of the year: Technology Dementia Care "13th Eldercare Innovation Award 2025" with Kedusia-RSM application based on android to preventing dementia for older people and their family (Install Aplikasi Kedusia-RSM di Playstore). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maryam.rd76@gmail.com

Profil Penulis



Dr. Wahyu Endang Setyowati, S.KM., M.Kep

Penulis merupakan akademisi di bidang keperawatan Pendidikan Diploma III Keperawatan di AKPER Muhammadiyah Semarang, pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di Universitas Diponegoro, pendidikan Magister (S2) Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan Pendidikan Doktor Keperawatan (S3) di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga lulus tahun 2024. Penulis berafiliasi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Indonesia. Pengalaman mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa dan Komunikasi Keperawatan. Pengalaman akademik dan manajerial meliputi posisi sebagai Ketua Program Studi DIII Keperawatan, Wakil Dekan III, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Aktivitas organisasi profesional meliputi keanggotaan dan kepengurusan dalam Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) serta Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVIKI) pada tingkat regional dan nasional sebagai Pengurus AIPVIKI Pusat dengan peran sebagai Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri. Kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah mencakup jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi Scopus. Topik penelitian meliputi keperawatan jiwa, komunikasi keperawatan, pemberdayaan keluarga, serta isu kesehatan psikososial seperti bullying dan kesehatan mental. Publikasi ilmiah telah terindeks pada basis data internasional dan disertai dengan karya Hak Kekayaan Intelektual di bidang edukasi kesehatan. Penulis juga aktif sebagai Tim Trainer Service Excellent serta Konsultan Komunikasi Efektif dalam berbagai kegiatan pelatihan, dan aktif sebagai Konselor Bullying. Kontribusi dalam Tridharma Perguruan Tinggi diwujudkan melalui keterlibatan dalam konferensi nasional dan internasional serta pelatihan profesional, termasuk sertifikasi komunikasi efektif. Penulis juga merupakan penulis buku dan modul bermain berbasis keyakinan atau *Health Belief Model*, serta pencipta dan inisiator permainan edukatif ular tangga anti bullying berbasis keyakinan pada anak usia sekolah.

Penulis dapat dihubungi melalui email: wahyu.endang@unissula.ac.id.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1900-9836>

SINTA ID: 6662913

Scopus ID: 57222710265

Web of Science ID: PAU-7782-2025

Sinopsis

Buku Ajar *Etik dan Hukum Keperawatan* disusun sebagai bahan pembelajaran yang membahas dasar-dasar etika, moral, hukum, serta tanggung jawab profesional perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Buku ini hadir untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami bahwa praktik keperawatan tidak hanya berlandaskan keterampilan klinis, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan nilai kemanusiaan, prinsip etik, ketentuan hukum, serta standar profesi yang berlaku.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pengantar etik dan hukum keperawatan yang menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab perawat dalam setiap tindakan pelayanan. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep nilai, moral, etika, serta teori-teori etika yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di praktik keperawatan. Materi tersebut menjadi fondasi penting agar mahasiswa mampu memahami persoalan etik secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab.

Buku ini juga membahas prinsip-prinsip etik keperawatan, meliputi *autonomy*, *beneficence*, *nonmaleficence*, *justice*, *veracity*, dan *fidelity*. Setiap prinsip dijelaskan dalam konteks pelayanan keperawatan sehingga pembaca dapat memahami penerapannya dalam hubungan antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Selain itu, buku ini mengulas hak dan kewajiban pasien serta perawat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bermartabat.

Pada bagian akhir, buku ini membahas *informed consent*, penolakan tindakan, serta pengambilan keputusan klinis dalam praktik keperawatan. Pembahasan ini penting untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami aspek hukum dan etik dalam persetujuan tindakan, menghormati keputusan pasien, serta menjalankan praktik keperawatan sesuai kewenangan dan standar profesional.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi keperawatan dalam memahami hubungan antara etik, hukum, profesionalisme, dan keselamatan pasien. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu mengembangkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan praktik keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Buku Ajar Etik dan Hukum Keperawatan disusun sebagai bahan pembelajaran yang membahas dasar-dasar etika, moral, hukum, serta tanggung jawab profesional perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Buku ini hadir untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami bahwa praktik keperawatan tidak hanya berlandaskan keterampilan klinis, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan nilai kemanusiaan, prinsip etik, ketentuan hukum, serta standar profesi yang berlaku.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pengantar etik dan hukum keperawatan yang menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab perawat dalam setiap tindakan pelayanan. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep nilai, moral, etika, serta teori-teori etika yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di praktik keperawatan. Materi tersebut menjadi fondasi penting agar mahasiswa mampu memahami persoalan etik secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab.

Buku ini juga membahas prinsip-prinsip etik keperawatan, meliputi autonomy, beneficence, nonmaleficence, justice, veracity, dan fidelity. Setiap prinsip dijelaskan dalam konteks pelayanan keperawatan sehingga pembaca dapat memahami penerapannya dalam hubungan antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Selain itu, buku ini mengulas hak dan kewajiban pasien serta perawat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bermartabat.

Pada bagian akhir, buku ini membahas informed consent, penolakan tindakan, serta pengambilan keputusan klinis dalam praktik keperawatan. Pembahasan ini penting untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami aspek hukum dan etik dalam persetujuan tindakan, menghormati keputusan pasien, serta menjalankan praktik keperawatan sesuai kewenangan dan standar profesional. Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi keperawatan dalam memahami hubungan antara etik, hukum, profesionalisme, dan keselamatan pasien. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu mengembangkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan praktik keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-31-6 (PDF)



9

786347

927316

